

GABARITO COMENTADO

Diagnóstico Institucional — MEDICINA

Contém o comentário de cada alternativa e resumo (TLDR) por questão.

GABARITO OFICIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	A	B	A	B	A	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	B	B	D	B	B	B	C	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	A	A	B	A	A	A	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	A	C	C	B	D	B	C	C	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	B	A	B	B	B	B	B	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	A	A	A	B	B	B	C	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	A	A	B	C	B	B	B	C	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	D	A	A	C	C	A	C	B	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	C	B	B	A	A	B	C	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	A	B	D	B	B	B	A	A	A

I. Clínica Médica

QUESTÃO 1 ■ Clínica Médica ■ HIV/AIDS ■ Gabarito: B

Homem de 32 anos, cisgênero, homossexual, comparece à Unidade Básica de Saúde para avaliação. Está em uso de PrEP diária há 18 meses, com boa adesão documentada. Relata parceiro fixo há 8 meses, soropositivo para HIV, em uso regular de terapia antirretroviral com carga viral indetectável nos últimos 12 meses. Nega relações sexuais com outros parceiros ou uso de drogas injetáveis. Exames de acompanhamento: anti-HIV não reagente, função renal normal, VDRL não reagente. Solicita suspensão da PrEP alegando que o tratamento do parceiro já oferece proteção suficiente. Considerando as evidências atuais, qual a conduta mais adequada?

- (A) Manter a PrEP diária obrigatoriamente, pois o conceito I=I não se aplica a casais de homens que fazem sexo com homens.
- (B) ✓ **Aceitar a suspensão da PrEP com orientações sobre monitoramento, retorno semestral e retomada imediata caso haja mudança no padrão de comportamento.**
- (C) Orientar sobre a possibilidade de transição para PrEP sob demanda (2+1+1), respeitando sua autonomia e mantendo proteção adicional.
- (D) Encaminhar ao infectologista para suspensão da PrEP, pois essa decisão não compete ao médico da atenção primária.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa contém uma afirmação factualmente errada. O conceito I=I (Indetectável = Intransmissível) **se aplica universalmente**, incluindo casais de homens que fazem sexo com homens. Na verdade, os estudos PARTNER2 (Rodger et al., 2019) e Opposites Attract (Bavinton et al., 2018) focaram especificamente nessa população e demonstraram **zero transmissões** em dezenas de milhares de atos sexuais desprotegidos quando o parceiro HIV+ mantinha carga viral indetectável. Portanto, manter a PrEP "obrigatoriamente" com base nessa justificativa incorreta não é a conduta adequada.

(B) ✓ **CORRETA** - Esta é a conduta mais adequada baseada nas evidências atuais. O paciente está em parceria sorodiscordante monogâmica com parceiro em supressão viral sustentada há mais de 12 meses, o que caracteriza a aplicação do conceito I=I (Indetectável = Intransmissível). Estudos como o PARTNER e PARTNER2 demonstraram zero transmissões em casais sorodiscordantes quando o parceiro HIV+ mantém carga viral indetectável. Neste contexto de baixo risco real, a suspensão da PrEP é uma opção segura e respaldada pelo PCDT do MS. O acompanhamento semestral garante reavaliação do contexto de vulnerabilidade e possibilita retomada rápida caso necessário.

(C) ✗ **INCORRETA** - Embora a PrEP sob demanda seja uma opção válida para alguns pacientes, ela não é a mais adequada neste caso específico. O esquema 2+1+1 exige planejamento das relações sexuais e tomada de comprimidos em horários específicos, o que adiciona complexidade desnecessária para um casal monogâmico em relacionamento estável. Além disso, em um contexto onde o parceiro HIV+ mantém carga viral indetectável de forma sustentada (I=I), a proteção adicional da PrEP sob demanda oferece benefício marginal com complexidade aumentada. A suspensão com acompanhamento é mais adequada.

(D) ✗ **INCORRETA** - O manejo da PrEP, incluindo prescrição, acompanhamento, transição entre modalidades e suspensão, **é competência da atenção primária à saúde**. Encaminhar ao infectologista para uma decisão que pode perfeitamente ser tomada na APS representa burocratização desnecessária do cuidado e vai contra as diretrizes de descentralização e capilarização da prevenção combinada ao HIV. O médico da APS está plenamente habilitado a conduzir esse caso.

RESUMO (TLDR)

PrEP e Decisão Compartilhada: O Essencial

Conceito I=I: Carga viral indetectável há ≥6 meses = zero transmissão sexual (estudos PARTNER, Opposites Attract).

1. Quando Flexibilizar a PrEP?

- Parceria sorodiscordante estável com I=I
- Mudança no contexto de vulnerabilidade
- Desejo informado do paciente

2. PrEP Sob Demanda (2+1+1)

- **Elegíveis:** Homens cis, não binários (masculino), trans femininas SEM estradiol
- **Não elegíveis:** Mulheres cis, trans femininas COM estradiol

3. Pérola

A APS pode e deve manejar toda a jornada da PrEP – da prescrição à suspensão!

QUESTÃO 2 ■ Clínica Médica ■ Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) ■ Gabarito: B

Gestante de 26 anos, G2P1, 32 semanas de idade gestacional, é admitida na urgência obstétrica após resultado de VDRL 1:64 em exame de rotina do terceiro trimestre. Ela apresentou VDRL não reagente na primeira consulta de pré-natal (8 semanas) e não compareceu ao seguimento regular desde então. Refere ter iniciado novo relacionamento há 4 meses. Ao exame físico, encontra-se assintomática, sem lesões cutaneomucosas, e a ultrassonografia obstétrica evidencia hepatomegalia fetal e polidrâmnio. O parceiro atual, assintomático, realizou teste rápido treponêmico com resultado reagente. Considerando o cenário clínico e as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão vertical, qual é a conduta mais adequada para esta paciente?

- (A) Aguardar confirmação com FTA-Abs e, se positivo, iniciar penicilina G benzatina 2.400.000 UI em dose única.
(B) ✓ Iniciar penicilina G benzatina 2.400.000 UI semanal por 3 semanas com orientação para tratamento do parceiro.
(C) Solicitar punção lombar para excluir neurosífilis antes de definir o esquema terapêutico.
(D) Encaminhar para pré-natal de alto risco e aguardar avaliação de especialista antes de iniciar tratamento.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa comete **dois erros graves**. Primeiro, sugere aguardar confirmação com FTA-Abs, o que é desnecessário em gestante com VDRL reagente em títulos elevados ($\geq 1:8$). O PCDT vigente do Ministério da Saúde recomenda tratamento imediato, sem necessidade de confirmação adicional, especialmente quando há evidências de comprometimento fetal. Segundo, propõe dose única de penicilina, que seria o esquema para sífilis recente documentada. Neste caso, com duração de infecção indeterminada e achados fetais de comprometimento, o esquema correto é de 3 doses semanais.

(B) ✓ **CORRETA** - Esta é a conduta preconizada pelo PCDT para Prevenção da Transmissão Vertical (MS, 2022, atualizado 2024/2025). Diante de gestante com VDRL em títulos elevados (1:64), achados ultrassonográficos de comprometimento fetal (hepatomegalia e polidrâmnio) e impossibilidade de determinar com precisão a duração da infecção, classifica-se como **sífilis de duração ignorada**, indicando o esquema de **3 doses semanais** de penicilina G benzatina 2.400.000 UI. O tratamento do parceiro é recomendado para evitar reinfecção, porém **não é mais critério obrigatório** para considerar o tratamento materno como adequado segundo as diretrizes atuais do MS. Os critérios de tratamento adequado são: uso de penicilina benzatina, esquema correto para o estágio e início até 30 dias antes do parto.

(C) ✗ **INCORRETA** - A punção lombar para investigação de neurosífilis **não** é indicada rotineiramente em gestantes assintomáticas. As indicações de punção lombar incluem: sinais ou sintomas neurológicos, falha terapêutica documentada ou pacientes com HIV. Esta gestante é assintomática do ponto de vista neurológico, portanto a punção lombar não está indicada e não deve atrasar o início do tratamento. Lembre-se: em gestante, o tempo é crucial para a proteção fetal.

(D) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa representa uma conduta **perigosa** e inadequada. Aguardar avaliação de especialista ou encaminhamento para pré-natal de alto risco **antes** de iniciar o tratamento pode resultar em progressão do dano fetal e desfechos adversos graves. O tratamento da sífilis na gestação deve ser **imediato**, iniciado pelo médico que fez o diagnóstico, em qualquer nível de atenção. O encaminhamento para pré-natal de alto risco pode ser feito paralelamente, mas nunca deve atrasar o início da penicilina.

RESUMO (TLDR)**Sífilis na Gestação: O Que Realmente Importa?**

A sífilis na gestação exige tratamento **imediato** com penicilina G benzatina para prevenir a transmissão vertical.

1. Estadiamento e Tratamento

- **Sífilis Recente (< 1 ano documentada):** Dose única
- **Sífilis Tardia ou Duração Ignorada:** 3 doses semanais
- **Na dúvida:** Sempre 3 doses!

2. Critérios de Tratamento Adequado

- Penicilina G benzatina (única droga aceita)
- Esquema completo para o estágio
- Iniciado ≥ 30 dias antes do parto
- Parceiro tratado

3. Pérola Final

Achados fetais anormais (hepatomegalia, polidrâmnio) reforçam a indicação do esquema completo de 3 doses, independentemente da estimativa de duração.

QUESTÃO 3 ■ Clínica Médica ■ Doenças Virais ■ Gabarito: C

Médica de família em UBS de município de médio porte recebe, em uma única semana de janeiro, três pacientes com quadros febris agudos suspeitos de arboviroses. O primeiro, homem de 45 anos, diabético, apresenta febre há 4 dias com defervescência nas últimas 24 horas, dor abdominal intensa e vômitos persistentes; plaquetas de 85.000/mm³. O segundo, mulher de 28 anos, gestante de 14 semanas, refere febre baixa, exantema pruriginoso difuso e hiperemia conjuntival bilateral há 2 dias; hemograma sem alterações significativas. O terceiro, homem de 62 anos, hipertenso, apresenta febre alta há 5 dias com poliartralgia incapacitante simétrica em mãos e tornozelos, com edema articular importante. Considerando a necessidade de priorização de recursos limitados, a integração da vigilância epidemiológica e o impacto em saúde pública, qual a melhor estratégia de manejo integrado para esses três casos?

(A) Internar o primeiro paciente para hidratação venosa; solicitar ultrassonografia obstétrica mensal para a gestante e orientar retorno se sintomas neurológicos; prescrever corticosteroide oral para o terceiro paciente; notificar apenas os casos confirmados laboratorialmente.

(B) Encaminhar o primeiro paciente para hidratação oral domiciliar com retorno em 48 horas; tranquilizar a gestante quanto ao baixo risco fetal após o primeiro trimestre; iniciar anti-inflamatório não hormonal para o terceiro paciente; aguardar resultados sorológicos para notificação.

(C) ✓ Internar o primeiro paciente para hidratação venosa e monitorização; referenciar a gestante para pré-natal de alto risco com acompanhamento ultrassonográfico seriado; prescrever analgésico comum e repouso para o terceiro paciente; notificar imediatamente os três casos suspeitos e acionar vigilância entomológica.

(D) Manter os três pacientes em observação ambulatorial com hemograma seriado; solicitar amniocentese para pesquisa viral na gestante; prescrever opioides para o terceiro paciente devido à intensidade da dor; notificar apenas o caso da gestante por se tratar de Zika.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa apresenta dois erros graves. Primeiro, prescrever **corticosteroide oral na fase aguda da Chikungunya** é contraindicado — está associado a efeito rebote da artralgia e prolongamento da viremia. Corticoides são reservados para fases subaguda ou crônica refratárias a outras medidas. Segundo, **notificar apenas casos confirmados laboratorialmente** vai contra as diretrizes do Ministério da Saúde: arboviroses são de notificação compulsória imediata na **suspeita clínica**, permitindo ações de bloqueio epidemiológico antes da confirmação laboratorial. A internação do primeiro paciente está correta, mas os demais erros invalidam a alternativa.

(B) ✗ **INCORRETA** - Esta é a alternativa "armadilha" com múltiplos erros graves. O primeiro paciente apresenta **sinais de alarme** (dor abdominal intensa, vômitos persistentes) durante a defervescência — fase crítica de maior risco de extravasamento plasmático. Encaminhá-lo para hidratação oral domiciliar pode ser fatal. Para a gestante, afirmar que o risco fetal é baixo após o primeiro trimestre é incorreto: a Síndrome Congênita do Zika pode ocorrer em qualquer trimestre. Iniciar **AINE na fase aguda** da Chikungunya é contraindicado pelo risco de sangramento (se for Dengue) e lesão renal em idoso hipertenso. Por fim, aguardar sorologia para notificar atrasa ações de controle vetorial.

(C) ✓ **CORRETA** - Esta alternativa integra corretamente o manejo dos três casos. O **primeiro paciente** (Dengue Grupo C com sinais de alarme) necessita internação para hidratação venosa e monitorização — conduta que pode salvar sua vida durante a fase crítica. A **gestante** com suspeita de Zika deve ser referenciada para pré-natal de alto risco com acompanhamento ultrassonográfico seriado para vigilância de Síndrome Congênita. O **terceiro paciente** (Chikungunya aguda) recebe corretamente analgésico comum e repouso, evitando AINEs e corticoides contraindicados nesta fase. A **notificação imediata** dos três casos suspeitos e o acionamento da vigilância entomológica completam a abordagem de saúde pública, permitindo ações de bloqueio frente a um possível surto.

(D) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa subestima a gravidade do primeiro paciente. Mantê-lo em observação ambulatorial com sinais de alarme durante a defervescência é conduta de risco inaceitável — ele necessita internação. Para a gestante, **amniocentese para pesquisa viral** não é indicada rotineiramente: o diagnóstico de Zika é feito por sorologia/PCR materna, e a vigilância fetal é ultrassonográfica. Opioides podem ser considerados em Chikungunya com dor intensa, mas a prescrição inicial deve ser com analgésicos comuns, escalonando conforme necessidade. O erro mais grave é **notificar apenas o caso da gestante**: todas as arboviroses são de notificação compulsória, e notificar seletivamente compromete a vigilância epidemiológica e o controle de surtos.

RESUMO (TLDR)

Arboviroses na APS: O Essencial para a Prova**Dengue com sinais de alarme = INTERNAÇÃO IMEDIATA**

- Dor abdominal, vômitos, hipotensão, sangramento = Grupo C
- Defervescência é a fase de maior risco

Zika em gestante = PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO

- USG seriada independente do trimestre
- Risco de Síndrome Congênita existe sempre

Chikungunya aguda = ANALGÉSICO COMUM

- NÃO usar AINE (risco se for Dengue)
- NÃO usar corticoide (rebote + prolonga viremia)

Vigilância = NOTIFICAR NA SUSPEITA

- Não esperar confirmação laboratorial
- Cluster de casos = acionar controle vetorial

QUESTÃO 4 ■ Clínica Médica ■ Zoonoses ■ Gabarito: A

Menino de 8 anos é levado pela mãe ao pronto-socorro após ser mordido por um cão de rua há aproximadamente 3 horas. A criança estava brincando no quintal quando o animal, que frequentemente perambula pelo bairro e não possui dono conhecido, entrou no terreno e atacou sem provocação aparente. Ao exame físico, apresenta ferimentos múltiplos e profundos na face, com lacerações em região malar esquerda e lábio superior, além de ferida perfurante em dorso da mão direita, todos com sangramento ativo. O município registrou casos confirmados de raiva canina no último ano. A mãe refere que o esquema vacinal da criança está atualizado conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações, porém não há registro de vacinação antirrábica prévia. Considerando o protocolo de profilaxia da raiva humana, a conduta imediata mais adequada é

(A) ✓ lavar os ferimentos com água e sabão, administrar vacina antirrábica em 4 doses nos dias 0, 3, 7 e 14, e aplicar soro antirrábico ou imunoglobulina humana antirrábica infiltrando ao redor das lesões.

(B) lavar os ferimentos com solução antisséptica, suturar as lacerações faciais para minimizar cicatrizes e iniciar vacina antirrábica em 4 doses, reservando o soro antirrábico para caso o animal seja encontrado raivoso.

(C) higienizar os ferimentos com água e sabão, aguardar a busca ativa e observação do animal por 10 dias antes de iniciar qualquer profilaxia específica, administrando apenas vacina antitetânica.

(D) lavar os ferimentos com água corrente e sabão, administrar apenas vacina antirrábica em esquema de 4 doses, uma vez que o soro antirrábico está contraindicado em ferimentos na face pelo risco de reação local grave.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. Esta é a conduta preconizada pelo Ministério da Saúde para acidentes graves (ferimentos em face e mãos, múltiplos e profundos) causados por animal de risco (cão de rua, desaparecido, em área com circulação viral confirmada). O protocolo inclui: (1) lavagem exaustiva com água e sabão; (2) vacina antirrábica em **4 doses** nos dias 0, 3, 7 e 14; (3) soro antirrábico ou imunoglobulina humana antirrábica, infiltrando o máximo possível ao redor e dentro das lesões. A infiltração local do soro é fundamental para neutralizar o vírus antes que ele penetre nas terminações nervosas. O esquema vacinal pós-exposição é de 4 doses independentemente da indicação de soro — o protocolo atualizado eliminou a 5ª dose no dia 28.

(B) ✗ INCORRETA. Esta alternativa contém dois erros graves: (1) **Suturar ferimentos de mordedura está contraindicado** — a sutura favorece a inoculação profunda do vírus e dificulta a drenagem de secreções contaminadas. Se absolutamente necessária por razões estéticas ou hemostáticas, deve ser feita apenas após infiltração do soro, com pontos frouxos de aproximação; (2) **Não se reserva o soro para depois** — em acidentes graves com animal de risco, o soro deve ser aplicado IMEDIATAMENTE, junto com a primeira dose da vacina. Aguardar o resultado da busca do animal pode significar perder a janela terapêutica para uma doença invariavelmente fatal.

(C) ✗ INCORRETA. A observação do animal por 10 dias **só é válida para cães e gatos domésticos, com dono conhecido, que podem ser efetivamente monitorados**. Um cão de rua, sem dono, que perambula pelo bairro não é passível de observação confiável para fins de profilaxia antirrábica. Além disso, em área com circulação viral confirmada e acidente grave, aguardar significaria perder a janela terapêutica para prevenção de uma doença invariavelmente fatal. A vacina antitetânica é complementar, não substitui a profilaxia antirrábica.

(D) ✗ INCORRETA. O soro antirrábico **NÃO está contraindicado em ferimentos de face** — pelo contrário, ferimentos faciais têm indicação absoluta de soro pela proximidade com o Sistema Nervoso Central, que acelera a progressão do vírus. A infiltração local ao redor das lesões faciais é fundamental e deve ser realizada cuidadosamente. A omissão do soro em um acidente grave como este seria um erro potencialmente fatal. Embora o número de doses (4) esteja correto, a ausência do soro torna a conduta insuficiente.

RESUMO (TLDR)

Profilaxia da Raiva: O Que Realmente Importa?

A raiva é 100% letal após início dos sintomas, então a profilaxia pós-exposição não admite erros.

1. Classifique o Acidente

- **Grave:** Face, pescoço, mãos, pés, mucosas, ferimentos profundos/múltiplos
- **Leve:** Superficiais em tronco/membros

2. Avalie o Animal

- **Observável:** Cão/gato doméstico com dono → observar 10 dias
- **Não observável:** Rua, fugiu, morreu, silvestre → tratamento imediato

3. Defina a Conduta (Protocolo Atualizado)

- **Acidente grave + animal de risco:** Lavagem + SORO + VACINA (4 doses: 0, 3, 7, 14)
- **Acidente leve + animal de risco:** Lavagem + VACINA (4 doses: 0, 3, 7, 14)
- O esquema é sempre de **4 doses** — a 5ª dose (dia 28) foi eliminada do protocolo

4. Pérola

Soro NÃO é contraindicado na face — pelo contrário, é indicação absoluta!

QUESTÃO 5 ■ Clínica Médica ■ Infecções Bacterianas ■ Gabarito: B

Mulher de 32 anos, professora de ensino fundamental, é trazida ao pronto-socorro da Unidade Básica de Saúde com quadro de cefaleia intensa, febre alta e vômitos iniciados há 36 horas. Familiar relata que a paciente apresentou prostração progressiva nas últimas 12 horas, com episódios de confusão mental. Nega comorbidades, uso de medicamentos ou imunossupressão. Ao exame físico: temperatura axilar de 39,2°C, frequência cardíaca de 112 bpm, pressão arterial de 100 x 65 mmHg, escala de coma de Glasgow 14 (abertura ocular espontânea, resposta verbal confusa, obedece comandos). Apresenta rigidez de nuca importante, sinal de Kernig positivo bilateralmente e sinal de Brudzinski presente. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit motor focal, sem papiledema à fundoscopia. Ausência de lesões cutâneas. Exames laboratoriais iniciais mostram leucocitose com desvio à esquerda. Considerando a conduta diagnóstica imediata mais apropriada para esta paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar tomografia computadorizada de crânio antes da punção lombar, devido à alteração do nível de consciência apresentada pela paciente.
- (B) ✓ **Iniciar antibioticoterapia empírica imediatamente e realizar punção lombar para coleta de líquido, sem necessidade de exame de imagem prévio.**
- (C) Solicitar hemoculturas e aguardar resultado preliminar em 24 horas para definir a necessidade de punção lombar diagnóstica.
- (D) Realizar ressonância magnética de encéfalo para exclusão de lesões parenquimatosas antes de qualquer procedimento invasivo.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A tomografia computadorizada de crânio **não** está indicada neste caso. A paciente apresenta Glasgow 14, sem déficit neurológico focal, sem papiledema e sem história de imunossupressão ou convulsões recentes. Segundo as diretrizes da ESCMID (2016), a indicação de TC prévia à punção lombar ocorre quando há Glasgow < 12, déficit focal, papiledema, convulsão recente ou imunossupressão. A confusão mental leve (Glasgow 14) isoladamente, sem sinais de herniação iminente, **não** contraindica a punção lombar imediata. Solicitar TC neste contexto apenas atrasaria o diagnóstico e o tratamento, aumentando a morbimortalidade.

(B) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta preconizada pelas diretrizes atuais. A paciente apresenta quadro clínico clássico de meningite bacteriana (febre, cefaleia, rigidez de nuca, sinais de Kernig e Brudzinski positivos) **sem** critérios para TC prévia. A conduta correta é iniciar **imediatamente** a antibioticoterapia empírica (ceftriaxona) e realizar a punção lombar para análise do líquido. O início precoce do antibiótico — idealmente em até 1 hora — é crucial para reduzir mortalidade. A coleta de líquido, mesmo após o início do antibiótico, ainda permite identificação etiológica na maioria dos casos.

(C) **X INCORRETA.** Aguardar resultado de hemoculturas para definir a necessidade de punção lombar é uma conduta **inadequada** e potencialmente fatal. A meningite bacteriana é uma emergência médica, e o atraso no diagnóstico e tratamento aumenta significativamente a mortalidade e as sequelas neurológicas. As hemoculturas devem ser coletadas, mas o tratamento empírico e a punção lombar não podem ser postergados. Além disso, a sensibilidade das hemoculturas na meningite bacteriana é de apenas 50-80%, não sendo suficiente para excluir o diagnóstico.

(D) **X INCORRETA.** A ressonância magnética de encéfalo **não** é o exame de escolha para avaliação inicial de meningite bacteriana aguda. A RM é mais demorada, menos disponível e não oferece vantagens sobre a TC para excluir contraindicações à punção lombar. Além disso, conforme discutido, esta paciente **não** tem indicação de exame de imagem prévio à PL. Solicitar RM atrasaria ainda mais o diagnóstico e o início do tratamento, comprometendo o prognóstico.

RESUMO (TLDR)

Meningite Bacteriana: O Que Realmente Importa?

A meningite bacteriana é uma **emergência neurológica** com alta mortalidade se não tratada precocemente.

1. Quando Suspeitar?

- Febre + cefaleia + rigidez de nuca (tríade clássica)
- Sinais de Kernig e Brudzinski positivos
- Alteração do nível de consciência

2. TC Antes da PL?

- **NÃO** é rotina!
- Indicar apenas se: Glasgow < 10-12, déficit focal, papiledema, convulsão recente ou imunossupressão

3. Conduta Imediata

- **Antibiótico em até 1 hora** (ceftriaxona 2g IV)
- **Dexametasona** junto ou antes do ATB
- **Punção lombar** para diagnóstico

4. Pérola

Se precisar de TC, dê o antibiótico ANTES – não espere o resultado da imagem!

QUESTÃO 6 ■ Clínica Médica ■ Tuberculose ■ Gabarito: A

Mulher de 32 anos, auxiliar de enfermagem em hospital geral, procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de tosse produtiva há 10 dias, associada a febre vespertina e sudorese noturna. Refere emagrecimento de 3 kg no último mês. Nega comorbidades ou uso de medicações. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, febril (38,2°C), eupneica, com ausculta pulmonar revelando estertores finos em ápice direito. Foram solicitados teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB), baciloscopia de escarro e radiografia de tórax. O TRM-TB resultou detectável para *Mycobacterium tuberculosis*, sem resistência à rifampicina detectada. A baciloscopia mostrou duas cruzes (++). Considerando as recomendações atuais do Ministério da Saúde, qual a conduta mais adequada para essa paciente?

(A) ✓ Iniciar esquema básico (RIPE) e solicitar cultura com teste de sensibilidade, mantendo acompanhamento na Atenção Primária.

(B) Aguardar resultado da cultura de escarro antes de iniciar o tratamento para confirmar sensibilidade às demais drogas.

(C) Encaminhar para serviço de referência terciária devido à sua ocupação como profissional de saúde.

(D) Iniciar esquema básico (RIPE) sem necessidade de cultura, pois o TRM-TB já descartou resistência à rifampicina.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. Esta é a conduta preconizada pelo Ministério da Saúde. Diante de um TRM-TB detectável e sem resistência à rifampicina, o tratamento com o Esquema Básico (RIPE) deve ser iniciado **imediatamente**, sem aguardar outros exames. A cultura com teste de sensibilidade deve ser solicitada concomitantemente, pois é obrigatória em populações vulneráveis como profissionais de saúde. O acompanhamento pode ser feito na Atenção Primária, já que não há indicação de resistência.

(B) ✗ INCORRETA. Aguardar o resultado da cultura (que pode demorar 4-8 semanas) antes de iniciar o tratamento é um erro grave. Cada dia sem tratamento mantém a paciente como fonte de transmissão ativa na comunidade e no ambiente hospitalar. O TRM-TB já confirma o diagnóstico e exclui resistência à rifampicina, permitindo o início seguro do Esquema Básico. A cultura servirá para avaliar resistência às outras drogas e ajustar o esquema se necessário posteriormente.

(C) ✗ INCORRETA. O encaminhamento para referência terciária é indicado para casos de TB resistente, eventos adversos graves ou difícil manejo clínico. O fato de ser profissional de saúde **não é critério isolado** para encaminhamento. A TB sensível (TRM sem resistência à rifampicina) deve ser manejada na Atenção Primária. O que muda para profissionais de saúde é a obrigatoriedade da cultura e a necessidade de investigar contatos no ambiente de trabalho.

(D) ✗ INCORRETA. Embora o início imediato do Esquema Básico esteja correto, a afirmação de que "não há necessidade de cultura" é equivocada. O TRM-TB avalia apenas a resistência à rifampicina, não às demais drogas do esquema (Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol). A cultura é **obrigatória** para populações vulneráveis, incluindo profissionais de saúde, pois permite identificar resistência a outras drogas e ajustar o tratamento se necessário.

RESUMO (TLDR)

TB Pulmonar: O Que Realmente Importa?

O manejo inicial da TB pulmonar gira em torno de três perguntas: É TB? É resistente? Preciso de cultura?

1. Diagnóstico Rápido

- **TRM-TB:** Confirma TB + avalia resistência à Rifampicina em 2h
- **BAAR:** Avalia carga bacilar e serve para controle mensal

2. Quando Começar o Tratamento?

- TRM positivo + Rif sensível → **Inicia RIPE imediatamente**
- Não espera cultura!

3. Pérola

A cultura é universal (todos os casos), mas **obrigatória** em vulneráveis (profissionais de saúde, PVHIV, PPL, rua). Ela complementa o TRM, avaliando resistência às outras drogas.

QUESTÃO 7 ■ Clínica Médica ■ Cirrose e Complicações ■ Gabarito: B

Homem de 62 anos, com diagnóstico de cirrose hepática por hepatite C, é trazido ao pronto-socorro pela família devido a quadro de confusão mental, inversão do ciclo sono-vigília e lentificação do raciocínio há 3 dias. Familiar relata que o paciente não evacua há 5 dias. Ao exame físico: sonolento, desorientado no tempo e espaço, respondendo lentamente às perguntas, com presença de flapping ao exame das mãos; abdome globoso, com maciez móvel positiva, indolor à palpação. Sinais vitais estáveis, afebril. Paracentese diagnóstica realizada evidenciou líquido ascítico com 120 polimorfonucleares/mm³ e GASA de 1,5. Além da identificação e correção do fator precipitante, a conduta farmacológica inicial mais adequada é:

- (A) Metronidazol endovenoso.
- (B) ✓ **Lactulose via oral ou retal.**
- (C) Flumazenil endovenoso.
- (D) Ceftriaxona endovenosa.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O **Metronidazol** é um antibiótico que pode ser utilizado como alternativa à rifaximina no tratamento da EH, por reduzir a flora bacteriana produtora de amônia. No entanto, não é a primeira linha de tratamento. Além disso, seu uso prolongado está associado a **neurotoxicidade** (neuropatia periférica), devendo ser evitado em hepatopatas que já possuem maior vulnerabilidade neurológica. A lactulose permanece como terapia inicial preferencial.

(B) ✓ **CORRETA.** A **Lactulose** é a terapia de primeira linha para a encefalopatia hepática. Ela atua por múltiplos mecanismos: efeito laxativo (reduz constipação, que é o fator precipitante neste caso), acidificação do lúmen intestinal (converte NH₄⁺ em NH₃, não absorvível) e modificação da flora bacteriana. A meta é alcançar 2-3 evacuações pastosas por dia. Pode ser administrada por via oral ou retal (enema) conforme o nível de consciência do paciente.

(C) **X INCORRETA.** O **Flumazenil** é um antagonista competitivo dos receptores benzodiazepínicos no SNC. Sua indicação é restrita a casos de intoxicação por benzodiazepínicos ou reversão de sedação consciente. Embora estudos antigos tenham avaliado seu uso na EH (pela teoria do "tônus GABAérgico aumentado"), ele **não é recomendado** como tratamento padrão da encefalopatia hepática. No caso apresentado, não há história de uso de sedativos.

(D) **X INCORRETA.** A **Ceftriaxona** é o antibiótico de escolha para o tratamento da Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE). A indicação é baseada na contagem de polimorfonucleares ≥ 250 células/mm³ no líquido ascítico. No caso apresentado, a paracentese evidenciou apenas 120 PMN/mm³, o que **exclui PBE**. O GASA $\geq 1,1$ confirma a etiologia hipertensiva da ascite, mas não indica infecção.

RESUMO (TLDR)

Encefalopatia Hepática: O Essencial

Complicação neuropsiquiátrica da cirrose por acúmulo de amônia.

1. Diagnóstico

- Clínico (cirrose + alteração neurológica)
- Flapping = sinal clássico (grau II)
- Amônia sérica NÃO é obrigatória

2. Sempre Buscar Precipitante

- Constipação, infecção (PBE!), sangramento, DHE, medicamentos

3. Tratamento

- **1ª linha:** Lactulose (2-3 evacuações/dia)
- **Recorrente/refratária:** + Rifaximina
- **Paracentese:** Obrigatória se ascite (excluir PBE)

Pérola

Se PMN < 250 na paracentese → não é PBE → procure outro precipitante!

QUESTÃO 8 ■ Clínica Médica ■ Diarreias Crônicas ■ Gabarito: A

Mulher de 32 anos procura a unidade básica de saúde referindo desconforto abdominal há cerca de 8 meses. Relata episódios recorrentes de dor em cólica no abdome inferior, que melhoram após evacuar. Apresenta alternância entre períodos de fezes endurecidas e amolecidas, sem sangue, muco ou pus. Nega perda de peso, febre ou sintomas noturnos. Refere que os sintomas pioram em situações de estresse no trabalho. Exame físico sem alterações significativas. Hemograma, PCR, TSH e anticorpo antitransglutaminase IgA estão normais. De acordo com os critérios diagnósticos de Roma IV, qual é o achado clínico obrigatório para caracterizar a síndrome do intestino irritável?

- (A) ✓ **Dor abdominal recorrente.**
- (B) Distensão abdominal diária.
- (C) Diarreia com muco nas fezes.
- (D) Flatulência excessiva noturna.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A **dor abdominal recorrente** é o critério obrigatório e central para o diagnóstico de SII pelos Critérios de Roma IV. Conforme o consenso, deve ocorrer em média pelo menos 1 dia por semana nos últimos 3 meses, associada a pelo menos dois dos três critérios adicionais (relação com evacuação, mudança na frequência ou forma das fezes). Sem a presença de dor abdominal, o diagnóstico de SII não pode ser estabelecido formalmente em adultos.

(B) ✗ **INCORRETA.** A **distensão abdominal** é um sintoma de suporte frequente na SII, presente em muitos pacientes, mas **não é critério diagnóstico obrigatório** segundo Roma IV. Muitos pacientes com SII referem sensação de inchaço ou distensão, porém este achado isoladamente não fecha diagnóstico. É considerado um sintoma associado, não um critério definidor.

(C) ✗ **INCORRETA.** A presença de **muco nas fezes** pode ocorrer na SII, mas **não é critério diagnóstico**. Aliás, a presença de muco abundante, sangue ou pus nas fezes deve levantar suspeita de doença inflamatória intestinal ou infecção, sendo considerada sinal de alarme que afasta o diagnóstico de SII e indica investigação adicional.

(D) ✗ **INCORRETA.** A **flatulência** é queixa comum em pacientes com SII devido à fermentação intestinal e alterações na microbiota, mas **não é critério diagnóstico**. Além disso, sintomas noturnos que despertam o paciente do sono (como diarreia noturna) são considerados **sinais de alarme** que afastam SII e sugerem doença orgânica.

RESUMO (TLDR)

Síndrome do Intestino Irritável: O Que Realmente Importa?

A SII é o distúrbio funcional GI mais comum. O diagnóstico é **clínico e positivo** (Roma IV).

1. Critério Obrigatório

- **Dor abdominal recorrente** (≥ 1 dia/semana $\times$ 3 meses)

2. Critérios Associados (≥ 2 de 3)

- Relação com evacuação
- Mudança na frequência das fezes
- Mudança na forma das fezes

3. Sinais de Alarme = NÃO é SII

- Perda de peso, sangramento, anemia, sintomas noturnos

4. Pérola

Distensão, flatulência e muco são sintomas comuns, mas **não são critérios diagnósticos!**

QUESTÃO 9 ■ Clínica Médica ■ Doença Inflamatória Intestinal (DII) ■ Gabarito: B

Mulher de 32 anos procura a emergência com queixa de diarreia sanguinolenta há 10 dias, associada a cólicas abdominais em região infraumbilical e urgência evacuatória intensa. Refere cerca de 8 evacuações diárias, com presença de muco e sangue vivo nas fezes. Nega febre. Há 3 anos foi diagnosticada com retocolite ulcerativa, em acompanhamento irregular, utilizando mesalazina 2,4g/dia de forma intermitente. Ao exame físico: regular estado geral, descorada +/4+, afebril, FC 92 bpm, PA 110x70 mmHg, abdome doloroso à palpação profunda em fossa ilíaca esquerda e hipogástrio, sem sinais de peritonite. Exames laboratoriais: Hb 10,2 g/dL, leucócitos 9.800/mm³, PCR 48 mg/L, albumina 3,2 g/dL. Considerando o quadro de atividade moderada a grave da doença, qual a conduta inicial mais adequada?

- (A) Manter mesalazina e associar probióticos.
- (B) ✓ **Iniciar corticoterapia sistêmica.**
- (C) Indicar colectomia de urgência.
- (D) Iniciar infliximabe como primeira linha.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Manter mesalazina e associar probióticos seria uma abordagem inadequada para atividade moderada-grave. A mesalazina, embora seja a base do tratamento da RCU leve, é **insuficiente isoladamente** para controlar crises moderadas-graves. Probióticos podem ter papel adjuvante na manutenção da remissão, mas não há evidência robusta de eficácia na indução de remissão em doença ativa. A paciente necessita de escalonamento terapêutico com corticosteroide sistêmico.

(B) ✓ **CORRETA.** A corticoterapia sistêmica (prednisona 40-60mg/dia) é a **primeira linha** para indução de remissão na RCU moderada-grave, conforme o PCDT de Retocolite Ulcerativa (2023-2025) e diretrizes internacionais (ACG, ECCO). O objetivo é controlar rapidamente a inflamação aguda. Após indução da remissão, inicia-se o desmame gradual do corticoide e define-se a terapia de manutenção (mesalazina, imunomoduladores ou biológicos, conforme resposta e perfil do paciente).

(C) **X INCORRETA.** A colectomia de urgência está reservada para complicações graves: megacólon tóxico, perfuração intestinal, hemorragia maciça refratária ou colite fulminante que não responde ao tratamento clínico intensivo. A paciente apresenta atividade moderada-grave, sem sinais de toxemia, perfuração ou megacólon. O tratamento clínico deve ser otimizado antes de considerar abordagem cirúrgica.

(D) **X INCORRETA.** O infliximabe (anti-TNF) é um biológico altamente eficaz na RCU, mas **não é primeira linha** em atividade moderada-grave sem tentativa prévia de corticoide. Segundo o PCDT e o posicionamento do GEDIIB (2023), os biológicos são indicados em: (1) falha ou contraindicação ao corticoide, (2) colite aguda grave refratária ao corticoide IV após 3-5 dias, ou (3) manutenção em pacientes corticodependentes. Iniciar biológico diretamente, "pulando" o corticoide, não é a conduta recomendada neste cenário.

RESUMO (TLDR)

Tratamento da RCU Moderada-Grave: O Que Realmente Importa?

A paciente está em crise de atividade moderada-grave (não fulminante). A conduta correta segue a escada terapêutica.

1. Classificação

- ≥ 6 evacuações/dia + sangue + anemia + PCR elevada = **Moderada-Grave**
- Sem febre alta, megacólon ou perfuração = **Não é fulminante**

2. Tratamento de Indução

- **Primeira linha:** Corticoide sistêmico (prednisona 40-60mg/dia)
- Mesalazina isolada é insuficiente
- Biológicos: apenas após falha ao corticoide

3. Pérola de Prova

- Corticoide = indução rápida
- Biológico = resgate ou manutenção
- Cirurgia = complicações graves (megacólon, perfuração, refratariedade)

QUESTÃO 10 ■ Clínica Médica ■ Dor Torácica Aguda ■ Gabarito: B

Homem de 62 anos, hipertenso e tabagista, é trazido à emergência com dor torácica de início súbito há 2 horas, de forte intensidade, com irradiação para o dorso. Ao exame, apresenta-se ansioso, sudoreico, com pressão arterial de 178 x 95 mmHg no membro superior direito e 142 x 80 mmHg no esquerdo. Frequência cardíaca de 98 bpm, ausculta cardíaca com sopro diastólico em foco aórtico. O eletrocardiograma evidencia supradesnivelamento do segmento ST de 2 mm em D2, D3 e aVF com infradesnivelamento especular em aVL. Considerando o quadro clínico e os achados, a conduta inicial mais apropriada é:

- (A) Administrar ácido acetilsalicílico, clopidogrel e heparina, e encaminhar para angioplastia primária.
- (B) ✓ **Solicitar angiotomografia de aorta antes de iniciar antiagregação plaquetária ou anticoagulação.**
- (C) Administrar tenecteplase e heparina de baixo peso molecular para reperfusão coronariana imediata.
- (D) Realizar ecocardiograma transtorácico e iniciar nitroglicerina endovenosa para controle da dor.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Esta seria a conduta padrão para um IAM com supra de ST em parede inferior, visando reperfusão por angioplastia primária. No entanto, os achados clínicos (assimetria de PA de 36 mmHg, sopro diastólico aórtico, dor de início súbito com irradiação dorsal) indicam fortemente **dissecção aórtica tipo A** com extensão para a coronária direita. Iniciar antiagregação e anticoagulação sem excluir dissecção pode ser catastrófico: aumenta o risco de sangramento em eventual cirurgia de emergência e expansão do hematoma intramural.

(B) ✓ **CORRETA.** Diante de um paciente com dor torácica aguda e ECG sugestivo de SCA, porém com sinais de alarme para dissecção aórtica (assimetria de PA entre membros, sopro de insuficiência aórtica, dor com irradiação dorsal), a conduta inicial obrigatória é **confirmar ou excluir dissecção antes de qualquer terapia antitrombótica**. A angiotomografia de aorta é o exame de escolha pela alta acurácia e disponibilidade. Somente após exclusão de dissecção podemos prosseguir com o protocolo de SCA.

(C) ✗ **INCORRETA.** A administração de trombolítico (tenecteplase) é uma **contraindicação absoluta** na dissecção aórtica. O fármaco pode causar expansão do hematoma intramural, ruptura da aorta e óbito em minutos. Este erro representa uma das armadilhas mais perigosas da cardiologia de emergência. Os sinais clínicos de dissecção (assimetria de PA, sopro diastólico, dor dorsal) devem impedir qualquer terapia fibrinolítica até que a condição seja excluída por imagem.

(D) ✗ **INCORRETA.** Embora o ecocardiograma transtorácico possa identificar sinais indiretos de dissecção (insuficiência aórtica, derrame pericárdico, flap na aorta ascendente), ele tem sensibilidade limitada para o diagnóstico definitivo. Além disso, a nitroglicerina endovenosa, apesar de útil na SCA, deve ser usada com cautela na dissecção, pois pode causar taquicardia reflexa (aumentando o estresse de cisalhamento). A angiotomografia de aorta é superior para confirmação diagnóstica neste contexto.

RESUMO (TLDR)

Dissecção vs. SCA: O Que Realmente Importa?

A dissecção aórtica tipo A pode mimetizar perfeitamente um IAM com supra de ST ao ocluir a coronária (geralmente a direita → padrão inferior).

1. Red Flags de Dissecção

- Dor súbita de intensidade máxima
- Irradiação para dorso
- Assimetria de PA/pulsos (> 20 mmHg)
- Sopro de insuficiência aórtica novo

2. Conduta Correta

- **NÃO** antiagregue, anticoagule ou trombolise antes de excluir dissecção
- **Angiotomografia de aorta** é o exame de escolha

3. Pérola Fatal

Trombolítico em dissecção = ruptura de aorta → óbito. Esta é uma das contraindicações absolutas mais cobradas em provas!

QUESTÃO 11 ■ Clínica Médica ■ Arritmias Cardíacas ■ Gabarito: B

Mulher de 42 anos procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de palpitações recorrentes há 6 meses. Relata episódios de início e término súbitos, com duração de 10 a 30 minutos, acompanhados de desconforto torácico leve e sensação de "coração acelerado". Nega síncope, dispneia ou dor torácica intensa. Refere que os episódios cessam espontaneamente ou quando realiza manobra de "prender a respiração". É hipertensa em uso de losartana 50 mg/dia. Ao exame físico: PA 128 x 82 mmHg, FC 78 bpm, ritmo cardíaco regular. Durante a consulta, apresenta novo episódio com FC de 180 bpm. O eletrocardiograma realizado nesse momento evidencia taquicardia regular de QRS estreito (90 ms), sem ondas P visíveis antes do QRS, com presença de entalhe terminal nos complexos QRS em DII, DIII e aVF (pseudo-onda S) e deflexão positiva ao final do QRS em V1 (pseudo-R'). Considerando o quadro clínico e os achados eletrocardiográficos, qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta inicial mais adequada?

- (A) Fibrilação atrial paroxística; iniciar betabloqueador e anticoagulação.
- (B) ✓ **Taquicardia por reentrada nodal; realizar manobra vagal modificada.**
- (C) Flutter atrial com condução 2:1; administrar amiodarona endovenosa.
- (D) Taquicardia atrial focal; encaminhar para ablação imediata.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A **Fibrilação Atrial (FA)** caracteriza-se eletrocardiograficamente por ritmo **irregular** (intervalos R-R completamente variáveis) e ausência de ondas P organizadas, com linha de base oscilante ou com ondas f fibrilatórias. O caso apresenta ritmo **regular** com pseudo-ondas S e pseudo-R', achados típicos de TRN, não de FA. Além disso, a anticoagulação na FA deve ser guiada pelo escore CHA₂DS₂-VASc, não sendo indicada universalmente para todos os pacientes. A conduta inicial na FA paroxística estável também seria controle de frequência, não necessariamente betabloqueador imediato com anticoagulação.

(B) ✓ **CORRETA.** O quadro clínico e eletrocardiográfico são clássicos de **Taquicardia por Reentrada Nodal (TRN) típica**: mulher de meia-idade, episódios paroxísticos de início e término súbitos, que cessam com manobras ("prender respiração" sugere Valsalva rudimentar). O ECG mostra taquicardia de QRS estreito e regular com pseudo-ondas S em derivações inferiores e pseudo-R' em V1 - achados patognômicos de ondas P retrógradas na TRN típica (slow-fast). A paciente está **hemodinamicamente estável** (PA normal, consciente, sem dispneia), portanto a conduta inicial correta é a **manobra vagal modificada** (REVERT), que é primeira linha no tratamento da TRN estável conforme as diretrizes ESC 2019.

(C) **X INCORRETA.** O **Flutter Atrial** caracteriza-se eletrocardiograficamente por ondas F em padrão de "dente de serra" (serrilhado), melhor visualizadas nas derivações inferiores (DII, DIII, aVF), com frequência atrial em torno de 300 bpm. Na condução 2:1 (a mais comum), a frequência ventricular seria aproximadamente 150 bpm e o ritmo seria regular, porém as ondas F serrilhadas estariam presentes, não pseudo-ondas S. Além disso, a amiodarona não é primeira linha para Flutter estável - prefere-se controle de frequência com betabloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio, ou cardioversão se indicada.

(D) **X INCORRETA.** A **Taquicardia Atrial Focal** origina-se de um foco ectópico atrial e apresenta ondas P de morfologia diferente da sinusal **visíveis antes de cada QRS**, com intervalo RP' longo (RP' > PR). No caso apresentado, não há ondas P visíveis antes do QRS - as deflexões identificadas (pseudo-S, pseudo-R') representam ativação atrial **retrógrada** (após a despolarização ventricular), típica da TRN. Além disso, encaminhamento para ablação imediata não é a conduta inicial em nenhuma TSV no momento do episódio agudo; primeiro deve-se reverter a arritmia e depois, em seguimento ambulatorial, discutir ablação como tratamento definitivo para casos recorrentes.

RESUMO (TLDR)

TRN: O Essencial para a Prova

Definição: Arritmia supraventricular mais comum, por reentrada no nó AV (dupla via nodal).

1. Reconhecimento no ECG

- QRS estreito + regular + FC 150-250 bpm
- **Pseudo-S em DII, DIII, aVF e/ou pseudo-R' em V1** = ondas P retrógradadas
- **Ausência de ondas P sinusais** visíveis antes do QRS = ativação atrial retrógrada

2. Perfil Típico

- Mulher, 30-50 anos, sem cardiopatia
- Episódios súbitos que podem cessar com manobras

3. Tratamento (Paciente Estável)

1. **Manobra vagal modificada (REVERT)** → 1ª linha
2. **Adenosina 6 mg IV** → se manobra falhar
3. Diltiazem/Verapamil ou Betabloqueador → alternativas

Pérola

Paciente instável (5 Ds) = Cardioversão Elétrica Sincronizada, independente da TSV!

QUESTÃO 12 ■ Clínica Médica ■ Valvopatias ■ Gabarito: A

Mulher de 34 anos, com história de febre reumática na infância, procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de dispneia progressiva há 8 meses, atualmente aos mínimos esforços, associada a palpitações frequentes. Refere dois episódios de "desmaio" nos últimos dois meses, ambos precedidos por esforço físico. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, com facies mitralis. Pressão arterial: 118 x 72 mmHg; frequência cardíaca: 112 bpm, irregular. Ausculta pulmonar com estertores crepitantes em bases. Ausculta cardíaca com ritmo irregular, B1 hiperfonética em foco mitral, estalido de abertura precoce seguido de sopro diastólico em ruflar com reforço pré-sistólico ausente; P2 hiperfonética. Ecocardiograma transtorácico revela área valvar mitral de 0,9 cm², gradiente médio transvalvar de 14 mmHg, pressão sistólica de artéria pulmonar de 58 mmHg, ausência de trombo em átrio esquerdo e escore de Wilkins de 7 pontos. Considerando a gravidade do quadro, os achados ecocardiográficos e a necessidade de definir a melhor estratégia terapêutica para esta paciente, qual a conduta mais adequada?

(A) ✓ Valvoplastia mitral percutânea por balão.

(B) Troca valvar mitral por prótese mecânica.

(C) Comissurotomia mitral cirúrgica aberta.

(D) Otimização clínica e reavaliação em 6 meses.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. A **valvoplastia mitral percutânea por balão (PMBV)** é o tratamento de escolha para esta paciente. Ela apresenta todos os critérios de indicação: estenose mitral grave sintomática (área valvar 0,9 cm², dispneia NYHA III-IV), morfologia favorável pelo escore de Wilkins (7 pontos ≤ 8), ausência de trombo em átrio esquerdo e presumível regurgitação mitral não significativa. Segundo as diretrizes ESC/EACTS 2025, a PMBV é recomendação Classe I para pacientes com este perfil. O procedimento oferece excelentes resultados imediatos e a longo prazo em válvulas com morfologia favorável, com menor morbidade que a cirurgia aberta.

(B) ✗ INCORRETA. A **troca valvar mitral por prótese mecânica** não é a primeira escolha neste caso. Esta paciente possui morfologia valvar favorável (Wilkins 7), o que a torna candidata ideal à valvoplastia percutânea. A troca valvar é reservada para casos com: morfologia desfavorável (Wilkins > 8), falha prévia da PMBV, regurgitação mitral moderada/grave associada ou calcificação bicomissural grave. Além disso, uma prótese mecânica em mulher de 34 anos implica anticoagulação vitalícia com Varfarina (INR 2,5-3,5), com riscos de sangramento e complicações a longo prazo que devem ser evitados quando há alternativa menos invasiva.

(C) ✗ INCORRETA. A **comissurotomia mitral cirúrgica aberta** é uma alternativa válida, porém não é a melhor escolha quando a PMBV está disponível e indicada. A comissurotomia aberta pode ser considerada em centros sem expertise em procedimentos percutâneos, quando há necessidade de abordar outras lesões valvares concomitantes ou em casos de contraindicação à PMBV. Nesta paciente, com morfologia favorável e sem contraindicações ao procedimento percutâneo, a PMBV oferece resultados equivalentes com menor morbidade, menor tempo de internação e ausência de necessidade de circulação extracorpórea.

(D) ✗ INCORRETA. A conduta de "**otimização clínica e reavaliação em 6 meses**" seria inadequada e potencialmente perigosa para esta paciente. Ela apresenta estenose mitral grave com sintomas incapacitantes (dispneia aos mínimos esforços), episódios de síncope (sugerindo baixo débito cardíaco crítico), hipertensão pulmonar significativa (PSAP 58 mmHg) e fibrilação atrial. Postergar a intervenção neste cenário aumenta o risco de eventos tromboembólicos, deterioração clínica progressiva e morte súbita. O tratamento clínico isolado não reverte a obstrução mecânica e é reservado apenas para pacientes assintomáticos ou com

contraindicações absolutas à intervenção.

RESUMO (TLDR)

Estenose Mitral: Decisão Terapêutica

Paciente jovem com EM grave sintomática necessita de intervenção — a questão é **qual**.

1. Quando indicar PMBV?

- EM grave (área $\leq 1,0 \text{ cm}^2$)
- Sintomática (NYHA $\geq \text{II}$)
- **Wilkins ≤ 8** (morfologia favorável)
- Sem trombo em AE
- Regurgitação mitral $\leq$ leve

2. Quando indicar cirurgia?

- Wilkins > 8 (morfologia desfavorável)
- Trombo em AE persistente
- RM moderada/grave associada
- Falha da PMBV prévia

3. Pérola de Prova

O **escore de Wilkins** é o divisor de águas: ≤ 8 = PMBV; > 8 = cirurgia. Se a banca não mencionar Wilkins ou der valor ≤ 8 com demais critérios presentes → resposta é PMBV!

II. Cirurgia Geral

QUESTÃO 13 ■ Cirurgia Geral ■ Cirurgia Bariátrica ■ Gabarito: B

Mulher de 42 anos, submetida a bypass gástrico em Y de Roux há 18 meses, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixas de fadiga progressiva, parestesias em extremidades e dificuldade de concentração há 3 meses. Relata adesão irregular à suplementação vitamínica prescrita na alta hospitalar. Ao exame físico, apresenta-se hipocorada (++)/4+, com glossite e queilite angular. Traz exames laboratoriais: hemoglobina 9,2 g/dL, VCM 112 fL, leucócitos 4.800/mm³, plaquetas 180.000/mm³, ferritina 85 ng/mL, vitamina B12 98 pg/mL (referência: 200-900), ácido fólico 8 ng/mL. Considerando a fisiopatologia da cirurgia realizada, as manifestações clínicas e os achados laboratoriais, qual é a conduta mais adequada para esta paciente?

- (A) Iniciar reposição oral de sulfato ferroso 300 mg/dia e solicitar endoscopia digestiva alta para investigar sangramento oculto.
- (B) ✓ **Prescrever vitamina B12 intramuscular 1.000 mcg/semana por 4 semanas, seguida de manutenção mensal, e reforçar orientações sobre adesão à suplementação.**
- (C) Solicitar dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico para confirmação diagnóstica antes de iniciar qualquer tratamento de reposição.
- (D) Encaminhar para transfusão de concentrado de hemácias devido à anemia sintomática e iniciar investigação de neoplasia hematológica.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A ferritina está normal (85 ng/mL), o que afasta deficiência de ferro como causa primária da anemia. Além disso, o VCM de 112 fL indica macrocitose, incompatível com anemia ferropriva (que causa microcitose). A investigação de sangramento oculto com endoscopia não é prioritária neste contexto, pois os achados apontam claramente para deficiência de B12. Tratar com sulfato ferroso seria ineficaz e atrasaria o tratamento correto.

(B) ✓ **CORRETA.** A paciente apresenta o quadro clássico de deficiência de vitamina B12 pós-bypass gástrico: anemia macrocítica (VCM 112 fL), B12 sérica baixa (98 pg/mL), sintomas neurológicos (parestesias, déficit cognitivo) e sinais de deficiência de vitaminas do complexo B (glossite, queilite angular). A via **intramuscular** é obrigatória porque a absorção oral está comprometida pela exclusão do estômago (fator intrínseco) e duodeno (sítio de absorção). O esquema de 1.000 mcg/semana por 4 semanas, seguido de manutenção mensal, é o preconizado pelas diretrizes. Reforçar a adesão à suplementação é fundamental para prevenção de outras deficiências.

(C) ✗ **INCORRETA.** A dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico é útil em casos de B12 em "zona cinzenta" (200-400 pg/mL), onde há dúvida diagnóstica. Com B12 de 98 pg/mL (francamente baixa) e quadro clínico exuberante, o diagnóstico já está estabelecido. Aguardar exames complementares atrasaria o tratamento e aumentaria o risco de lesão neurológica irreversível – lembre-se que a degeneração combinada subaguda pode deixar sequelas permanentes se não tratada precocemente.

(D) ✗ **INCORRETA.** A hemoglobina de 9,2 g/dL, embora reduza a capacidade de exercício, não indica transfusão em uma paciente jovem, hemodinamicamente estável e sem comorbidades cardiopulmonares. A indicação de transfusão baseia-se em sintomas de descompensação (angina, dispneia em repouso, taquicardia sintomática), não apenas no número. Além disso, não há elementos que sugiram neoplasia hematológica: a paciente tem uma causa clara e tratável para a anemia, e o leucograma e plaquetas estão normais.

RESUMO (TLDR)

Deficiência de B12 Pós-Bypass: O Que Realmente Importa?

A vitamina B12 precisa do fator intrínseco (produzido no estômago) para ser absorvida no duodeno. O bypass exclui ambos.

1. Quando Suspeitar?

- Anemia **macrocítica** (VCM > 100 fL) 12-24 meses após a cirurgia
- Sintomas neurológicos: parestesias, déficit cognitivo, alterações de marcha
- Glossite, queilite angular

2. Como Tratar?

- **Via parenteral (IM ou SC)** é obrigatória no bypass
- Ataque: 1.000 mcg/semana por 4 semanas
- Manutenção: 1.000 mcg/mês vitalício

3. Pérola

Não espere confirmação com exames sofisticados quando a B12 está muito baixa e a clínica é clara – o tratamento precoce evita sequelas neurológicas irreversíveis!

QUESTÃO 14 ■ Cirurgia Geral ■ Cirurgia Bariátrica ■ Gabarito: B

Homem de 42 anos comparece ao ambulatório de cirurgia geral encaminhado pela Unidade Básica de Saúde para avaliação de elegibilidade para cirurgia bariátrica. Tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 3 anos, em uso de metformina 2g/dia e empagliflozina 25mg/dia, com hemoglobina glicada atual de 8,2%. Apresenta também hipertensão arterial controlada com losartana 50mg/dia e apneia obstrutiva do sono moderada em uso de CPAP. Peso: 94 kg; Altura: 1,72 m. Refere ter realizado acompanhamento nutricional e com educador físico nos últimos 18 meses, sem perda ponderal significativa. Considerando a Resolução CFM nº 2.429/2025, qual a análise correta sobre a indicação cirúrgica desse paciente?

(A) Não há indicação cirúrgica, pois o IMC está abaixo de 35 kg/m² e o diabetes está parcialmente controlado com medicações orais.

(B) ✓ **Há indicação cirúrgica pelo IMC associado a diabetes tipo 2 não controlado, independentemente do tempo de acompanhamento clínico prévio.**

(C) Não há indicação cirúrgica, pois o paciente deveria ter completado pelo menos 2 anos de tratamento clínico antes da avaliação.

(D) Há indicação cirúrgica apenas se houver progressão para uso de insulina ou desenvolvimento de complicações microvasculares.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa reflete os critérios **antigos** das resoluções CFM 2.131/2015 e 2.172/2017, que eram mais restritivos. Com a Resolução CFM nº 2.429/2025, pacientes com IMC entre 30-34,9 kg/m² **têm indicação** se apresentarem comorbidades graves específicas, incluindo DM2 não controlado. O fato de o diabetes estar "parcialmente controlado" com HbA1c de 8,2% representa, na verdade, um **descontrole** (meta < 7%), reforçando a indicação cirúrgica.

(B) ✓ **CORRETA.** Olha só, esta alternativa está alinhada com a Resolução CFM nº 2.429/2025. O paciente tem IMC de 31,8 kg/m² (Obesidade Grau I) associado a Diabetes Mellitus Tipo 2 não controlado (HbA1c 8,2%). Pela nova resolução, isso configura indicação cirúrgica. Perceba que a exigência de tempo mínimo de tratamento clínico (antes 2 anos) foi **removida** na atualização de 2025. O foco agora é na presença da comorbidade grave e sua refratariedade ao tratamento, não no tempo decorrido.

(C) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa também se baseia em critérios **desatualizados**. A exigência de 2 anos de tratamento clínico prévio era um requisito das resoluções anteriores (CFM 2.131/2015 e 2.172/2017). A Resolução CFM nº 2.429/2025 **removeu** essa exigência temporal. O que importa é a demonstração de que o tratamento clínico não está sendo eficaz em controlar a doença metabólica, independentemente do tempo de acompanhamento.

(D) ✗ **INCORRETA.** A indicação cirúrgica para IMC 30-34,9 kg/m² com DM2 não controlado **não** depende de progressão para insulinoterapia ou desenvolvimento de complicações microvasculares. A cirurgia bariátrica/metabólica tem papel justamente em **prevenir** essas complicações, não em esperar que elas ocorram. Aguardar a deterioração clínica representa perda de oportunidade terapêutica e pior prognóstico a longo prazo.

RESUMO (TLDR)**Cirurgia Bariátrica: Indicações Atualizadas 2025**

A Resolução CFM nº 2.429/2025 revolucionou as indicações!

1. Critérios Tradicionais (Mantidos)

- IMC ≥ 40: Opera sempre
- IMC 35-39,9 + comorbidade: Opera

2. Grande Novidade 2025

- IMC 30-34,9 + DM2 não controlado ou outras comorbidades graves → **OPERA**
- **Não exige mais** 2 anos de tratamento clínico prévio
- **Não exige mais** limites rígidos de idade

3. Pérola Final

Se a questão mencionar a resolução de 2025 e um paciente com IMC ~30-34 + DM2 descompensado, a resposta provavelmente é **indicar a cirurgia!**

QUESTÃO 15 ■ Cirurgia Geral ■ Coloproctologia ■ Gabarito: D

A doença diverticular dos cólons é uma condição prevalente na população ocidental, especialmente em indivíduos acima de 50 anos. Os divertículos colônicos são herniações da mucosa e submucosa através da camada muscular da parede intestinal, caracterizando pseudodivertículos. Considerando a anatomia e a fisiopatologia dessa condição, qual é o segmento do cólon mais frequentemente acometido pela doença diverticular na população ocidental?

- (A) Ceco.
- (B) Cólon ascendente.
- (C) Cólon transverso.
- (D) ✓ **Cólon sigmoide.**

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O ceco é um segmento de grande calibre, logo, pela Lei de Laplace, apresenta menor pressão intraluminal. Na população ocidental, o acometimento do ceco é incomum. Entretanto, vale lembrar que em populações asiáticas há uma proporção maior de divertículos no cólon direito, incluindo o ceco.

(B) **X INCORRETA.** O cólon ascendente também possui calibre maior que o sigmoide e, portanto, menor pressão intraluminal. Na população ocidental, os divertículos predominam no cólon esquerdo, especialmente no sigmoide. O acometimento do cólon ascendente é mais frequente em populações do Oriente.

(C) **X INCORRETA.** O cólon transverso raramente é o segmento mais acometido pela doença diverticular. A localização predominante é o sigmoide, onde o menor diâmetro gera maior pressão pela Lei de Laplace, favorecendo a herniação da mucosa nos pontos de fragilidade.

(D) **✓ CORRETA.** O **cólon sigmoide** é o segmento mais frequentemente acometido pela doença diverticular na população ocidental. Isso se explica pela **Lei de Laplace**: como o sigmoide possui o menor diâmetro do cólon, é onde ocorrem as maiores pressões intraluminais durante as contrações. Essa pressão elevada força a herniação da mucosa através dos pontos de penetração dos vasos retos (*vasa recta*), formando os pseudodivertículos.

RESUMO (TLDR)**Doença Diverticular: O Que Realmente Importa?**

Os divertículos colônicos são **pseudodivertículos** que se formam em pontos de fragilidade da parede (onde penetram os *vasa recta*).

1. Por que o Sigmoide?

- Menor diâmetro do cólon
- Lei de Laplace: menor raio = maior pressão
- Predominância no **Ocidente**

2. E no Oriente?

- Cólon **direito** é mais acometido
- Provável influência genética

3. Pérola

Sigmoide estreito → pressão alta → herniação da mucosa → divertículo!

QUESTÃO 16 ■ Cirurgia Geral ■ Malformações Congênicas ■ Gabarito: B

Lactente de 45 dias, nascido a termo, é trazido à UBS pela mãe com queixa de constipação desde o nascimento. A mãe refere que o bebê evacuou pela primeira vez com 72 horas de vida, após uso de supositório de glicerina, e desde então só evacua com estímulo. Nega vômitos, mas refere que o bebê fica irritado e com a barriga "dura" antes de evacuar. Ao exame físico: abdome globoso e tenso, com ruídos hidroaéreos presentes. Ao toque retal, observa-se saída explosiva de fezes líquidas e gases. Diante da suspeita diagnóstica, é solicitado enema opaco, cujo resultado está apresentado a seguir. Considerando o achado radiológico esperado para essa condição, assinale a alternativa correta.

- (A) O segmento dilatado corresponde à porção aganglionar, que permanece em atonia pela ausência de inervação.
- (B) ✓ **O segmento estreitado corresponde à porção aganglionar, que permanece em contração tônica pela ausência de relaxamento.**
- (C) A zona de transição representa o limite entre o segmento com hiperplasia ganglionar e o segmento normal.
- (D) O calibre aumentado do reto em relação ao sigmoide é o achado típico que confirma o diagnóstico.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA**. Essa alternativa inverte completamente a fisiopatologia! O segmento **dilatado** NÃO é o aganglionar — pelo contrário, é o segmento **sadio** (com células ganglionares preservadas). Ele dilata justamente porque tenta vencer a resistência do segmento doente localizado distalmente. O termo "atonía" também está errado: o problema do segmento aganglionar não é atonia (falta de tônus), mas sim **espasmo tônico** (contração permanente por falta de relaxamento).

(B) **✓ CORRETA**. Perceba que esta alternativa traduz exatamente a fisiopatologia da doença. O segmento **estreitado** é a porção **aganglionar** — sem células ganglionares, não há liberação de neurotransmissores inibitórios (como óxido nítrico e VIP) que normalmente promovem o relaxamento muscular. Resultado: o músculo permanece em **contração tônica constante**, criando uma obstrução funcional. É por isso que no enema opaco vemos o reto/sigmoide de calibre reduzido.

(C) **X INCORRETA**. A zona de transição representa o limite entre o segmento **aganglionar** (doente, estreitado) e o segmento **ganglionar** (sadio, dilatado). Não existe "hiperplasia ganglionar" na Doença de Hirschsprung — o problema é justamente a **ausência** de gânglios, não o excesso. Essa alternativa tenta confundir o candidato usando terminologia que soa técnica mas é conceitualmente errada.

(D) **X INCORRETA**. Na verdade, ocorre exatamente o **oposto**! O reto na Doença de Hirschsprung está **estreitado** (é o segmento aganglionar mais comum), enquanto o sigmoide e cólon proximal estão dilatados. Se o reto estivesse mais calibroso que o sigmoide, pensaríamos em outras causas de constipação (como megarreto funcional), não em Hirschsprung. Essa é uma pegadinha clássica para quem não entendeu a fisiopatologia.

RESUMO (TLDR)

Doença de Hirschsprung: O Que Realmente Importa?

Ausência de células ganglionares no intestino distal por falha na migração embrionária.

1. Fisiopatologia

- Segmento aganglionar (distal) → **espasmo tônico** → **estreitado**
- Segmento ganglionar (proximal) → **dilatação compensatória** → megacólon

2. Quadro Clínico Clássico

- Atraso na eliminação de mecônio (>48h)
- Constipação desde nascimento
- Distensão abdominal
- Sinal do spray ao toque retal

3. Diagnóstico

- **Enema opaco**: zona de transição (cone) + retenção de contraste
- **Biópsia retal (padrão-ouro)**: ausência de células ganglionares

4. Pérola

O "mega" é o sadio! A parte dilatada é a que tem gânglios funcionantes.

QUESTÃO 17 ■ Cirurgia Geral ■ Acessos Vasculares ■ Gabarito: B

Homem de 68 anos, com insuficiência renal crônica dialítica, é submetido a punção de veia jugular interna direita para inserção de cateter de hemodiálise em hospital sem disponibilidade de ultrassonografia. Após a punção com agulha, o médico percebe retorno de sangue vermelho rutilante e pulsátil pelo lúmen. O paciente permanece hemodinamicamente estável, sem sinais de hematoma cervical. Considerando a complicação identificada, qual é a conduta mais adequada?

(A) Prosseguir com a passagem do fio-guia e dilatador pelo mesmo trajeto.

(B) **✓ Retirar a agulha imediatamente e realizar compressão local prolongada.**

(C) Solicitar angiotomografia cervical de urgência antes de qualquer conduta.

(D) Realizar nova punção ipsilateral mais lateralmente sem compressão prévia.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - Prosseguir com a passagem do fio-guia e dilatador após identificar sangue arterial é o **erro mais grave** que se pode cometer nessa situação. Olha só o que aconteceria: o dilatador alargaria o orifício na parede da artéria carótida, tornando impossível o controle do sangramento por compressão simples. Além disso, a manipulação intrarterial pode causar dissecação da parede vascular, embolização de material aterosclerótico (com risco de AVC) ou criação de falso trajeto. Essa conduta transforma uma complicação menor e facilmente manejável em uma emergência vascular potencialmente fatal.

(B) **✓ CORRETA** - Quando a punção arterial é identificada precocemente (apenas agulha no vaso, sem dilatação), a conduta padrão é a **retirada imediata da agulha seguida de compressão manual firme** por 5 a 10 minutos. O pequeno orifício deixado pela agulha fina na parede arterial é facilmente tamponado pela compressão digital adequada contra as estruturas profundas do pescoço. Em pacientes com coagulopatia, a compressão deve ser prolongada (15-20 minutos ou mais). Após hemostasia confirmada, pode-se considerar nova punção em sítio alternativo.

(C) X INCORRETA - Solicitar angiotomografia cervical de urgência antes de qualquer conduta seria inadequado neste cenário. Perceba que o diagnóstico de punção arterial já está estabelecido clinicamente pelos sinais inequívocos: sangue vermelho rutilante e fluxo pulsátil. A angiotomografia atrasaria desnecessariamente a conduta correta (compressão) e não traria informação adicional útil para o manejo. Exames de imagem estão indicados quando há dúvida diagnóstica, quando um cateter calibroso foi avançado na artéria, ou quando há suspeita de complicações como hematoma expansivo, pseudoaneurisma ou dissecção.

(D) X INCORRETA - Realizar nova punção no mesmo lado (ipsilateral) sem antes garantir hemostasia adequada do sítio de punção arterial é conduta de risco. Enquanto houver sangramento ativo (mesmo que mínimo) pelo orifício arterial não comprimido, há risco de formação de hematoma cervical. Além disso, a presença de sangue nos tecidos adjacentes dificulta a visualização anatômica e aumenta o risco de nova punção arterial ou de puncionar o próprio hematoma em formação. A conduta correta seria primeiro comprimir adequadamente, confirmar hemostasia, e então considerar nova punção - preferencialmente em sítio contralateral ou alternativo (como subclávia ou femoral).

RESUMO (TLDR)

Punção Arterial no CVC: O Que Realmente Importa?

A punção arterial acidental é complicação mecânica frequente na cateterização de veia jugular interna, especialmente sem ultrassom.

1. Como Identificar?

- Sangue vermelho **rutilante** (brilhante)
- Fluxo **pulsátil** e vigoroso
- Fluxo **ascendente** no equipo (pressão arterial > pressão hidrostática)

2. Conduta por Calibre

- **Agulha fina:** Retirar imediatamente + compressão firme 5-10 min
- **Cateter/dilatador calibroso:** NÃO retirar → avaliar com cirurgia vascular

3. Pérola de Prova

NUNCA avance fio-guia ou dilatador se suspeitar de punção arterial - você transforma problema pequeno em emergência vascular!

QUESTÃO 18 ■ Cirurgia Geral ■ Trauma Ortopédico ■ Gabarito: B

Homem de 32 anos comparece à Unidade de Pronto Atendimento após queda de bicicleta há 3 horas. Relata ter caído com a mão espalmada no chão. Queixa-se de dor no punho direito, que piora ao movimentar o polegar. Ao exame físico, apresenta edema discreto na face dorsal do punho, sem deformidade aparente. Há dor intensa à palpação da tabaqueira anatômica e do tubérculo do escafoide na face palmar. Radiografias do punho em incidências anteroposterior, perfil e oblíqua não evidenciam traços de fratura. Qual é a conduta mais adequada neste momento?

- (A) Prescrever anti-inflamatório e orientar retorno se persistir dor.
- (B) ✓ Imobilizar com gesso incluindo o polegar e reavaliar em 10-14 dias.**
- (C) Solicitar ressonância magnética de urgência para definir conduta.
- (D) Encaminhar para avaliação ortopédica ambulatorial em 30 dias.

COMENTÁRIOS

(A) X INCORRETA. Prescrever apenas anti-inflamatório e orientar retorno é uma conduta **perigosa** quando há suspeita clínica de fratura de escafoide. Lembre-se: a dor na tabaqueira anatômica é altamente sensível para essa lesão, e até 30% das fraturas não aparecem no RX inicial. Deixar o paciente sem imobilização expõe-no a risco significativo de pseudoartrose e necrose avascular, complicações que podem levar à incapacidade funcional permanente do punho.

(B) ✓ CORRETA. Esta é a conduta padrão-ouro! Quando há suspeita clínica de fratura de escafoide (dor na tabaqueira anatômica, dor no tubérculo do escafoide, mecanismo de trauma compatível) e o RX é normal, devemos **tratar como se a fratura existisse**. A imobilização com gesso incluindo o polegar protege o osso e permite a consolidação caso a fratura exista. A reavaliação em 10-14 dias com nova radiografia permite visualizar a fratura (que se torna evidente pela reabsorção óssea) ou descartar o diagnóstico com segurança.

(C) X INCORRETA. Embora a ressonância magnética seja o padrão-ouro para diagnóstico imediato de fratura de escafoide oculta, solicitá-la de **urgência** não é a conduta mais adequada na Atenção Primária. A RM tem custo elevado, disponibilidade limitada e raramente é acessível em regime de urgência no SUS. A conduta custo-efetiva e amplamente aceita é imobilizar e reavaliar — a RM fica reservada para casos de dúvida persistente ou quando há necessidade de definição rápida (como em atletas profissionais).

(D) X INCORRETA. Aguardar 30 dias para avaliação ortopédica é tempo demais! O paciente ficaria sem proteção adequada para uma possível fratura, aumentando significativamente o risco de complicações. Além disso, a Atenção Primária é perfeitamente capaz de conduzir esse caso inicialmente: imobilização e reavaliação em 10-14 dias. O encaminhamento ao ortopedista pode ser feito após confirmação da fratura ou se houver indicação cirúrgica.

RESUMO (TLDR)

Fratura de Escafoide: O Que Realmente Importa?

Fratura mais comum do carpo, frequentemente **invisível** no RX inicial.

1. Mecanismo e Anatomia

- Queda com mão espalmada (FOOSH)
- Vascularização retrógrada → risco de necrose avascular no polo proximal

2. Diagnóstico Clínico (Triade)

- Dor na **tabaqueira anatômica** (mais sensível)
- Dor no **tubérculo do escafoide** (face palmar)
- Dor à **compressão axial do polegar**

3. Conduta com RX Negativo

- **Imobilizar com gesso incluindo polegar**
- Reavaliar em 10-14 dias com novo RX
- Nunca liberar sem proteção!

4. Pérola

Clínica positiva + RX negativo = tratar como fratura até provar o contrário.

QUESTÃO 19 ■ Cirurgia Geral ■ Avaliação perioperatória ■ Gabarito: C

Homem de 67 anos, hipertenso e diabético, foi submetido a colectomia direita videolaparoscópica eletiva por adenocarcinoma de ceco há 36 horas. No pós-operatório imediato, evoluiu sem intercorrências, com diurese satisfatória e sem queixas. Nesta manhã, a enfermagem aciona o plantonista porque o paciente apresentou pico febril de 38,2°C, frequência cardíaca de 92 bpm, frequência respiratória de 22 irpm e saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente. Ao exame físico: lúcido, orientado, corado, hidratado; ausculta cardíaca sem alterações; ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído em bases, sem ruídos adventícios; abdome levemente distendido, indolor à palpação, sem sinais de peritonite; ferida operatória com bom aspecto. Considerando a cronologia e o quadro clínico apresentado, qual a conduta inicial mais adequada?

- (A) Solicitar tomografia de abdome e pelve com contraste para investigar deiscência de anastomose.
- (B) Iniciar antibioticoterapia empírica de amplo espectro e solicitar hemoculturas.
- (C) ✓ **Solicitar radiografia de tórax e intensificar fisioterapia respiratória.**
- (D) Solicitar urocultura e iniciar tratamento empírico para infecção urinária.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Solicitar tomografia de abdome para investigar deiscência de anastomose seria uma conduta precipitada neste momento. Estamos apenas 36 horas após a cirurgia, período muito precoce para deiscência de anastomose, que tipicamente se manifesta entre o 5º e 7º dia pós-operatório. Além disso, o exame abdominal do paciente é benigno: abdome levemente distendido, porém **indolor e sem sinais de peritonite**. Uma deiscência tão precoce seria catastrófica e cursaria com sepse grave e abdome agudo. A febre isolada com exame físico pulmonar alterado aponta para outra etiologia.

(B) ✗ **INCORRETA.** Iniciar antibioticoterapia empírica de amplo espectro diante de febre isolada nas primeiras 48 horas de pós-operatório é uma conduta precipitada e potencialmente danosa. A febre neste período é frequentemente causada por atelectasia ou pela resposta inflamatória ao trauma cirúrgico (REMIT), condições que não requerem antibióticos. O uso indiscriminado de antimicrobianos contribui para seleção de bactérias resistentes e não traz benefício quando não há foco infeccioso identificado. O paciente não apresenta sinais de sepse ou instabilidade hemodinâmica que justifiquem essa abordagem.

(C) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta mais adequada para este paciente. Pela cronologia (36 horas = 1º-2º dia pós-operatório) e pelo quadro clínico apresentado (febre, taquipneia, dessaturação, murmúrio vesicular diminuído em bases sem ruídos adventícios), a hipótese mais provável é **atelectasia pulmonar**. Seguindo o mnemônico dos 5 Ws, estamos na janela do "Wind" (pulmão). A radiografia de tórax confirmará a hipótese diagnóstica e descartará pneumonia. A fisioterapia respiratória intensiva é tanto diagnóstica quanto terapêutica, promovendo expansão pulmonar e resolução da atelectasia.

(D) ✗ **INCORRETA.** A infecção do trato urinário (ITU) está associada à janela do "Water" no mnemônico dos 5 Ws, tipicamente entre o 3º e 5º dia pós-operatório, especialmente em pacientes que permaneceram sondados. Com apenas 36 horas de pós-operatório, estamos fora dessa janela temporal. Além disso, o quadro clínico do paciente não sugere ITU: não há queixas urinárias mencionadas, e os achados de exame físico (MV diminuído, dessaturação) apontam claramente para etiologia pulmonar. Investigar e tratar ITU empiricamente seria ignorar a cronologia e os achados clínicos.

RESUMO (TLDR)

Febre Pós-Operatória Precoce: O Que Importa?

Febre nas primeiras 48 horas após cirurgia abdominal, com achados pulmonares (MV diminuído, dessaturação), aponta para **atelectasia**.

1. Use os 5 Ws

- 1º-2º dia = **Pulmão** (Wind) → atelectasia
- 3º-5º dia = **Urina** (Water) → ITU por sonda
- 5º-7º dia = **Ferida** (Wound) → infecção de sítio cirúrgico
- > 5º dia = **TVP/TEP** (Walk) → doença tromboembólica
- Qualquer dia = **Drogas/Cateter** (Wonder Drugs) → febre medicamentosa

2. Conduta na Atelectasia

- RX de tórax para confirmar
- Fisioterapia respiratória intensiva
- Analgesia adequada + mobilização precoce

3. Pérola

Não saia pedindo TC de abdome e antibióticos para toda febre pós-operatória! O tempo e o exame físico definem a conduta.

QUESTÃO 20 ■ Cirurgia Geral ■ Técnicas e Princípios Cirúrgicos ■ Gabarito: B

Homem de 38 anos, vítima de colisão automobilística, é admitido em pronto-socorro com trauma abdominal fechado e instabilidade hemodinâmica refratária à reposição volêmica inicial. Na laparotomia exploradora de urgência, identifica-se laceração hepática grau IV com sangramento ativo e perfurações múltiplas em jejuno. Após 80 minutos de cirurgia, o paciente evolui com temperatura de 34,0°C, pH 7,15, lactato 9,0 mmol/L, INR 2,6 e plaquetas 55.000/mm³. Considerando a estratégia cirúrgica mais adequada para este paciente, deve-se

- (A) prosseguir com hepatorrafia definitiva e enterorrafias primárias.
- (B) ✓ **realizar tamponamento hepático, ressecção intestinal sem anastomose e peritoneostomia.**
- (C) converter para hepatectomia parcial e jejunostomia derivativa.
- (D) manter compressão manual hepática até normalização laboratorial.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Prosseguir com hepatorrafia definitiva e enterorrafias primárias seria a conduta em paciente estável fisiologicamente. No entanto, este paciente apresenta a tríade letal completa (hipotermia, acidose grave e coagulopatia). Tentar reparo definitivo neste contexto resulta em alta mortalidade, pois o organismo não consegue sustentar o estresse cirúrgico adicional, e as anastomoses realizadas em paciente coagulopático têm altíssimo risco de deiscência.

(B) ✓ **CORRETA.** Esta é a descrição clássica da **Fase 1 do Damage Control Surgery**. O tamponamento hepático (packing) controla o sangramento venoso; a ressecção intestinal sem anastomose elimina a fonte de contaminação sem o risco de deiscência; e a peritoneostomia (fechamento abdominal temporário) evita a síndrome compartimental abdominal. O paciente será reanimado na UTI (Fase 2) e submetido a reparo definitivo após estabilização (Fase 3).

(C) ✗ **INCORRETA.** Hepatectomia parcial é um procedimento de alta complexidade e tempo cirúrgico prolongado, completamente contraindicado em paciente com colapso fisiológico. Além disso, realizar jejunostomia derivativa também adiciona tempo cirúrgico desnecessário. A filosofia do damage control é "fazer o mínimo necessário para manter o paciente vivo" e não realizar procedimentos definitivos ou complexos.

(D) ✗ **INCORRETA.** Manter compressão manual indefinidamente até normalização laboratorial é impraticável e ineficaz. A correção da tríade letal não ocorre intraoperatoriamente apenas com compressão; exige reanimação intensiva em ambiente de UTI com aquecimento ativo, transfusão maciça e suporte hemodinâmico. Além disso, o sangramento persistiria e a contaminação intestinal não estaria controlada.

RESUMO (TLDR)

Damage Control Surgery: O Que Realmente Importa?

Quando o paciente de trauma entra na **Tríade Letal** (Hipotermia + Acidose + Coagulopatia), insistir em cirurgia definitiva é fatal.

1. Indicações para Damage Control

- Temperatura < 35°C
- pH < 7,2
- Coagulopatia (INR > 1,5, plaquetas < 100.000)
- Transusão maciça (> 10 unidades)

2. As Três Fases

- **Fase 1:** Controle rápido (packing, ressecção sem anastomose, peritoneostomia)
- **Fase 2:** Reanimação na UTI (correção da tríade em 24-72h)
- **Fase 3:** Reparo definitivo após estabilização

3. Pérola

"O inimigo é a fisiologia, não a anatomia" - paciente morre de coagulopatia, não da lesão!

QUESTÃO 21 ■ Cirurgia Geral ■ Coloproctologia ■ Gabarito: B

Mulher de 28 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para avaliação após descobrir que sua mãe foi diagnosticada com câncer colorretal aos 42 anos. Refere que o avô materno faleceu de câncer de cólon aos 48 anos e uma tia materna teve câncer de endométrio aos 45 anos. Ela nega sintomas gastrointestinais e nunca realizou colonoscopia. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável e as diretrizes de rastreamento para essa paciente, qual é a conduta adequada?

- (A) Iniciar rastreamento com colonoscopia aos 45 anos, conforme recomendação para população de risco médio.
- (B) ✓ **Solicitar colonoscopia agora e, se normal, repetir a cada 1 a 2 anos a partir dos 20-25 anos ou 2-5 anos antes do caso mais jovem na família.**
- (C) Aguardar o aparecimento de sintomas gastrointestinais para então indicar investigação com colonoscopia.
- (D) Realizar pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente como método de rastreamento inicial.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Esta recomendação aplica-se à população de **risco médio**, ou seja, pessoas sem história familiar significativa ou outros fatores de risco. A paciente do caso apresenta critérios clínicos para Síndrome de Lynch (história familiar com CCR e câncer de endométrio em idade jovem, em 3 familiares, em 2 gerações). Pacientes de alto risco hereditário devem iniciar rastreamento muito mais precocemente (20-25 anos) e com intervalos muito mais curtos (1-2 anos).

(B) ✓ **CORRETA.** Excelente! A paciente preenche os Critérios de Amsterdam II para Síndrome de Lynch. As diretrizes recomendam que o rastreamento colonoscópico em portadores ou suspeitos de Lynch seja iniciado entre **20-25 anos** ou **2-5 anos antes do caso mais jovem na família** (no caso, a mãe teve CCR aos 42 anos, então o rastreamento poderia começar entre 37-40 anos – mas como a paciente já tem 28 anos e está dentro da faixa de início recomendada, deve-se iniciar agora). O intervalo deve ser de **1-2 anos** devido à carcinogênese acelerada nesta síndrome.

(C) ✗ **INCORRETA.** Aguardar sintomas para investigar uma síndrome hereditária de alto risco é um erro grave! O objetivo do rastreamento é justamente detectar lesões pré-malignas (pólipos) ou câncer em estágio inicial, **antes** de causar sintomas. Quando o paciente com Lynch apresenta sintomas (sangramento, alteração do hábito intestinal, dor abdominal), frequentemente o câncer já está em estágio avançado. A vigilância ativa e precoce é fundamental para reduzir mortalidade.

(D) ✗ **INCORRETA.** A pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF ou FIT) é uma opção válida para rastreamento da população de risco médio, mas **não** é adequada para pacientes de alto risco hereditário como a Síndrome de Lynch. A colonoscopia é o método de escolha porque permite não apenas detectar, mas também **remover** pólipos durante o procedimento (polipectomia), interrompendo a sequência adenoma-carcinoma. Além disso, a sensibilidade do FIT pode não ser suficiente para a carcinogênese acelerada do Lynch.

RESUMO (TLDR)

Síndrome de Lynch: O Que Realmente Importa?

A Síndrome de Lynch é a causa hereditária mais comum de CCR, causada por mutação nos genes de reparo do DNA (MLH1, MSH2).

1. Como Reconhecer (Critérios de Amsterdam II)

- 3 familiares com câncer do espectro Lynch
- 2 gerações consecutivas
- 1 caso antes dos 50 anos
- PAF excluída

2. Tumores Associados

- Colorretal (principal)
- **Endométrio** (segundo mais comum – memorize!)
- Ovário, estômago, ureter, delgado

3. Rastreamento

- Colonoscopia: iniciar aos **20-25 anos** ou 2-5 anos antes do caso mais jovem
- Repetir a cada **1-2 anos** (carcinogênese acelerada!)
- Teste genético para confirmação e cascata familiar

Pérola Final

Lynch = poucos pólipos + história familiar rica + endométrio. PAF = centenas de pólipos + gene APC.

QUESTÃO 22 ■ Cirurgia Geral ■ Hérnias de Parede Abdominal ■ Gabarito: C

Homem de 34 anos, carteiro, procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de abaulamento na região inguinal direita há 6 meses, que aumenta com esforço físico e reduz ao deitar. Refere desconforto local durante a jornada de trabalho, quando caminha longas distâncias. Nega episódios de dor intensa, náuseas ou vômitos. Ao exame físico, observa-se abaulamento em região inguinal direita que se torna evidente à manobra de Valsalva, redutível à palpação, emergindo lateralmente aos vasos epigástricos inferiores e percorrendo o canal inguinal. O anel inguinal interno encontra-se alargado, porém a parede posterior do canal inguinal está preservada. Considerando a classificação de Nyhus e as diretrizes atuais para o tratamento das hérnias inguinais, qual a conduta mais adequada para este paciente?

- (A) Tratamento conservador com observação vigilante, reservando cirurgia para casos de encarceramento.
- (B) Hernioplastia inguinal aberta com técnica de Shouldice, sem utilização de tela sintética.
- (C) ✓ **Hernioplastia inguinal aberta com técnica de Lichtenstein, utilizando tela de polipropileno.**
- (D) Hernioplastia inguinal laparoscópica por via totalmente extraperitoneal (TEP), obrigatoriamente.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O tratamento conservador com observação vigilante (*watchful waiting*) é uma opção válida **apenas** para pacientes **assintomáticos** ou com sintomas mínimos, que aceitam o risco de progressão ou complicação. O paciente da questão é **sintomático** (desconforto durante a jornada de trabalho), o que configura indicação cirúrgica eletiva segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hérnias e da European Hernia Society. Aguardar até o encarceramento aumenta a morbidade e transforma uma cirurgia eletiva em urgência.

(B) **X INCORRETA.** A técnica de Shouldice é considerada a melhor entre as técnicas de reparo tecidual (sem tela), com taxas de recidiva aceitáveis quando realizada em centros especializados. No entanto, as diretrizes atuais são categóricas: o uso de **tela sintética é recomendado em todas as hernioplastias inguinais** por reduzir significativamente as taxas de recidiva em comparação às técnicas sem tela. A Shouldice sem tela não é mais o padrão-ouro, tendo sido superada pela Lichtenstein com tela.

(C) ✓ **CORRETA.** A hernioplastia inguinal aberta com técnica de **Lichtenstein** utilizando tela de polipropileno é o **padrão-ouro** para o tratamento de hérnias inguinais primárias unilaterais em homens adultos sintomáticos. É uma técnica "tension-free" (sem tensão nos tecidos), pode ser realizada com anestesia local em regime ambulatorial, apresenta baixa taxa de recidiva (<2%) e é amplamente acessível. O paciente apresenta Nyhus tipo II, sintomático, sem complicações - perfil ideal para Lichtenstein.

(D) **X INCORRETA.** A hernioplastia laparoscópica por TEP (totalmente extraperitoneal) é uma excelente opção, com vantagens como menor dor pós-operatória e menor incidência de dor crônica. Entretanto, ela **não é obrigatória** para hérnias primárias unilaterais. As diretrizes indicam que tanto a via aberta (Lichtenstein) quanto a laparoscópica (TEP/TAPP) são adequadas para esse perfil, sendo a escolha dependente da experiência do cirurgião e disponibilidade de recursos. A TEP é **preferencial** em hérnias bilaterais, recidivadas e em mulheres (risco de hérnia femoral oculta).

RESUMO (TLDR)

Hérnias Inguinais: O Que Realmente Importa?

Hérnia inguinal sintomática em homem adulto = indicação cirúrgica com tela.

1. Classificação de Nyhus (Completa)

- **Tipo I:** Indireta com anel inguinal interno normal (típica de crianças)
- **Tipo II:** Indireta com anel alargado, mas parede posterior preservada
- **Tipo IIIA:** Direta — defeito na parede posterior (triângulo de Hasselbach)
- **Tipo IIIB:** Indireta com destruição da parede posterior ± componente direto
- **Tipo IIIC:** Femoral — protrusão pelo canal femoral
- **Tipo IV:** Recidivada (qualquer tipo)

Anatomia: Y Invertido

O ligamento inguinal forma um "Y invertido" com a fáscia transversalis: o ramo lateral corresponde ao anel inguinal interno (hérnias indiretas) e o ramo medial ao triângulo de Hasselbach (hérnias diretas). Os vasos epigástricos inferiores dividem as duas regiões.

2. Tratamento

- **Primária unilateral:** Lichtenstein (aberta com tela) = padrão-ouro
- **Bilateral/Recidiva/Mulher:** Preferir TEP laparoscópica
- **Shouldice sem tela:** Não é mais primeira escolha

3. Pérola

Lateralidade aos vasos epigástricos define o tipo: **lateral = indireta, medial = direta.**

QUESTÃO 23 ■ Cirurgia Geral ■ Urologia Pediátrica ■ Gabarito: A

Mãe de menino de 2 anos comparece à consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde (UBS) preocupada porque não consegue retrain completamente o prepúcio do filho para higienização durante o banho. Relata que a criança não apresenta dor, dificuldade para urinar ou episódios prévios de infecção local. Ao exame físico, observa-se prepúcio com tecido elástico, sem sinais de fibrose ou cicatrizes, que retrai parcialmente sem dor. Qual informação deve ser transmitida à mãe sobre essa condição?

- (A) ✓ **A fimose fisiológica é comum nessa faixa etária e tende à resolução espontânea na maioria dos casos.**
- (B) Há necessidade de encaminhamento imediato ao cirurgião pediátrico para avaliação de postectomia.
- (C) Deve-se iniciar manobras de retração forçada diárias para acelerar a abertura do prepúcio.
- (D) O uso de corticoides tópicos está indicado de imediato para prevenir complicações futuras.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A fimose fisiológica é extremamente comum em meninos com menos de 3 anos de idade. Perceba que o enunciado descreve claramente um **tecido elástico, sem fibrose**, o que caracteriza a condição como fisiológica. A literatura mostra que aproximadamente 90% dos casos resolvem-se espontaneamente até os 3 anos de idade devido ao crescimento peniano e ereções fisiológicas. Nessa situação, a conduta adequada é **expectante**, com orientação aos pais sobre higiene externa sem retração forçada.

(B) ✗ **INCORRETA.** O encaminhamento imediato para cirurgia pediátrica **não está indicado** neste caso. A postectomia tem indicações precisas: fimose patológica (anel fibrótico), balanopostites de repetição, ITU recorrente, parafimose prévia ou falha do tratamento conservador. Note que a criança do caso não apresenta nenhum desses critérios – tem tecido elástico, sem complicações. Encaminhar para cirurgia seria uma intervenção desnecessária.

(C) ✗ **INCORRETA.** As manobras de retração forçada estão **completamente proscritas!** Essa é uma orientação antiga que infelizmente ainda persiste na cultura popular. O trauma causado pela retração forçada provoca microlesões que cicatrizam com fibrose, transformando uma fimose fisiológica em patológica. A higiene deve ser feita externamente, sem forçar a exposição da glândula.

(D) ✗ **INCORRETA.** O uso de corticoides tópicos (betametasona 0,05-0,1%) **não está indicado de rotina** em toda fimose fisiológica. Essa terapia é reservada para casos de fimose fisiológica **persistente** após os 3-5 anos de idade ou quando há anel estenótico sem fibrose. No caso apresentado, a criança tem apenas 2 anos e não apresenta sintomas – a conduta expectante é suficiente.

RESUMO (TLDR)

Fimose na Infância: O Que Realmente Importa?

A fimose é a incapacidade de retrair o prepúcio. O segredo está em diferenciar **fisiológica** (normal) de **patológica** (doença).

1. Fimose Fisiológica

- Tecido elástico, sem cicatriz
- Normal até 3-5 anos
- ~90% resolvem espontaneamente
- **Conduta: expectante**

2. Fimose Patológica

- Anel fibrótico/cicatricial (branco, rígido)
- Causas: trauma, infecções, BXO
- **Conduta: cirurgia**

3. Pérola de Prova

Retração forçada está PROSCRITA – transforma fisiológica em patológica!

QUESTÃO 24 ■ Cirurgia Geral ■ Pancreatobiliar ■ Gabarito: A

Mulher de 48 anos, obesa, comparece à Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor abdominal em hipocôndrio direito há 4 horas, de forte intensidade, tipo cólica, iniciada após jantar em churrascaria. Refere episódios semelhantes nos últimos 6 meses, sempre relacionados à ingestão de alimentos gordurosos, com resolução espontânea em poucas horas. Nega febre, icterícia ou alteração urinária. Ao exame físico: bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, afebril (36,4 °C), frequência cardíaca de 88 bpm, pressão arterial de 128 × 82 mmHg. Abdome globoso, doloroso à palpação profunda em hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal, sinal de Murphy ausente. Exames laboratoriais: hemograma normal, bilirrubinas normais, transaminases normais, amilase normal. Ultrassonografia abdominal: vesícula biliar de paredes finas, com múltiplos cálculos em seu interior; vias biliares de calibre normal. Considerando o quadro clínico e os achados propedêuticos, qual é a conduta mais adequada para essa paciente?

- (A) ✓ **Indicar colecistectomia videolaparoscópica eletiva.**
- (B) Orientar tratamento conservador com dieta hipolipídica.
- (C) Solicitar colangioressonância antes de definir conduta.
- (D) Encaminhar para colecistectomia de urgência.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Esta paciente apresenta quadro clássico de **colecistite sintomática** (cólica biliar): dor em hipocôndrio direito, pós-prandial, autolimitada, com USG confirmando cálculos em vesícula de paredes finas. Não há sinais de complicações (febre ausente, Murphy negativo, laboratório normal, vias biliares não dilatadas). A indicação é inequívoca: **colecistectomia videolaparoscópica eletiva**. A cirurgia deve ser programada após resolução do episódio agudo, em caráter eletivo, preferencialmente em até 4-6 semanas. Conforme o Protocolo do HC-FMUSP/MS (2017) e as diretrizes internacionais, a presença de sintomas recorrentes indica tratamento cirúrgico definitivo, pois a taxa de recorrência dos episódios e o risco de complicações graves aumentam progressivamente.

(B) ✗ **INCORRETA.** O tratamento conservador com dieta hipolipídica **não é conduta definitiva** para colecistite sintomática. A dieta pode reduzir a frequência dos episódios, mas não elimina os cálculos nem previne complicações. A paciente já apresentou episódios recorrentes nos últimos 6 meses, confirmando o caráter sintomático da doença. Manter apenas dieta seria expô-la ao risco de complicações graves como colecistite aguda, coledocolitíase, pancreatite biliar e colangite. Esta alternativa seria aceitável apenas para pacientes assintomáticos ou com risco cirúrgico proibitivo (ASA IV-V).

(C) ✗ **INCORRETA.** A colangioressonância (ColangioRM) é indicada quando há **suspeita de coledocolitíase** (cálculo na via biliar principal). Os preditores de coledocolitíase incluem: icterícia, colúria, elevação de bilirrubinas, dilatação de vias biliares ao USG e elevação de enzimas canaliculares (FA e GGT). A paciente do caso não apresenta nenhum desses achados: está anictérica, com bilirrubinas e transaminases normais, e vias biliares de calibre normal ao USG. Portanto, não há indicação de colangioressonância antes da colecistectomia. Solicitar esse exame seria aumentar custos desnecessariamente e retardar o tratamento definitivo.

(D) ✗ **INCORRETA.** A colecistectomia de **urgência** é reservada para casos de **colecistite aguda**, não para cólica biliar simples. A colecistite aguda é caracterizada por: dor > 6 horas, febre, leucocitose, sinal de Murphy positivo e espessamento de parede vesicular > 4 mm ao USG. A paciente não apresenta nenhum desses critérios: está afebril, sem leucocitose, com Murphy negativo e vesícula de paredes finas. Encaminhar para cirurgia de urgência seria indicação inadequada, expondo a paciente a riscos desnecessários de uma cirurgia em regime de emergência. A indicação correta é cirurgia **eletiva**, programada.

RESUMO (TLDR)

Colelitíase Sintomática: O Essencial

Paciente com cólica biliar recorrente + cálculos no USG = **cirurgia indicada**.

1. O Que Define Cólica Biliar?

- Dor em HCD pós-prandial, < 6 horas, autolimitada
- Sem febre, sem Murphy, laboratório normal

2. A Conduta Correta

- **Sintomático:** Colectectomia **ELETIVA**
- **Assintomático:** Observação (exceto casos específicos)
- **Colecistite:** Colectectomia de **URGÊNCIA**

3. Pérola de Prova

Dieta hipolipídica **NÃO** é tratamento definitivo. Se teve sintoma, vai para cirurgia!

III. Ginecologia e Obstetrícia

QUESTÃO 25 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Monitorização Fetal ■ Gabarito: B

Gestante de 34 anos, G2P1, com 38 semanas de idade gestacional, portadora de diabetes mellitus gestacional em uso de insulina, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de pré-natal. Relata diminuição dos movimentos fetais nas últimas 48 horas. Ao exame físico, altura uterina compatível com a idade gestacional, batimentos cardíacos fetais de 145 bpm. É realizada cardiotocografia basal, cujo traçado está representado abaixo. Considerando o contexto clínico e os achados do exame, qual a interpretação correta do traçado e a conduta mais adequada?

- (A) Traçado de categoria I, com padrão reativo; orientar retorno em 7 dias para nova avaliação de rotina.
- (B) ✓ **Traçado de categoria II, com variabilidade mínima persistente; complementar avaliação com perfil biofísico fetal.**
- (C) Traçado de categoria III, com desacelerações tardias recorrentes; indicar interrupção imediata da gestação.
- (D) Traçado de categoria I, porém não reativo; repetir exame após estímulo vibroacústico e alimentação materna.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Esta alternativa classifica erroneamente o traçado como Categoria I com padrão reativo. No entanto, a imagem demonstra variabilidade mínima persistente (< 5 bpm), o que automaticamente exclui a Categoria I, que exige variabilidade moderada (6-25 bpm). Além disso, orientar retorno em 7 dias seria inadequado para uma gestante de alto risco (DM gestacional) com queixa de diminuição de movimentos fetais e traçado indeterminado. A conduta subestimaria o risco fetal.

(B) ✓ **CORRETA.** O traçado apresenta linha de base normal (145 bpm), porém com variabilidade mínima persistente (< 5 bpm por período prolongado), sem desacelerações tardias recorrentes ou padrão sinusoidal. Conforme a classificação ACOG/NICHD, adotada pela FEBRASGO, este é um traçado de **Categoria II** (indeterminado). A conduta adequada é complementar a avaliação com perfil biofísico fetal (PBF), que permitirá estratificar melhor o risco e definir se há necessidade de interrupção ou se é possível manter vigilância.

(C) **X INCORRETA.** A Categoria III requer variabilidade **ausente** (não apenas mínima) associada a desacelerações tardias ou variáveis recorrentes, ou presença de padrão sinusoidal. O traçado descrito não preenche esses critérios. Indicar interrupção imediata sem critérios de Categoria III poderia resultar em iatrogenia, especialmente se o feto estiver apenas em período de sono ou a mãe em hipoglicemia transitória. A complementação diagnóstica é o passo correto antes de decisões mais invasivas.

(D) **X INCORRETA.** Esta alternativa reconhece corretamente que o traçado não é reativo, porém o classifica como Categoria I, o que é contraditório. Um traçado de Categoria I deve ter variabilidade moderada e, embora não exija obrigatoriamente acelerações, a presença de variabilidade mínima persistente já o exclui dessa categoria. Além disso, embora o estímulo vibroacústico e a alimentação materna possam ser tentados antes de classificar definitivamente o traçado, no contexto de alto risco (DM gestacional + queixa de ↓ movimentos), a complementação com PBF é mais adequada do que simplesmente repetir o exame.

RESUMO (TLDR)

Cardiotocografia: O Que Realmente Importa?

A CTG avalia a saúde fetal através da frequência cardíaca e sua variabilidade.

1. O Parâmetro Mais Importante

- **Variabilidade moderada (6-25 bpm)** = feto bem oxigenado
- Variabilidade mínima ou ausente = sinal de alerta

2. As 3 Categorias

- **I:** Normal → seguir pré-natal
- **II:** Indeterminada → complementar com PBF
- **III:** Anormal → parto imediato

3. Pérola de Prova

Categoria II é a mais cobrada! Grave: não indica parto, indica **investigação complementar** com perfil biofísico fetal.

QUESTÃO 26 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Alterações do Crescimento Fetal ■ Gabarito: A

Gestante de 29 anos, G2P1, com 33 semanas de idade gestacional, é acompanhada em pré-natal de alto risco por hipertensão arterial crônica. Ultrassonografia obstétrica evidencia peso fetal estimado no percentil 5, com circunferência abdominal abaixo do percentil 3. A dopplervelocimetria demonstra índice de pulsatilidade da artéria umbilical acima do percentil 95 com fluxo diastólico presente, relação cérebro-placentária abaixo do percentil 5 e ducto venoso com onda A positiva. Considerando o quadro de restrição de crescimento fetal, qual a conduta mais adequada?

- (A) ✓ **Internação hospitalar, corticoterapia para maturação pulmonar fetal e reavaliação com Doppler em 48-72 horas.**
 (B) Interrupção imediata da gestação por cesariana devido à alteração da relação cérebro-placentária.
 (C) Manutenção do acompanhamento ambulatorial semanal com Doppler até completar 37 semanas.
 (D) Indução do trabalho de parto com misoprostol após completar a corticoterapia em 48 horas.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta adequada para uma gestante com 33 semanas, RCF confirmada, RCP alterada e ducto venoso normal. Perceba que a alteração da relação cérebro-placentária indica que o feto está em mecanismo compensatório — redistribuindo fluxo para órgãos nobres. Porém, o ducto venoso com onda A positiva mostra que a função cardíaca está preservada e não há acidose. Conforme as diretrizes ISUOG, isso permite uma janela de vigilância. A **internação** garante monitorização adequada, a **corticoterapia** promove maturação pulmonar (essencial entre 24-34 semanas), e a **reavaliação em 48-72h** permite detectar deterioração precoce. O parto será planejado entre 34-37 semanas, dependendo da evolução.

(B) ✗ **INCORRETA.** A alteração da RCP **não** indica interrupção imediata quando o ducto venoso está normal. Esse é um erro conceitual comum! A RCP alterada representa um mecanismo compensatório — o feto está se adaptando à hipóxia crônica priorizando o fluxo cerebral. As diretrizes ISUOG 2023 são claras: a indicação de parto imediato ocorre quando há alteração do ducto venoso (onda A ausente ou reversa), não apenas por RCP alterada. Interromper imediatamente com 33 semanas exporia o feto a riscos significativos de prematuridade sem necessidade.

(C) ✗ **INCORRETA.** O acompanhamento ambulatorial semanal é insuficiente para este caso. Com RCF confirmada, RCP alterada e idade gestacional de 33 semanas, a paciente necessita de **internação** para vigilância intensiva. A reavaliação deve ser feita em 48-72 horas, não semanalmente. A conduta ambulatorial seria adequada apenas para casos de RCF leve com Doppler normal, onde o parto pode ser aguardado até 37 semanas com acompanhamento periódico.

(D) ✗ **INCORRETA.** A indução com misoprostol **não** está indicada neste caso por dois motivos principais. Primeiro, fetos com RCF e Doppler alterado têm reserva de oxigênio limitada e podem não tolerar as contrações uterinas do trabalho de parto — a cesariana é a via preferencial. Segundo, a idade gestacional de 33 semanas com RCP alterada mas DV normal não exige parto em 48 horas; há janela para vigilância e amadurecimento fetal. A conduta é reavaliação com Doppler, não indução automática.

RESUMO (TLDR)**Manejo da RCF: O Que Realmente Importa?**

A decisão de parto na RCF depende do **equilíbrio entre risco de prematuridade e risco de óbito fetal**.

1. A Cascata do Doppler

- **AU alterada** → Problema na placenta
- **RCP/ACM alterada** → Feto compensando (redistribuição)
- **DV alterado** → Acidose fetal → EMERGÊNCIA

2. Timing do Parto

- RCF + Doppler normal: **37 semanas**
- RCP/ACM alterada + DV normal: **34-37 semanas** (vigilância)
- Diástole zero: **34 semanas**
- DV alterado: **Imediato**

3. Pérola

A RCP é o marcador mais sensível na RCF tardia (≥ 32 sem). Mas RCP alterada com DV normal = compensação, não acidose — permite vigilância!

QUESTÃO 27 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Cuidados Pré-Natais ■ Gabarito: A

Gestante de 32 anos, G2P1A0, comparece à consulta de pré-natal na UBS com 30 semanas de gestação. Refere movimentação fetal preservada e nega perdas vaginais. Exames laboratoriais do segundo trimestre sem alterações. Ao exame físico: PA 118x76 mmHg, peso 72 kg (ganho de 8 kg desde o início da gestação), altura uterina 27 cm. A palpação obstétrica está representada na figura. Considerando os achados do exame físico obstétrico e a curva de altura uterina por idade gestacional, é correto afirmar que:

- (A) ✓ a estática fetal é longitudinal cefálica com dorso à direita e a altura uterina está adequada para a idade gestacional.
(B) a estática fetal é longitudinal pélvica com dorso à direita e a altura uterina está diminuída.
(C) a estática fetal é longitudinal cefálica com dorso à esquerda e a altura uterina está diminuída.
(D) a estática fetal é transversa córmica com dorso superior e a altura uterina está adequada para a idade gestacional.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A análise integrada do exame obstétrico confirma esta alternativa. Na **palpação** (manobras de Leopold-Zweifel): o 1º tempo identifica polo pélvico no fundo uterino (irregular, volumoso e mole), indicando apresentação **cefálica**; o 2º tempo revela superfície lisa e contínua à **direita** (dorso fetal) e irregularidades à esquerda (membros); a situação é **longitudinal** (eixos paralelos). Quanto à **altura uterina**: 27 cm para 30 semanas encontra-se dentro da faixa de normalidade na curva de crescimento (entre os percentis 10 e 90), configurando AU **adequada** para a idade gestacional. Esse padrão indica crescimento fetal compatível com a idade gestacional e pré-natal sem intercorrências.

(B) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa erra a apresentação fetal. Na palpação obstétrica representada, o polo pélvico (irregular, volumoso e mole) está no **fundo** uterino, indicando apresentação **cefálica**, e não pélvica. Quando temos apresentação pélvica, o polo cefálico (duro, regular, liso e rechaçável) é que ocupa o fundo. Além disso, a AU está adequada para 30 semanas, não diminuída — 27 cm encontra-se dentro dos limites de normalidade da curva.

(C) ✗ **INCORRETA.** Dois erros nesta alternativa. Primeiro, a posição do dorso está incorreta: a imagem mostra claramente o dorso fetal à **direita** (superfície lisa e contínua), não à esquerda. Segundo, a interpretação da AU é inadequada: 27 cm para 30 semanas está dentro dos limites de normalidade na curva de altura uterina, entre os percentis 10 e 90, configurando AU **adequada**, e não diminuída.

(D) ✗ **INCORRETA.** A situação transversa (córmica) ocorre quando o maior eixo fetal é perpendicular ao eixo uterino, com polo cefálico em uma fossa ilíaca e polo pélvico na outra. Nesse caso, ao palpar o fundo uterino, não se identifica nenhum polo — sente-se o dorso ou os membros. A imagem claramente demonstra polo pélvico no fundo, indicando situação **longitudinal**, e não transversa.

RESUMO (TLDR)**Exame Físico Obstétrico: O Que Realmente Importa?**

O exame físico no pré-natal é sua ferramenta de rastreio quando não há USG disponível.

1. Manobras de Leopold-Zweifel

- **1º tempo:** Identifica polo no fundo → define SITUAÇÃO e sugere APRESENTAÇÃO
- **2º tempo:** Localiza o dorso → define POSIÇÃO
- **3º e 4º tempos:** Confirmam apresentação e insinuação

2. Altura Uterina

- Entre 20-32 semanas: AU (cm) ≈ IG (semanas)
- AU entre p10 e p90: **adequada**
- AU < p10: Suspeitar de RCF → USG obrigatória
- AU > p90: Suspeitar de macrosomia/polidramnia

3. Pérola

Polo pélvico (grande, irregular, mole) no fundo = apresentação CEFÁLICA. Não confunda o polo no fundo com a apresentação!

QUESTÃO 28 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Parto Instrumental e Cirúrgico ■ Gabarito: A

Gestante de 28 anos, secundigesta, com 40 semanas de idade gestacional, está em trabalho de parto ativo há 4 horas. Evolui para dilatação total, bolsa rota espontaneamente há 2 horas, com líquido amniótico claro. A cardiotocografia demonstra bradicardia fetal sustentada de 90 bpm nos últimos 5 minutos. Ao toque vaginal: apresentação cefálica fletida, variedade de posição occipito-púbica, plano +3 de De Lee, bacia proporcional. A paciente encontra-se com analgesia peridural efetiva e bexiga vazia. Considerando a necessidade de extração fetal imediata, o instrumento mais adequado para resolução desse parto é o fórceps de

- (A) ✓ **Simpson.**
- (B) Kielland.
- (C) Piper.
- (D) Barton.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** O **Fórceps de Simpson** é o instrumento de escolha para este caso. Perceba que a paciente apresenta todas as condições favoráveis: dilatação total, bolsa rota, cabeça em plano +3 (fórceps de saída), variedade de posição **occipito-púbica** (direta anterior). Como não há necessidade de rotação (a cabeça já está com o occipício voltado para a sínfise púbica), precisamos apenas de um instrumento de **tração**. O Simpson, com sua curvatura pélvica e cefálica bem definidas e articulação fixa, é ideal para essa função. O estudo RALES... ops, contexto errado! Aqui o conceito é simples: Simpson = tração = variedades diretas.

(B) ✗ **INCORRETA.** O **Fórceps de Kielland** é o instrumento de **rotação**, indicado quando a cabeça fetal está em variedades transversas (OET, ODT) ou posteriores oblíquas que necessitam de rotação $\geq 45^\circ$. Sua característica marcante é a articulação de deslize e a ausência de curvatura pélvica acentuada, permitindo girar a cabeça dentro do canal de parto. No caso em questão, a paciente está em **OP** (occipito-púbica), uma variedade direta que não necessita de rotação. Usar o Kielland seria inadequado e aumentaria o risco de complicações sem benefício.

(C) ✗ **INCORRETA.** O **Fórceps de Piper** é exclusivo para o **parto pélvico vaginal**, sendo utilizado para extrair a cabeça derradeira após a saída do corpo fetal. Suas hastes longas e curvatura específica foram desenhadas para essa função única. No caso apresentado, temos uma apresentação **cefálica**, portanto o Piper não tem nenhuma aplicabilidade. Grave: Piper = pélvico = cabeça derradeira.

(D) ✗ **INCORRETA.** O **Fórceps de Barton** é um instrumento histórico, praticamente em desuso na obstetrícia moderna. Era indicado para variedades transversas em pelvis andróides (achatadas). Seu ramo posterior articulado tinha como objetivo permitir aplicação em situações específicas que hoje são resolvidas de outras formas (cesariana ou Kielland). Além disso, o caso apresenta uma variedade direta (OP), sem necessidade de rotação, tornando o Barton completamente inadequado.

RESUMO (TLDR)**Fórceps Obstétrico: O Que Realmente Importa?**

A escolha do fórceps depende fundamentalmente da **variedade de posição** e da **necessidade de rotação**.

1. Os Três Protagonistas

- **Simpson:** Tração (variedades diretas OP/OS, rotação $< 45^\circ$)
- **Kielland:** Rotação (transversas, posteriores, assinclitismo)
- **Piper:** Exclusivo para cabeça derradeira no parto pélvico

2. Pré-requisitos (APLICAR)

- Anestesia, Pelve proporcional, Livre canal, Insinuação, Colo dilatado, Ausência de desproporção, Reconhecer variedade

3. Pérola de Prova

Variedade direta (OP ou OS) em plano baixo (+2, +3) = **Simpson** = Tração pura!

QUESTÃO 29 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Infecções na Gestação ■ Gabarito: C

Gestante de 32 anos, G2P1, com 28 semanas de idade gestacional, comparece à UBS com quadro de febre (38,5°C), diarreia aquosa e mialgia há 2 dias. Relata ter consumido queijo artesanal não pasteurizado em churrasco familiar há 5 dias. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, abdome gravídico com tônus uterino normal e ausência de contrações. A frequência cardíaca fetal é de 160 bpm. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada para este caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Prescrever sintomáticos e acompanhamento ambulatorial, pois gastroenterites virais são autolimitadas na gestação.
- (B) Solicitar coprocultura e aguardar resultado para iniciar antibioticoterapia específica.
- (C) ✓ **Encaminhar para internação hospitalar e iniciar ampicilina endovenosa empiricamente.**
- (D) Prescrever metronidazol via oral e retorno em 48 horas para reavaliação.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Esta alternativa comete um erro grave ao assumir que toda gastroenterite na gestante é viral e autolimitada. Perceba que o enunciado fornece uma pista epidemiológica crucial: consumo de queijo artesanal não pasteurizado. Este é o cenário clássico de transmissão de *Listeria monocytogenes*. A listeriose gestacional tem alto potencial de transmissão vertical e pode causar consequências fetais catastróficas (aborto, morte fetal, sepse neonatal), mesmo quando a mãe apresenta sintomas leves. Conduta expectante com sintomáticos seria negligência neste contexto.

(B) **X INCORRETA.** Aguardar resultado de coprocultura para iniciar tratamento é uma conduta inadequada por dois motivos principais: (1) a coprocultura tem baixa sensibilidade para *Listeria*, pois a bactéria pode ser portada assintomaticamente no TGI, e (2) na gestante febril com suspeita de listeriose, o tratamento deve ser **empírico e imediato** devido ao alto risco fetal. O exame de escolha para diagnóstico é a hemocultura, não a coprocultura. Entretanto, mesmo a hemocultura não deve retardar o início do tratamento.

(C) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta adequada para a gestante com suspeita de listeriose. A combinação de febre + sintomas gastrointestinais + história de consumo de laticínio não pasteurizado configura alta suspeita clínica de listeriose. A **ampicilina endovenosa** é o antibiótico de primeira linha, pois a *Listeria monocytogenes* é intrinsecamente resistente às cefalosporinas. A internação hospitalar é obrigatória para: (1) garantir antibioticoterapia parenteral adequada, (2) monitorização fetal contínua, e (3) vigilância de sinais de corioamnionite ou trabalho de parto prematuro.

(D) **X INCORRETA.** O metronidazol não é eficaz contra *Listeria monocytogenes*. Esta droga tem espectro de ação contra anaeróbios e alguns protozoários (como *Giardia* e *Entamoeba histolytica*), mas não cobre a *Listeria*, que é um bacilo gram-positivo aeróbio facultativo. Além disso, o tratamento ambulatorial com retorno em 48 horas é inadequado para uma gestante com suspeita de listeriose, que requer internação imediata para antibioticoterapia endovenosa e monitorização fetal.

RESUMO (TLDR)**Listeriose na Gestação: O Que Realmente Importa?**

A listeriose é uma infecção bacteriana grave na gestante, transmitida por alimentos contaminados.

1. Quando Suspeitar?

- Febre + sintomas gripais ou gastrointestinais
- História de consumo de laticínios não pasteurizados, embutidos frios ou patês
- Especialmente no 3º trimestre

2. Por que é Grave?

- Alto risco de transmissão vertical
- Pode causar aborto, morte fetal, parto prematuro e sepse neonatal
- A mãe pode estar bem enquanto o feto está gravemente comprometido

3. Conduta

- **Internação obrigatória**
- **Ampicilina EV (2g 4/4h)** — tratamento empírico imediato
- **Jamais usar cefalosporinas** (resistência intrínseca)

4. Pérola

Não espere cultura para tratar! O tempo é crucial para o prognóstico fetal.

QUESTÃO 30 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Parto Instrumental e Cirúrgico ■ Gabarito: C

Gestante de 32 anos, secundigesta com cesariana prévia há 3 anos por apresentação pélvica, encontra-se com 39 semanas de idade gestacional. Pré-natal sem intercorrências, ultrassonografia atual evidencia feto único em apresentação cefálica, peso fetal estimado de 3.200g e placenta corporal anterior. Durante consulta na UBS, relata desejo de tentar parto vaginal. Ao exame obstétrico: altura uterina compatível, batimentos cardíofetais de 140 bpm, colo médio, posterior, pérvio para 1 cm. No prontuário da cesariana anterior, consta descrição cirúrgica de histerotomia corporal longitudinal. Considerando as evidências atuais sobre trabalho de parto após cesariana (TOLAC), qual elemento do caso clínico constitui contraindicação absoluta para a tentativa de parto vaginal?

- (A) Peso fetal estimado acima de 3.000g.
- (B) Antecedente de cesariana por apresentação pélvica.
- (C) ✓ **Tipo de incisão uterina realizada na cesariana prévia.**
- (D) Localização anterior da placenta.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O peso fetal estimado de 3.200g está dentro da normalidade e não representa macrosomia (definida como > 4.000g). Mesmo em casos de macrosomia, esta constitui uma contraindicação **relativa**, não absoluta, ao TOLAC. A gestante poderia ser candidata ao trabalho de parto com adequado acompanhamento e discussão dos riscos aumentados.

(B) **X INCORRETA.** A cesariana prévia por apresentação pélvica é considerada uma indicação **não-recorrente**, ou seja, a condição que motivou a cesariana não tende a se repetir na gestação atual. Na verdade, gestantes com indicações não-recorrentes apresentam maior taxa de sucesso de VBAC comparadas àquelas com indicações recorrentes (como falha de progressão). Portanto, esse antecedente é um fator **favorável**, não uma contraindicação.

(C) ✓ **CORRETA.** A histerotomia corporal longitudinal (também chamada de incisão clássica) constitui **contraindicação absoluta** ao TOLAC. Conforme as Diretrizes do Ministério da Saúde (2016, atualizadas em 2025): "*O trabalho de parto e parto vaginal não é recomendado para mulheres com cicatriz uterina longitudinal de cesariana anterior*". Esse tipo de cicatriz apresenta risco significativamente elevado de ruptura uterina durante o trabalho de parto, tornando a tentativa de parto vaginal inaceitavelmente perigosa.

(D) **X INCORRETA.** A localização anterior da placenta no corpo uterino é uma variação fisiológica normal. O que contraindica o parto vaginal seria a **placenta prévia** (inserção no segmento inferior, cobrindo parcial ou totalmente o orifício interno do colo). A placenta "corporal anterior" simplesmente indica que ela está implantada na parede anterior do corpo uterino, acima do segmento inferior, o que não interfere na via de parto.

RESUMO (TLDR)**TOLAC e Contraindicações: O Que Realmente Importa?**

A tentativa de parto vaginal após cesariana (TOLAC) depende fundamentalmente do **tipo de cicatriz uterina**.

1. Contraindicações Absolutas

- Cicatriz corporal/clássica (longitudinal)
- Ruptura uterina prévia
- Miomectomia transmural

2. Fatores Relativos (não proíbem, mas reduzem sucesso)

- DCP prévia, macrosomia, intervalo < 18 meses

3. Pérola

A cicatriz na **pele** não indica o tipo de cicatriz no **útero**. Revisar sempre o relatório cirúrgico!

QUESTÃO 31 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Cuidados Pré-Natais ■ Gabarito: C

Mulher de 28 anos, previamente hígida, comparece à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com queixa de dor abdominal em baixo ventre há 6 horas, de início súbito, associada a sangramento vaginal escuro e escasso. Refere atraso menstrual de 7 semanas. Nega uso de contraceptivos. Ao exame físico: PA 85x60 mmHg, FC 98 bpm, abdome doloroso à palpação profunda em fossa ilíaca direita com descompressão brusca positiva. Toque vaginal: colo amolecido, útero discretamente aumentado, dor intensa à mobilização do colo e empastamento em fundo de saco posterior. Exames laboratoriais: hemoglobina 10,2 g/dL; beta-hCG sérico quantitativo: 2.500 mUI/mL. Ultrassonografia transvaginal: útero vazio, endométrio espessado, massa complexa em anexo direito de 3,5 cm e líquido livre em fundo de saco de Douglas. Considerando a integração dos achados clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos, a conduta mais adequada para esta paciente é:

- (A) Repetir dosagem de beta-hCG em 48 horas para avaliar curva de duplicação.
- (B) Administrar metotrexato intramuscular em dose única.
- (C) ✓ **Indicar laparoscopia diagnóstica e terapêutica.**
- (D) Realizar curetagem uterina para diagnóstico histopatológico.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A dosagem seriada de beta-hCG em 48 horas para avaliar a curva de duplicação é uma estratégia válida para **pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas** com diagnóstico incerto (beta-hCG abaixo da zona discriminatória ou ultrassonografia inconclusiva). No caso apresentado, a paciente já apresenta beta-hCG acima da zona discriminatória com útero vazio, massa anexial identificada e, principalmente, **sinais de hemoperitônio** (líquido livre + irritação peritoneal). Aguardar 48 horas poderia resultar em deterioração hemodinâmica e colocar a vida da paciente em risco. Esta conduta seria adequada apenas se não houvesse sinais de urgência.

(B) **X INCORRETA.** O metotrexato é uma excelente opção para o tratamento conservador da gravidez ectópica íntegra, permitindo preservar a fertilidade sem cirurgia. Entretanto, esta paciente **não preenche os critérios de elegibilidade**. A presença de líquido livre em fundo de saco de Douglas associada a sinais clínicos de irritação peritoneal (descompressão brusca positiva, dor à mobilização do colo) indica hemoperitônio, o que representa **contraindicação absoluta** ao uso de metotrexato. Além disso, a massa de 3,5 cm está no limite superior e a instabilidade hemodinâmica iminente (taquicardia) reforça a necessidade de abordagem cirúrgica.

(C) **✓ CORRETA.** A paciente apresenta quadro clínico compatível com **gravidez ectópica complicada** (provável ruptura tubária): atraso menstrual, dor abdominal, sangramento vaginal, beta-hCG acima da zona discriminatória com útero vazio, massa anexial e evidência de hemoperitônio (líquido livre + sinais peritoneais). A **laparoscopia diagnóstica e terapêutica** é a conduta de escolha, pois permite confirmar o diagnóstico, avaliar a extensão do sangramento e realizar o tratamento definitivo (salpingostomia ou salpingectomia) no mesmo procedimento. A via laparoscópica é preferível por ser menos invasiva, com menor tempo de recuperação e melhores resultados estéticos, desde que a paciente não esteja em choque hemorrágico franco.

(D) **X INCORRETA.** A curetagem uterina **não tem papel no diagnóstico** de gravidez ectópica. Esta conduta seria apropriada em casos de abortamento incompleto ou gestação anembrionada, onde há tecido trofoblástico retido **dentro do útero**. Na gravidez ectópica, o produto conceptual está **fora** da cavidade uterina, e a curetagem apenas encontraria reação decidual (deciduose) sem vilosidades coriônicas. Além de não resolver o problema, atrasaria o tratamento adequado e exporia a paciente a riscos desnecessários. O diagnóstico de ectópica é feito pela correlação entre beta-hCG e ultrassonografia, não por histopatologia endometrial.

RESUMO (TLDR)

Gravidez Ectópica: O Que Realmente Importa?

Na urgência obstétrica, o reconhecimento rápido da gravidez ectópica complicada salva vidas.

1. Diagnóstico

- Beta-hCG > zona discriminatória + útero vazio = ectópica provável
- Zona discriminatória TV: 1.500-2.000 mUI/mL
- Líquido livre + sinais peritoneais = sangramento ativo

2. Critérios para Metotrexato

- Estabilidade hemodinâmica
- Beta-hCG < 5.000, massa < 3,5 cm, sem BCF
- **SEM líquido livre significativo**

3. Indicação Cirúrgica

- Instabilidade ou sinais de ruptura
- Contra-indicação ao metotrexato
- Laparoscopia é a via preferencial

Pérola

Líquido livre + dor = cirurgia. Não perca tempo com beta-hCG seriado ou metotrexato em paciente sintomática!

QUESTÃO 32 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Dor pélvica ■ Gabarito: A

Mulher de 17 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de cólicas menstruais intensas há 3 anos, que se iniciam algumas horas antes do fluxo menstrual e persistem por 2 a 3 dias. Refere que as dores a impedem de frequentar a escola durante o período menstrual. Nega dispareunia, sangramento intermenstrual ou corrimento vaginal. Menarca aos 12 anos, ciclos regulares de 28 dias. Virgem, sem desejo de contracepção no momento. Exame físico: abdome sem visceromegalias, indolor à palpação profunda fora do período menstrual. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta inicial mais adequada é

(A) ✓ **prescrever anti-inflamatório não esteroide.**

(B) solicitar ultrassonografia pélvica.

(C) indicar videolaparoscopia diagnóstica.

(D) iniciar progestágeno contínuo.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A paciente apresenta quadro clássico de **dismenorreia primária**: adolescente, dor em cólica que se inicia antes do fluxo e dura 2-3 dias, sem dispareunia ou outros sinais de alarme, exame físico normal. O diagnóstico é clínico! Como ela é virgem e não deseja contracepção, os **AINEs são a primeira linha de tratamento**. Eles inibem a ciclooxigenase, bloqueando a síntese de prostaglandinas responsáveis pelas contrações uterinas e pela dor. Devem ser iniciados ao primeiro sinal de dor ou 1-2 dias antes da menstruação esperada, com eficácia de 70-90%.

(B) ✗ **INCORRETA.** A ultrassonografia pélvica **não é necessária** em casos típicos de dismenorreia primária. Perceba que a paciente tem história clássica (início na adolescência, padrão temporal típico, sem sinais de alarme) e exame físico normal. Solicitar USG nesse contexto seria investigação desnecessária. A ultrassonografia está indicada quando há falha terapêutica após 3-6 meses de tratamento adequado ou quando existem sinais sugestivos de dismenorreia secundária (dor progressiva, dispareunia, sangramento anormal).

(C) ✗ **INCORRETA.** A videolaparoscopia é o padrão-ouro para diagnóstico de endometriose, mas **jamais é indicada como exame inicial** para dismenorreia. Trata-se de procedimento invasivo, reservado para casos de forte suspeita de endometriose que não responderam ao tratamento clínico ou que necessitam de abordagem cirúrgica terapêutica. Nesta paciente com quadro típico de dismenorreia primária, sem sinais de alarme, a laparoscopia seria completamente desproporcional.

(D) ✗ **INCORRETA.** O progestágeno contínuo (como dienogeste ou desogestrel) é uma excelente opção terapêutica para dismenorreia, porém **não é a primeira escolha** neste caso específico. A paciente referiu que é virgem e não deseja contracepção no momento. Os AINEs são preferíveis como primeira linha quando não há desejo contraceptivo, pois são usados apenas durante o período menstrual (poucos dias por mês), enquanto o progestágeno exige uso contínuo. Se houver falha dos AINEs ou desejo futuro de contracepção, o progestágeno passa a ser uma opção adequada.

RESUMO (TLDR)

Dismenorreia Primária: O Essencial

Dor menstrual **sem causa orgânica**, comum em adolescentes, causada por **excesso de prostaglandinas**.

1. Diagnóstico

- **Clínico!** História típica + exame normal = não precisa de USG
- Red flags → investigar secundária

2. Tratamento de Primeira Linha

- **Sem desejo de contracepção** → AINE (ibuprofeno, naproxeno)
- **Com desejo de contracepção** → ACO ou progestágeno

3. Pérola da Prova

Nunca peça laparoscopia como exame inicial! USG só se houver falha terapêutica ou sinais de alarme.

QUESTÃO 33 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Contracepção ■ Gabarito: C

Paciente de 32 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para orientação sobre métodos contraceptivos. Relata que está amamentando exclusivamente um bebê de 5 semanas de vida, nascido de parto vaginal sem intercorrências. Nega comorbidades, não faz uso de medicamentos e não apresentou complicações no puerpério. Ao exame físico, útero bem involuído e lóquios fisiológicos. Considerando os critérios de elegibilidade da OMS para uso de contraceptivos, qual método pode ser iniciado neste momento?

- (A) Anticoncepcional hormonal combinado oral.
- (B) Anel vaginal combinado.
- (C) ✓ **Dispositivo intrauterino de cobre.**
- (D) Adesivo transdérmico combinado.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O anticoncepcional hormonal combinado oral contém **estrogênio + progestagênio**. Em lactantes com menos de 6 semanas pós-parto, os métodos combinados são classificados como **Categoria 4** pela OMS (risco inaceitável à saúde). O estrogênio pode reduzir a produção de leite materno e aumentar o risco de tromboembolismo venoso, que já está elevado no puerpério.

(B) **X INCORRETA.** O anel vaginal combinado (etinilestradiol + etonogestrel) também é um método hormonal combinado, contendo estrogênio. Assim como a pílula combinada, está classificado como **Categoria 4** para lactantes com menos de 6 semanas pós-parto. O fato de ser de absorção vaginal não elimina os riscos sistêmicos do estrogênio.

(C) ✓ **CORRETA.** O DIU de cobre é um método **não hormonal** que não interfere na lactação nem aumenta o risco tromboembólico. Com 5 semanas pós-parto e involução uterina confirmada ao exame físico, ele é classificado como **Categoria 2** (vantagens superam riscos), sendo a única opção adequada entre as alternativas. A inserção entre 48h e 4 semanas seria Categoria 3, mas após 4 semanas com involução uterina confirmada, torna-se seguro.

(D) **X INCORRETA.** O adesivo transdérmico combinado contém **etinilestradiol + norelgestromina**, sendo um método hormonal combinado. Para lactantes com menos de 6 semanas pós-parto, é **Categoria 4** pelos mesmos motivos dos demais combinados: risco de redução da lactação e aumento do risco tromboembólico.

RESUMO (TLDR)**Contracepção no Puerpério: O Que Realmente Importa?**

Em lactantes, os métodos combinados (com estrogênio) são **contraindicados** nas primeiras 6 semanas pós-parto.

1. O Problema do Estrogênio

- Reduz produção de leite
- Aumenta risco tromboembólico
- Categoria 4 (contraindicado) em < 6 semanas

2. Alternativas Seguras

- **DIU de cobre:** Categoria 2 se ≥4 semanas com involução OK
- **Progestagênios isolados:** Categoria 2 desde o início
- **Inserção imediata** (até 48h): também é opção

3. Pérola

Evite DIU entre 48h e 4 semanas (risco de expulsão). Fora dessa janela, é excelente opção para lactantes!

QUESTÃO 34 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Infecções do trato genital ■ Gabarito: C

Mulher de 28 anos procura a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com queixa de lesões dolorosas em região genital há 5 dias. Refere que, antes do aparecimento das lesões, sentiu ardência e formigamento no local. Nega corrimento vaginal. Ao exame físico, observam-se múltiplas úlceras rasas, de bordas irregulares, agrupadas e coalescentes em pequenos lábios, com fundo eritematoso sem secreção purulenta. Há linfonodomegalia inguinal bilateral, discretamente dolorosa à palpação. A paciente relata ser o primeiro episódio desse tipo de lesão. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta terapêutica mais adequada?

- (A) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular, dose única.
- (B) Azitromicina 1 g, via oral, dose única.
- (C) ✓ **Aciclovir 400 mg, via oral, três vezes ao dia, por 7 a 10 dias.**
- (D) Doxiciclina 100 mg, via oral, duas vezes ao dia, por 21 dias.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A **Penicilina benzatina 2,4 milhões UI IM em dose única** é o tratamento de escolha para a **Sífilis Primária** (e secundária). Na sífilis, a úlcera é caracteristicamente **única, indolor**, com bordas endurecidas e fundo limpo. O quadro descrito na questão apresenta múltiplas úlceras dolorosas precedidas por pródromo, o que é incompatível com sífilis e característico de herpes genital.

(B) **X INCORRETA.** A **Azitromicina 1g VO em dose única** é o tratamento de primeira escolha para o **Cancro Mole** (*Haemophilus ducreyi*). Embora o cancro mole também seja doloroso, suas úlceras têm **fundo sujo/purulento** (e não eritematoso/limpo como no herpes) e a adenopatia fistuliza por orifício único (bubão). O quadro clínico com vesículas prévias, múltiplas úlceras coalescentes e fundo limpo é típico de herpes.

(C) ✓ **CORRETA.** O quadro clínico descrito é clássico de **Herpes Genital em primeiro episódio**: pródromo (ardência/formigamento), múltiplas úlceras dolorosas, rasas, agrupadas e coalescentes, com fundo limpo/eritematoso, e adenopatia inguinal bilateral que não fistuliza. O tratamento preconizado pelo PCDT do Ministério da Saúde para o primeiro episódio é **Aciclovir 400 mg VO, 3x/dia, por 7 a 10 dias**. Os antivirais reduzem a duração e a gravidade dos sintomas.

(D) **X INCORRETA.** A **Doxiciclina 100 mg VO, 2x/dia, por 21 dias** é o tratamento de escolha para o **Linfogranuloma Venéreo (LGV)**, causado por *Chlamydia trachomatis* (sorotipos L1-L3). No LGV, a úlcera é tipicamente **indolor** e fugaz (muitas vezes passa despercebida), e o achado principal é a adenopatia inguinal que fistuliza por **múltiplos orifícios** ("bico de regador"). O quadro apresentado não corresponde a essa etiologia.

RESUMO (TLDR)**Herpes Genital: O Que Realmente Importa?**

O herpes genital é a causa mais comum de úlcera genital dolorosa.

1. Tríade Diagnóstica

- **Pródromo:** Ardência/formigamento antes da lesão
- **Morfologia:** Vesículas → úlceras múltiplas, coalescentes, fundo limpo
- **Adenopatia:** Bilateral, dolorosa, **NÃO** fistuliza

2. Tratamento

- **Primeiro episódio:** Aciclovir 400mg VO, 3x/dia, **7-10 dias**
- **Recorrência:** Aciclovir 400mg VO, 3x/dia, **5 dias**

3. Pérola

Se a questão mencionar "formigamento antes da lesão" = Herpes. Não erre!

QUESTÃO 35 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Lesões precursoras ■ Gabarito: B

Mulher de 42 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com resultado de citologia oncológica colhida há três semanas. Refere menarca aos 12 anos, três gestações com partos vaginais, vida sexual ativa com parceiro único há 15 anos. Nega comorbidades e imunossupressão. O laudo citopatológico descreve: amostra satisfatória, presença de representação da junção escamocolumnar, células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão de alto grau (ASC-H). Considerando as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde, qual a conduta mais adequada para esta paciente?

- (A) Repetir a citologia oncológica em 6 meses.
- (B) ✓ **Encaminhar para colposcopia imediata.**
- (C) Solicitar teste de DNA-HPV oncogênico.
- (D) Repetir a citologia oncológica em 12 meses.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Repetir a citologia em 6 meses é a conduta adequada para **ASC-US em mulheres ≥30 anos**, não para ASC-H. O ASC-H indica que o citopatologista visualizou células atípicas onde não foi possível descartar lesão de alto grau. Aguardar 6 meses poderia permitir a progressão de uma lesão potencialmente grave. A conduta correta é investigação imediata com colposcopia.

(B) **✓ CORRETA.** O resultado de **ASC-H** (células escamosas atípicas não podendo excluir alto grau) representa uma situação de alerta no rastreamento cervical. Segundo as Diretrizes do Ministério da Saúde, diante desse achado, a conduta é **encaminhamento imediato para colposcopia**, independentemente da idade da paciente. O risco de haver uma NIC 2/3 (lesão de alto grau) subjacente é significativo (24-94%), justificando a investigação invasiva sem demora.

(C) **X INCORRETA.** Solicitar teste de DNA-HPV oncogênico não é a conduta indicada quando já temos um resultado citológico de ASC-H. O teste HPV é utilizado como método de **rastreamento primário** (nas novas diretrizes de 2024) ou como teste reflexo em situações específicas (ex: HPV não-16/18). No ASC-H, já existe indicação clara de investigação invasiva; realizar o teste HPV apenas atrasaria a colposcopia sem mudar a conduta.

(D) **X INCORRETA.** Repetir a citologia em 12 meses seria a conduta para **ASC-US em mulheres entre 25-29 anos**. No ASC-H, não existe indicação de seguimento expectante com repetição de citologia. O achado citológico já demonstra suspeita suficiente para justificar investigação imediata. Esperar 12 meses seria inadequado e potencialmente perigoso.

RESUMO (TLDR)

ASC-H: O Que Realmente Importa?

O ASC-H é o "sinal de alerta vermelho" da citologia cervical.

1. A Diferença Crucial

- **ASC-US:** Provavelmente nada grave → REPETE citologia
- **ASC-H:** Pode ser alto grau → COLPOSCOPIA imediata

2. Por Que Não Esperar?

- Risco de NIC 2/3 no ASC-H: até 94%
- Citologia tem limitações; colposcopia confirma

3. Pérola de Prova

Se aparecer "H" no resultado (ASC-H, HSIL), vai para colposcopia. Não existe "esperar para ver" nessas situações!

QUESTÃO 36 ■ Ginecologia e Obstetrícia ■ Câncer endometrial ■ Gabarito: D

Mulher de 62 anos procura a UBS com queixa de sangramento vaginal há 3 semanas. Nega uso de terapia hormonal. Antecedentes: menopausa aos 55 anos, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade grau II (IMC 37 kg/m²). Ao exame especular, observa-se pequena quantidade de sangue proveniente do orifício cervical externo. Toque vaginal sem massas palpáveis. Ultrassonografia transvaginal evidencia endométrio heterogêneo, com espessura de 12 mm. Considerando a suspeita diagnóstica e a necessidade de confirmação, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Repetir ultrassonografia transvaginal em 6 meses.
 (B) Iniciar progestágeno oral contínuo e reavaliar.
 (C) Solicitar ressonância magnética de pelve.
 (D) **✓ Indicar histeroscopia com biópsia endometrial.**

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - Repetir ultrassonografia em 6 meses é **conduta absolutamente inadequada**. A paciente apresenta sangramento pós-menopausa associado a espessamento endometrial (12 mm) e múltiplos fatores de risco para câncer de endométrio. A conduta expectante apenas atrasaria o diagnóstico de uma potencial neoplasia, comprometendo o prognóstico. Sangramento pós-menopausa exige investigação histológica imediata, não observação.

(B) **X INCORRETA** - Iniciar progestágeno sem diagnóstico histológico é **conduta de risco**. O progestágeno pode ter papel no tratamento da hiperplasia endometrial **já diagnosticada** (especialmente em pacientes com desejo de preservar fertilidade), mas **jamaís** deve ser iniciado empiricamente em paciente com suspeita de câncer. Primeiro, confirma-se o diagnóstico; depois, define-se o tratamento.

(C) **X INCORRETA** - A ressonância magnética de pelve é exame de **estadiamento**, não de diagnóstico. Ela avalia a profundidade de invasão miometrial, extensão cervical e auxilia no planejamento cirúrgico **após a confirmação histopatológica** do câncer. Solicitar RM antes da biópsia é inverter a sequência lógica de investigação e desperdiçar recursos.

(D) **✓ CORRETA** - A histeroscopia com biópsia endometrial é o **padrão-ouro** para diagnóstico de patologia endometrial. Permite visualização direta da cavidade uterina, identificação de lesões focais (pólipos, áreas suspeitas) e coleta de material para análise histopatológica no local exato da alteração. Em paciente pós-menopausa com sangramento e endométrio espessado (12 mm), a

indicação é inequívoca. A biópsia confirmará se há hiperplasia, câncer ou outra patologia, direcionando o tratamento adequado.

RESUMO (TLDR)

Diagnóstico do Câncer de Endométrio: O Que Realmente Importa?

O sangramento pós-menopausa é o principal sinal de alerta e exige investigação obrigatória.

1. Quando Investigar?

- Sangramento pós-menopausa + endométrio $\geq 4\text{-}5\text{ mm}$ → **biópsia**
- Sangramento persistente → **biópsia** (mesmo com USG normal)
- Fatores de risco (obesidade, DM, tamoxifeno) → **menor limiar para indicar biópsia**

2. Como Investigar?

- **Padrão-ouro:** Histeroscopia com biópsia dirigida
- **Alternativa:** Biópsia por Pipelle (ambulatorial)
- **NÃO é padrão-ouro:** Curetagem (procedimento cego)

3. Pérola

RM é para estadiamento, não diagnóstico. Primeiro confirma a histologia, depois planeja o tratamento!

IV. Pediatria

QUESTÃO 37 ■ Pediatria ■ Desenvolvimento Infantil ■ Gabarito: B

Lactente de 14 meses, sexo masculino, é trazido pela mãe ao Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) após encaminhamento da UBS por suspeita de atraso no desenvolvimento. A mãe relata que a criança não fala nenhuma palavra com significado, não atende quando chamada pelo nome, não aponta para objetos de interesse e apresenta movimentos repetitivos com as mãos. Nega regressão de marcos previamente adquiridos. Ao exame: criança eutrófica, anda sem apoio desde os 12 meses, pega objetos com pinça, mas não os entrega quando solicitado, evita contato visual e não imita gestos. Perímetro cefálico no percentil 85. Audição testada e normal. A equipe multiprofissional discute o caso e, considerando a melhor conduta baseada em evidências para essa faixa etária, decide

- (A) solicitar cariótipo e ressonância magnética de crânio antes de qualquer intervenção.
- (B) ✓ **iniciar estimulação precoce intensiva e agendar reavaliação em reavaliação precoce em 1-2 meses.**
- (C) aguardar até os 24 meses para confirmar o diagnóstico antes de iniciar terapias.
- (D) encaminhar para avaliação neurológica e postergar intervenções até laudo definitivo.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Solicitar cariótipo e ressonância magnética de crânio **antes** de qualquer intervenção representa uma conduta ultrapassada e prejudicial. Embora a investigação etiológica possa ser indicada em casos selecionados (presença de dismorfias, microcefalia, regressão neurológica ou epilepsia), ela **nunca** deve postergar o início da estimulação precoce. Os exames podem ser realizados **em paralelo** às intervenções terapêuticas. Nosso paciente tem perímetro cefálico normal, sem dismorfias e sem regressão – não há indicação urgente de investigação complementar, e mesmo que houvesse, a terapia deveria começar imediatamente.

(B) ✓ **CORRETA.** Iniciar estimulação precoce intensiva é a conduta preconizada por todas as diretrizes atuais (AAP, SBP) quando há sinais de alerta para TEA, **independentemente de diagnóstico fechado**. A janela de maior plasticidade neuronal ocorre nos primeiros 3 anos de vida, e postergar intervenção significa desperdiçar oportunidades de desenvolvimento. A reavaliação em 1-2 meses permite monitorar a resposta terapêutica, aplicar instrumentos de triagem formais (M-CHAT-R/F aos 18 meses) e ajustar o plano terapêutico conforme evolução. O princípio é claro: **tratar precocemente, investigar em paralelo se necessário.**

(C) ✗ **INCORRETA.** Aguardar até os 24 meses para confirmar diagnóstico antes de iniciar terapias é uma conduta **obsoleta e prejudicial**. As evidências científicas demonstram que a intervenção comportamental intensiva iniciada antes dos 2 anos melhora significativamente os desfechos cognitivos, adaptativos e de linguagem. O conceito de "esperar para ver" (wait and see) foi abandonado pelas principais sociedades pediátricas. Sinais de alerta confiáveis para TEA podem ser identificados a partir dos 12 meses, e a intervenção deve começar tão logo sejam detectados.

(D) ✗ **INCORRETA.** Encaminhar para avaliação neurológica e postergar intervenções até laudo definitivo comete o mesmo erro das alternativas anteriores: condiciona a terapia a uma confirmação diagnóstica. O neurologista infantil é um parceiro importante na investigação etiológica e no manejo de comorbidades (como epilepsia), mas **não é um pré-requisito** para iniciar estimulação precoce. A avaliação especializada pode ocorrer em paralelo às intervenções terapêuticas. Cada mês de atraso no tratamento representa perda de oportunidades durante o período crítico de neuroplasticidade.

RESUMO (TLDR)

Sinais de Alerta para TEA: O Que Realmente Importa?

Crianças com sinais de alerta para TEA devem receber **intervenção imediata**, independentemente de diagnóstico fechado.

1. Sinais de Alerta Precoces (12-18 meses)

- Não atende ao nome
- Não aponta para mostrar interesse (ausência de atenção compartilhada)
- Ausência de palavras com significado
- Não imita gestos ou brincadeiras
- Estereotipias motoras

2. Conduta Correta

- **Iniciar estimulação precoce IMEDIATAMENTE**
- Investigação complementar em **paralelo** (se indicada)
- Reavaliação periódica com instrumentos validados (M-CHAT-R/F)

3. Pérola

O diagnóstico de TEA é **CLÍNICO (DSM-5)** – não depende de genética, neuroimagem ou EEG para iniciar tratamento. A janela crítica de neuroplasticidade (0-3 anos) não espera!

QUESTÃO 38 ■ Pediatria ■ Crescimento Infantil ■ Gabarito: C

Menino de 8 anos é levado pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após queda de bicicleta com escoriação em joelho. Durante o atendimento, a mãe questiona sobre a estatura do filho, pois ele é um dos menores da sala de aula. Informa que o pai mede 162 cm e a mãe 154 cm. Nascido a termo, peso e comprimento adequados, sem intercorrências neonatais. Nega doenças crônicas ou uso de medicamentos. Exame físico: bom estado geral, proporções corporais normais, estadiamento de Tanner G1P1. Antropometria: peso 23 kg (escore-Z entre -1 e 0), estatura 117 cm (escore-Z entre -2 e -3). Registro na caderneta há 12 meses mostrava estatura de 111 cm. A hipótese diagnóstica mais provável é

- (A) deficiência de hormônio do crescimento.
- (B) atraso constitucional do crescimento.
- (C) ✓ **baixa estatura familiar.**
- (D) hipotireoidismo congênito.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A deficiência de hormônio do crescimento (DGH) cursa caracteristicamente com **velocidade de crescimento baixa** (< 5 cm/ano). No caso apresentado, a VC é de 6 cm/ano, o que é absolutamente normal para a faixa etária. Além disso, crianças com DGH frequentemente apresentam atraso da idade óssea e podem ter proporções corporais alteradas (baixa estatura proporcional com tendência a obesidade central). O diagnóstico de DGH requer dois testes provocativos com pico de GH < 5-7 ng/mL, conforme o PCDT do Ministério da Saúde.

(B) **X INCORRETA.** O atraso constitucional do crescimento e puberdade (ACCP) apresenta VC normal, porém com **idade óssea atrasada** em relação à cronológica (geralmente > 2 anos de diferença) e **pais com estatura normal**. No caso, os pais são de baixa estatura (pai 162 cm, mãe 154 cm), o que resulta em estatura alvo baixa. O ACCP é típico de famílias com história de puberdade tardia, onde a criança "demora a crescer" mas atinge estatura final normal.

(C) ✓ **CORRETA.** A criança apresenta o perfil clássico de **Baixa Estatura Familiar (BEF)**: velocidade de crescimento normal (6 cm/ano), pais com baixa estatura (EA = 164,5 cm, abaixo do percentil 10), proporções corporais normais e desenvolvimento puberal adequado para a idade. Na BEF, a idade óssea é compatível com a idade cronológica, e a criança cresce seguindo seu canal genético, atingindo uma estatura final baixa, porém condizente com o potencial familiar.

(D) **X INCORRETA.** O hipotireoidismo congênito, se não tratado precocemente, causa baixa estatura com **velocidade de crescimento muito reduzida**, além de outros achados como atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, constipação, pele seca e bradicardia. No caso apresentado, a criança tem 8 anos, bom estado geral e VC normal, o que torna esse diagnóstico improvável. Vale lembrar que o hipotireoidismo congênito é rastreado pelo teste do pezinho e tratado precocemente no Brasil.

RESUMO (TLDR)**Baixa Estatura: O Que Realmente Importa?**

Na avaliação de baixa estatura, o raciocínio segue três passos obrigatórios.

1. Calcule a Velocidade de Crescimento (VC)

- VC ≥ 5 cm/ano no escolar → variante normal
- VC < 5 cm/ano → investigar causas patológicas

2. Diferencie as Variantes Normais

- **BEF:** Pais baixos + IO = IC → estatura final baixa
- **ACCP:** Pais normais + IO atrasada → estatura final normal

3. Pérola

Se a VC é normal e os pais são baixos, é Baixa Estatura Familiar. Não precisa de investigação extensa!

QUESTÃO 39 ■ Pediatria ■ Obesidade Infantil ■ Gabarito: C

Menino de 9 anos é levado pela mãe à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. A mãe refere que a criança passa grande parte do dia em atividades sedentárias e tem preferência por alimentos ultraprocessados. Ao exame físico: peso de 45 kg, altura de 1,30 m, circunferência abdominal de 78 cm (acima do percentil 90 para sexo e idade), pressão arterial de 118 x 78 mmHg (acima do percentil 90 para sexo, idade e estatura) e placas hiperocrômicas aveludadas em região cervical e axilas. Exames laboratoriais: glicemia de jejum de 98 mg/dL, triglicerídeos de 168 mg/dL e HDL-colesterol de 35 mg/dL. Considerando o quadro clínico e os achados laboratoriais, qual é a hipótese diagnóstica mais adequada?

- (A) Obesidade com resistência insulínica isolada, sem configurar síndrome metabólica.
(B) Sobrepeso com dislipidemia secundária, exigindo apenas orientação alimentar.
(C) ✓ **Obesidade associada à síndrome metabólica, com múltiplos fatores de risco presentes.**
(D) Diabetes mellitus tipo 2 com complicações metabólicas já estabelecidas.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa subestima a gravidade do quadro. O paciente não apresenta apenas resistência insulínica isolada - ele preenche múltiplos critérios para síndrome metabólica (obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, HDL baixo e PA elevada). A acantose nigricans é, de fato, um marcador de resistência insulínica, mas o conjunto de alterações vai muito além disso. Classificar como "isolada" seria ignorar os outros fatores de risco cardiovascular presentes.

(B) ✗ **INCORRETA.** Há dois erros nesta alternativa. Primeiro, o paciente tem **obesidade** (IMC = 26,6 kg/m², Escore Z > +2), não sobrepeso. Segundo, a abordagem de "apenas orientação alimentar" é insuficiente - as diretrizes atuais da AAP recomendam intervenção comportamental intensiva com pelo menos 26 horas de contato em 3-12 meses, envolvendo toda a família. Além disso, a dislipidemia não é meramente secundária, mas parte de um quadro mais amplo de síndrome metabólica.

(C) ✓ **CORRETA.** Esta é a resposta adequada. O paciente apresenta: (1) Obesidade - IMC de 26,6 kg/m² (Escore Z > +2); (2) Circunferência abdominal > percentil 90; (3) Triglicerídeos de 168 mg/dL (≥ 150); (4) HDL de 35 mg/dL (< 40); (5) PA elevada (> p90). Isso configura obesidade com síndrome metabólica, pois há obesidade abdominal associada a múltiplos fatores de risco cardiometabólicos. A acantose nigricans reforça o diagnóstico ao indicar resistência insulínica subjacente.

(D) ✗ **INCORRETA.** O diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 requer glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5%, glicemia ≥ 200 mg/dL em qualquer momento com sintomas, ou TOTG ≥ 200 mg/dL. O paciente apresenta glicemia de jejum de 98 mg/dL, que está dentro da normalidade (< 100 mg/dL). Portanto, não há critérios para diagnóstico de DM2 neste momento. A síndrome metabólica é um fator de risco para desenvolvimento futuro de diabetes, mas ainda não configura a doença.

RESUMO (TLDR)**Síndrome Metabólica Pediátrica: O Essencial**

A SM em crianças é o agrupamento de fatores de risco cardiovascular sobre uma base de **resistência insulínica**.

1. Critérios (IDF, 10-16 anos)

- Obesidade abdominal (CA ≥ p90) **obrigatória**
- + ≥ 2: TG ≥ 150, HDL < 40, PA elevada, glicemia ≥ 100

2. Pistas Clínicas

- Acantose nigricans = marcador de resistência insulínica
- Não é micose nem sujeira!

3. Conduta

- Intervenção intensiva de estilo de vida (não "esperar para ver")
- AAP 2023: ≥ 26 horas de contato em 3-12 meses

Pérola

Criança obesa + acantose + dislipidemia = síndrome metabólica até que se prove o contrário!

QUESTÃO 40 ■ Pediatria ■ Epilepsias ■ Gabarito: C

Menino de 13 anos é levado ao pronto-socorro por episódio convulsivo há 40 minutos. A mãe relata que a criança acordou pela manhã e, enquanto escovava os dentes, deixou a escova cair após apresentar abalos súbitos nos braços, sem perda de consciência. Minutos depois, evoluiu com crise tônico-clônica generalizada. Refere que o filho dormiu tarde na noite anterior jogando videogame. Nega febre ou trauma. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade. Exame físico e neurológico sem alterações. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual medicamento deve ser evitado no tratamento deste paciente?

- (A) Valproato de sódio.
- (B) Levetiracetam.
- (C) ✓ Carbamazepina.
- (D) Lamotrigina.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - O **valproato de sódio** é justamente a droga de **primeira escolha** para o tratamento da Epilepsia Mioclônica Juvenil (EMJ). Estudos demonstram controle das crises em mais de 80% dos pacientes. É um antiepiléptico de amplo espectro, eficaz contra todos os tipos de crises presentes na EMJ (mioclônias, CTCG e ausências). A principal limitação é seu uso em mulheres em idade fértil devido ao risco teratogênico. Portanto, não deve ser evitado – pelo contrário, é a droga de escolha!

(B) **X INCORRETA** - O **levetiracetam** é uma excelente alternativa terapêutica para a EMJ, especialmente indicado em mulheres em idade fértil devido ao melhor perfil de segurança na gestação. Apresenta eficácia comprovada no controle das crises mioclônicas e tônico-clônicas generalizadas, com poucos efeitos adversos. É frequentemente utilizado como primeira linha quando o valproato está contraindicado. Portanto, não deve ser evitado – é uma boa opção terapêutica.

(C) **✓ CORRETA** - A **carbamazepina** é um bloqueador de canais de sódio classicamente indicado para epilepsias focais. No entanto, nas epilepsias generalizadas genéticas como a EMJ, essa classe de medicamentos está **contraindicada** porque pode **agravar as crises mioclônicas** e até precipitar crises tônico-clônicas generalizadas. O mesmo se aplica à fenitoína e oxcarbazepina. Esse é um conceito de alto rendimento: bloqueadores de canais de sódio pioram epilepsias generalizadas idiopáticas!

(D) **X INCORRETA** - A **lamotrigina** é uma opção terapêutica válida para a EMJ, sendo especialmente útil em mulheres em idade fértil como alternativa ao valproato. Embora em alguns pacientes possa haver exacerbação das mioclônias (devendo ser usada com cautela e titulação lenta), não é formalmente contraindicada como a carbamazepina. É considerada uma droga de segunda linha aceitável para essa síndrome.

RESUMO (TLDR)**Epilepsia Mioclônica Juvenil: O Que Realmente Importa?**

A EMJ é a epilepsia generalizada genética mais comum, com início na adolescência.

1. Quadro Clássico

- Mioclônias matinais (abalos em MMSS ao despertar)
- Consciência preservada durante mioclônias
- CTCG (90%) e ausências (30%)
- DNPM normal

2. Gatilhos

- Privação de sono (principal!)
- Álcool, estresse, fotoestimulação

3. Tratamento

- **Usar:** Valproato (1ª escolha), Levetiracetam, Lamotrigina
- **EVITAR:** Carbamazepina, Fenitoína, Oxcarbazepina (pioram!)

4. Pérola

Bloqueadores de canais de sódio agravam epilepsias generalizadas genéticas!

QUESTÃO 41 ■ Pediatria ■ Choque ■ Gabarito: C

Lactente de 8 meses é trazido à Unidade Básica de Saúde pela mãe, que relata febre alta há 2 dias, recusa alimentar e irritabilidade. Antecedentes: nascido a termo, vacinação em dia, sem comorbidades. Ao exame físico: temperatura axilar de 39,2°C, frequência cardíaca de 180 bpm, frequência respiratória de 52 irpm, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, extremidades frias e mosqueadas, pulsos periféricos finos. Encontra-se irritado, chorando inconsolavelmente. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios. Otoscopia revela membrana timpânica direita abaulada e hiperemiada. Diante desse quadro clínico, a conduta inicial mais adequada é:

- (A) Prescrever amoxicilina oral e orientar retorno em 48 horas para reavaliação clínica.
- (B) Solicitar hemograma e proteína C reativa para definir necessidade de antibioticoterapia.
- (C) ✓ **Iniciar expansão volêmica com cristalóide isotônico e encaminhar para serviço de urgência com antibioticoterapia empírica na primeira hora.**
- (D) Administrar antitérmico, observar por 2 horas na unidade e reavaliar sinais vitais.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Prescrever amoxicilina oral e orientar retorno em 48 horas seria adequado para uma otite média aguda **sem sinais de gravidade sistêmica**. Porém, este lactente apresenta sinais claros de choque séptico: taquicardia importante (FC 180 bpm), TEC prolongado (4 segundos), extremidades frias e mosqueadas, pulsos finos. Tratar apenas a infecção de foco e liberar o paciente para casa seria potencialmente fatal. A criança necessita de ressuscitação volêmica imediata e encaminhamento para serviço de urgência.

(B) **X INCORRETA.** Solicitar exames laboratoriais para "definir necessidade de antibioticoterapia" representa um atraso inaceitável no manejo de um paciente em choque. O diagnóstico de choque séptico é **clínico** e o tratamento deve ser iniciado imediatamente, baseado na suspeita. Conforme as diretrizes do Surviving Sepsis Campaign, cada hora de atraso na ressuscitação aumenta significativamente a mortalidade. Exames podem ser coletados, mas não devem retardar a expansão volêmica e o encaminhamento.

(C) ✓ **CORRETA.** Este lactente apresenta sinais inequívocos de choque séptico: taquicardia (FC 180 bpm), taquipneia (FR 52 irpm), TEC prolongado (4 segundos), extremidades frias e mosqueadas, pulsos finos. A conduta correta na APS é: (1) reconhecer o choque; (2) iniciar ressuscitação volêmica com cristalóide isotônico (SF 0,9% ou Ringer Lactato) em bolus de 10-20 mL/kg; (3) encaminhar imediatamente para serviço de urgência com suporte avançado. O médico da atenção primária é a primeira linha de defesa e deve iniciar o tratamento antes do transporte.

(D) **X INCORRETA.** Administrar apenas antitérmico e observar por 2 horas subestima gravemente a condição do paciente. A febre é um marcador de infecção, mas o problema crítico aqui é a **hipoperfusão tecidual**. Os sinais de choque (TEC prolongado, extremidades frias, pulsos finos, taquicardia) indicam que o paciente está em risco iminente de deterioração. Observação passiva pode levar à progressão para choque irreversível. A intervenção ativa com ressuscitação volêmica é mandatória.

RESUMO (TLDR)**Choque Séptico Pediátrico na APS: O Essencial**

Lactente com febre, foco infeccioso (otite) e **sinais de hipoperfusão** (TEC prolongado, extremidades frias, pulsos finos, taquicardia) = choque séptico até prova em contrário.

1. Reconhecimento

- Em pediatria, a hipotensão é sinal **tardio**
- Foco nos sinais de hipoperfusão: TEC > 3s, extremidades frias, pulsos finos

2. Conduta na APS (R-R-R)

- **Reconhecer** os sinais de choque
- **Ressuscitar** com cristalóide isotônico (10-20 mL/kg em bolus)
- **Referenciar** para urgência imediatamente

3. Pérola

- O tratamento começa pela **suspeita clínica**, não pela confirmação laboratorial
- Cada hora de atraso aumenta a mortalidade

QUESTÃO 42 ■ Pediatria ■ Imunizações ■ Gabarito: A

Lactente de 7 meses é levado à Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura. A mãe informa que a criança nasceu a termo, sem intercorrências, e apresenta caderneta vacinal com todas as vacinas aplicadas corretamente até os 5 meses de idade, incluindo segunda dose de pentavalente, VIP, pneumocócica 10-valente e rotavírus, além de segunda dose de meningocócica C. Aos 6 meses, a família mudou-se para outro município e não compareceu à UBS. Nega comorbidades, alergias ou uso de medicamentos. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação do PNI 2025-2026, quais vacinas devem ser aplicadas nesta consulta para atualizar o esquema vacinal?

- (A) ✓ **Pentavalente (3ª dose), VIP (3ª dose), influenza (1ª dose) e COVID-19 (1ª dose).**
(B) Pentavalente (3ª dose), VIP (3ª dose), pneumocócica 10-valente (reforço) e influenza (1ª dose).
(C) Pentavalente (3ª dose), VIP (3ª dose), meningocócica C (reforço) e influenza (1ª dose).
(D) Pentavalente (3ª dose), VIP (3ª dose), rotavírus (3ª dose) e influenza (1ª dose).

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Aos 6 meses, conforme o Calendário Nacional de Vacinação do PNI 2025-2026, as vacinas preconizadas são: **3ª dose de Pentavalente** (esquema 2-4-6 meses), **3ª dose de VIP** (esquema 2-4-6 meses), **1ª dose de Influenza** (indicada a partir dos 6 meses para crianças de 6 meses a menores de 6 anos) e **1ª dose de COVID-19** (incorporada ao calendário de rotina a partir dos 6 meses). Note que a pneumocócica 10-valente já completou suas 2 doses do esquema primário (2 e 4 meses) e terá reforço apenas aos 12 meses; a meningocócica C completou as 2 doses (3 e 5 meses) e terá reforço aos 12 meses com meningocócica ACWY; e o rotavírus completou seu esquema de 2 doses aos 4 meses.

(B) ✗ **INCORRETA.** Contém dois erros: (1) inclui a **pneumocócica 10-valente**, cujo esquema primário é de 2 doses (aos 2 e 4 meses), já completo neste lactente — a próxima dose será o **reforço aos 12 meses**, não havendo dose prevista aos 6 meses; (2) **omite a COVID-19**, que foi incorporada ao calendário de rotina do PNI a partir dos 6 meses de idade. É fundamental diferenciar o esquema primário do reforço para cada vacina.

(C) ✗ **INCORRETA.** Inclui a **meningocócica C como reforço**, o que não é correto neste momento. O esquema primário da meningocócica C é de 2 doses (3 e 5 meses), já completo neste lactente. O reforço é previsto apenas aos **12 meses de idade** — e desde julho de 2025, o reforço é feito com a vacina **meningocócica ACWY** em substituição à meningocócica C isolada. Além disso, a alternativa omite a COVID-19, preconizada a partir dos 6 meses.

(D) ✗ **INCORRETA.** Apresenta erro grave ao incluir uma **3ª dose de rotavírus**. O esquema do rotavírus humano no PNI é de apenas **2 doses** (aos 2 e 4 meses), já completo neste lactente. Não existe 3ª dose de rotavírus no calendário brasileiro. Além disso, a alternativa omite a **COVID-19**, preconizada a partir dos 6 meses. É importante lembrar que, desde a Nota Técnica nº 193/2024, a faixa etária do rotavírus foi ampliada (1ª dose até 11m29d e 2ª dose até 23m29d), mas o número de doses permanece 2.

RESUMO (TLDR)**Calendário Vacinal aos 6 Meses (PNI 2025-2026): O Essencial****1. Vacinas aos 6 meses**

- **Pentavalente** (3ª dose) — esquema 2-4-6m
- **VIP** (3ª dose) — esquema 2-4-6m
- **Influenza** (1ª dose) — a partir de 6 meses
- **COVID-19** (1ª dose) — a partir de 6 meses

2. O que NÃO tem aos 6 meses

- ■ Pneumo 10: próxima dose é o **reforço aos 12m**
- ■ Meningo C: próxima é **ACWY aos 12m** (mudança jul/2025!)
- ■ Rotavírus: completou 2 doses aos 4m, sem mais doses

3. Mudanças recentes que caem em prova

- VOP abolida → VIP em todo o esquema (nov/2024)
- Meningo C → ACWY no reforço de 12m (jul/2025)
- Rotavírus: faixa etária ampliada, mas continua 2 doses
- COVID-19 na rotina a partir de 6m

QUESTÃO 43 ■ Pediatria ■ Doenças Tropicais ■ Gabarito: B

Lactente de 11 meses é trazido à UPA por quadro de febre alta (39,5°C) há 4 dias, associada a irritabilidade, recusa alimentar e exantema maculopapular difuso há 24 horas. A mãe relata que a criança apresentou dois episódios de vômitos hoje pela manhã. A família reside em município com epidemia de dengue em curso. Ao exame físico: regular estado geral, chorosa, fontanela anterior normotensa, mucosas levemente secas, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdome levemente distendido com dor à palpação difusa, fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito, sem petéquias visíveis. Prova do laço negativa. O hemograma revela: Hb 12,8 g/dL, Ht 42% (referência para idade: 33-39%), leucócitos 3.200/mm³ com linfocitopenia, plaquetas 98.000/mm³. A mãe questiona se pode levar a criança para casa e retornar no dia seguinte. Considerando as particularidades do manejo de dengue em lactentes e os achados clínico-laboratoriais apresentados, qual é a conduta mais adequada?

(A) Alta hospitalar com hidratação oral rigorosa e retorno obrigatório em 24 horas para reavaliação clínico-laboratorial, já que a prova do laço negativa exclui gravidade.

(B) ✓ **Internação hospitalar com hidratação venosa, pois lactentes com dengue e sinais de alarme devem ser classificados como grupo C, independentemente da prova do laço.**

(C) Observação em leito de emergência por 6 horas com hidratação oral supervisionada e repetição do hemograma, pois a ausência de petéquias classifica como grupo B.

(D) Transferência imediata para UTI pediátrica com expansão volêmica rápida de 20 mL/kg em 20 minutos, devido aos sinais de choque iminente no lactente.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa comete um erro grave e potencialmente fatal: valorizar excessivamente a prova do laço negativa. Perceba que a prova do laço serve para diferenciar pacientes do **Grupo A** (ambulatorial) do **Grupo B** (observação) quando **não há sinais de alarme**. No entanto, este lactente apresenta múltiplos sinais de alarme: hepatomegalia > 2 cm, dor abdominal, hemoconcentração e vômitos. A presença de qualquer sinal de alarme automaticamente classifica o paciente como **Grupo C**, independentemente do resultado da prova do laço. Dar alta para um lactente na fase crítica da dengue com sinais de alarme é negligência médica.

(B) ✓ **CORRETA.** Olha só a importância de conhecer as particularidades do lactente! Este paciente apresenta: (1) hepatomegalia de 3 cm (> 2 cm = sinal de alarme), (2) dor abdominal à palpação, (3) hemoconcentração (Ht 42% vs. referência máxima de 39% para a idade), (4) vômitos. Qualquer um desses achados isoladamente já classificaria como **Grupo C**. Além disso, lactentes têm menor reserva fisiológica e sinais clínicos mais inespecíficos, o que exige um limiar mais baixo para internação. A conduta correta é internação hospitalar com hidratação venosa (10 mL/kg/h nas primeiras 2 horas), monitorização de sinais vitais, hematócrito seriado e vigilância para evolução para choque.

(C) ✗ **INCORRETA.** A alternativa confunde os critérios de classificação. A **ausência de petéquias** não é o que define o Grupo B. O Grupo B é caracterizado por: sangramento cutâneo (petéquias) OU prova do laço positiva, OU comorbidades/risco social – **na ausência de sinais de alarme**. Este paciente tem sinais de alarme evidentes (hepatomegalia > 2 cm, hemoconcentração, dor abdominal, vômitos). Logo, a classificação correta é Grupo C, não B. Observação por 6 horas com hidratação oral é insuficiente e perigosa para um lactente com extravasamento plasmático documentado.

(D) ✗ **INCORRETA.** A transferência para UTI com expansão volêmica agressiva (20 mL/kg em 20 minutos) é reservada para o **Grupo D** – pacientes com sinais de **choque estabelecido**: hipotensão arterial, pulso filiforme, tempo de enchimento capilar > 2 segundos, extremidades frias e pegajosas. O lactente do caso apresenta sinais de alarme (Grupo C), mas não há descrição de sinais de choque: a fontanela está normotensa (não deprimida), não há relato de extremidades frias ou TEC prolongado. O manejo correto para Grupo C é enfermagem com hidratação venosa programada, não UTI com ressuscitação agressiva.

RESUMO (TLDR)

Dengue em Lactentes: O Que Realmente Importa?

Lactentes são mais vulneráveis e expressam sinais de alarme de forma inespecífica (irritabilidade = dor, recusa alimentar = mal-estar).

1. Classificação Rápida

- **Sem sinais de alarme + prova do laço negativa** → Grupo A (casa)
- **Sem sinais de alarme + prova do laço positiva** → Grupo B (observação)
- **COM sinais de alarme** → Grupo C (internação)
- **Com CHOQUE** → Grupo D (UTI)

2. Sinais de Alarme Mais Cobrados

- Hepatomegalia > 2 cm
- Dor abdominal intensa
- Hemoconcentração (Ht acima do limite para idade)
- Vômitos persistentes

3. Pérola

Prova do laço negativa NÃO exclui gravidade se há sinais de alarme. Ela serve apenas para diferenciar Grupo A de B, não para "liberar" paciente com hepatomegalia ou hemoconcentração!

QUESTÃO 44 ■ Pediatria ■ Asma ■ Gabarito: A

Menino de 7 anos é trazido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela mãe, com queixa de tosse seca e "chiado no peito" há 3 horas. A mãe relata que administrou 2 jatos de salbutamol spray em casa, sem melhora. A criança tem diagnóstico de asma desde os 4 anos, em uso irregular de beclometasona inalatória. Ao exame físico: consciente, agitado, preferindo ficar sentado, fala frases curtas, frequência respiratória de 36 incursões por minuto, frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto, saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente, tiragem intercostal e sibilos expiratórios difusos à ausculta. A conduta inicial mais adequada para essa criança é

- (A) ✓ **oxigenioterapia suplementar, salbutamol inalatório 4 a 10 jatos a cada 20 minutos e prednisolona oral.**
- (B) oxigenioterapia suplementar, adrenalina intramuscular e metilprednisolona endovenosa.
- (C) salbutamol inalatório 2 jatos a cada 4 horas e aumento da dose de beclometasona inalatória.
- (D) sulfato de magnésio endovenoso, brometo de ipratrópio inalatório e intubação orotraqueal.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Esta alternativa contempla o "tripé" do tratamento inicial da crise asmática moderada a grave: (1) **oxigenioterapia** para manter saturação entre 94-98%; (2) **salbutamol inalatório em doses altas** (4 a 10 jatos a cada 20 minutos na primeira hora), que é a dose de crise e não a de manutenção; e (3) **corticoide sistêmico precoce** (prednisolona oral), que reduz inflamação e previne recidivas. A via oral do corticoide é tão eficaz quanto a endovenosa quando o paciente tolera VO. Esta conduta está alinhada com as diretrizes GINA 2025 e as Diretrizes Einstein 2023 para manejo de crises asmáticas em pediatria.

(B) ✗ **INCORRETA.** A **adrenalina intramuscular** é indicada para **anafilaxia**, não para crise asmática. Embora a adrenalina tenha efeito broncodilatador, seu uso na asma é limitado e não é primeira linha. Na anafilaxia, a broncoconstrição é apenas um dos componentes do quadro (junto com hipotensão, angioedema, urticária), enquanto na asma pura, o SABA inalatório é muito mais eficaz e seguro. A metilprednisolona IV seria uma opção se a criança não tolerasse a via oral, mas não há indicação de pular para IV neste caso.

(C) ✗ **INCORRETA.** Esta conduta seria adequada para **manejo ambulatorial de manutenção** ou para uma crise **muito leve**, mas é completamente insuficiente para uma criança com saturação de 91%, agitação, tiragem e fala entrecortada. A dose de 2 jatos é a dose de manutenção, não a de crise! Além disso, aumentar a beclometasona inalatória não terá efeito na crise aguda, pois os corticoides inalatórios demoram dias a semanas para atingir efeito pleno. O corticoide **sistêmico** (oral ou IV) é o que age rapidamente na inflamação da crise.

(D) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa pula etapas importantes do tratamento escalonado. O **sulfato de magnésio IV** é uma terapia **adjuvante de resgate** para crises **refratárias** ao tratamento inicial com SABA e corticoide, não uma medicação de primeira linha. O brometo de ipratrópio pode ser associado ao SABA nas crises moderadas/graves, mas não isoladamente. A **intubação orotraqueal** é medida de último recurso, reservada para pacientes com falência respiratória iminente (sonolência, tórax silencioso, parada respiratória), o que não é o caso desta criança que está consciente e agitada.

RESUMO (TLDR)

Manejo da Crise Asmática Pediátrica: O Que Realmente Importa?

Criança com asma em crise moderada a grave precisa de tratamento imediato e agressivo.

1. Classifique a Gravidade

- SatO₂ < 94%, fala entrecortada, agitação, tiragem = **crise moderada a grave**
- Sonolência = **risco de vida iminente!**

2. O Tripé do Tratamento Inicial

- **Oxigênio:** alvo 94-98%
- **SABA em dose alta:** 4-10 jatos a cada 20 min (não 2 jatos!)
- **Corticoide sistêmico:** prednisolona VO (= metilprednisolona IV em eficácia)

3. Pérola

Adrenalina IM é para anafilaxia, não para asma! Magnésio IV é resgate para casos refratários, não primeira linha.

QUESTÃO 45 ■ Pediatria ■ Distúrbios Neurológicos ■ Gabarito: B

Recém-nascido a termo, com 5 dias de vida, é levado à Unidade Básica de Saúde pela mãe, que relata episódios de movimentos rítmicos em membros superiores e desvio ocular desde ontem, com duração de 1 a 2 minutos cada. A gestação foi sem intercorrências, parto vaginal sem complicações, Apgar 9/10. Ao exame físico: afebril, fontanela normotensa, sem sinais de irritação meníngea, reflexos primitivos presentes. Durante a consulta, o médico observa movimentos clônicos em membro superior direito, com duração de aproximadamente 90 segundos. A glicemia capilar é de 72 mg/dL e o cálcio iônico sérico está normal. Diante desse quadro, qual a conduta farmacológica inicial mais adequada?

- (A) Midazolam endovenoso.
- (B) ✓ **Fenobarbital endovenoso.**
- (C) Fenitoína endovenosa.
- (D) Diazepam endovenoso.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O **midazolam** é um benzodiazepínico utilizado como segunda ou terceira linha no tratamento de convulsões neonatais refratárias. Embora seja eficaz, não é a primeira escolha devido ao risco aumentado de depressão respiratória no neonato, farmacocinética desfavorável (meia-vida prolongada) e menor eficácia comparada ao fenobarbital em estudos clínicos. O midazolam em infusão contínua seria indicado se o paciente não respondesse ao fenobarbital e à fenitoína.

(B) ✓ **CORRETA.** O **fenobarbital** é o anticonvulsivante de **primeira linha** para convulsões neonatais, conforme recomendado pelas diretrizes da ILAE de 2023. A dose de ataque é de 20 mg/kg por via endovenosa, em infusão lenta (10-15 minutos). No caso apresentado, após confirmar que a glicemia e o cálcio estão normais (afastando causas metabólicas tratáveis), o próximo passo é iniciar fenobarbital. Sua eficácia, ampla experiência de uso e perfil de segurança conhecido no período neonatal justificam essa indicação.

(C) **X INCORRETA.** A **fenitoína** é uma alternativa válida para convulsões neonatais, porém é considerada **segunda linha**, indicada quando há falha do fenobarbital ou em situações específicas como suspeita de canalopatia (epilepsia neonatal autossômica dominante). Além disso, a fenitoína tem farmacocinética complexa no neonato, com absorção errática e necessidade de monitorização de níveis séricos, o que a torna menos prática como primeira escolha.

(D) **X INCORRETA.** O **diazepam** não é recomendado como primeira linha em neonatos por várias razões: risco elevado de depressão respiratória, meia-vida extremamente prolongada (até 75 horas no RN), e algumas formulações contêm benzoato de sódio, que pode deslocar a bilirrubina da albumina e aumentar o risco de kernicterus. Em crianças maiores e adultos, o diazepam pode ser primeira escolha, mas no neonato essa conduta está contraindicada.

RESUMO (TLDR)

Convulsões Neonatais: O Que Realmente Importa?

Convulsões no período neonatal têm manejo diferente do resto da vida!

1. Primeira Linha é FENOBARBITAL

- Dose: 20 mg/kg EV (pode repetir até 40 mg/kg total)
- Benzodiazepínicos (diazepam, midazolam) são segunda/terceira linha

2. Sempre Corrigir Causas Metabólicas

- Hipoglicemia: Glicose 10% 2 mL/kg
- Hipocalcemia: Gluconato de cálcio 10% 1-2 mL/kg

3. Pérola de Prova

Se a questão mostrar convulsão neonatal e perguntar primeira droga → **Fenobarbital**, independente da etiologia (exceto canalopatia, que é raríssima).

QUESTÃO 46 ■ Pediatria ■ Febre ■ Gabarito: B

Lactente de 2 meses, previamente hígido, é trazido pela mãe à Unidade Básica de Saúde com história de febre há 12 horas. A mãe refere que a criança está mamando bem e com diurese preservada. Ao exame físico: temperatura axilar de 38,2 °C, frequência cardíaca de 140 bpm, frequência respiratória de 36 irpm, tempo de enchimento capilar de 2 segundos, fontanela normotensa, sem sinais meníngeos, ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, abdome flácido e indolor, sem lesões cutâneas. Considerando a abordagem atual da criança febril, a conduta mais adequada é

- (A) prescrever antitérmico e liberar para casa, com orientação de retorno se piora clínica.
- (B) ✓ **solicitar hemograma, urina tipo I e urocultura, e avaliar internação conforme resultados.**
- (C) iniciar antibioticoterapia empírica imediatamente e encaminhar ao hospital de referência.
- (D) administrar dipirona e manter em observação na UBS até completar 24 horas de febre.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Essa conduta seria aceitável para uma criança **maior de 3 meses** com bom estado geral e exame físico normal. Porém, em um lactente de 2 meses, o risco de infecção bacteriana invasiva é significativo (3-10%), e a apresentação clínica pode ser sutil. Liberar sem investigação laboratorial é uma conduta de risco que pode atrasar o diagnóstico de ITU, bacteremia ou até meningite.

(B) ✓ **CORRETA.** Olha só, essa é a conduta padrão-ouro para lactentes de 1 a 3 meses com febre! Independentemente do bom aspecto clínico, a investigação laboratorial é **obrigatória** nessa faixa etária. O hemograma avalia a resposta inflamatória sistêmica, enquanto o EAS e a urocultura são fundamentais para identificar ITU – a principal causa de febre bacteriana em lactentes. A decisão sobre internação dependerá dos resultados: se os exames vierem normais e a criança mantiver bom estado geral, pode-se optar por reavaliação ambulatorial em 24 horas.

(C) ✗ **INCORRETA.** Iniciar antibioticoterapia empírica **antes da coleta de exames** é um erro! A hemocultura e a urocultura devem ser coletadas antes de qualquer antibiótico, pois o tratamento prévio pode negatar as culturas e dificultar o diagnóstico etiológico. Além disso, a criança não apresenta sinais de toxemia ou instabilidade hemodinâmica que justificariam antibiótico imediato. O encaminhamento ao hospital também não é mandatório antes de avaliar os exames – a UBS pode iniciar a investigação.

(D) ✗ **INCORRETA.** Manter a criança em observação "esperando completar 24 horas de febre" não é conduta adequada. Não existe critério temporal que justifique postergar a investigação em lactentes < 3 meses. A infecção bacteriana grave pode evoluir rapidamente, e a conduta expectante sem exames laboratoriais coloca o paciente em risco. O antitérmico pode ser administrado para conforto, mas não substitui a investigação.

RESUMO (TLDR)

Febre no Lactente Jovem: O Que Não Errar?

Lactentes de 1-3 meses com febre representam um desafio diagnóstico: podem parecer bem e ter infecção grave.

1. Regra de Ouro

- < 3 meses com febre = **investigação laboratorial obrigatória**
- HMG + EAS + urocultura são o mínimo

2. Principal Diagnóstico

- ITU é a causa mais comum de febre bacteriana – o exame físico geralmente é normal!

3. Pérola

- NÃO libere sem exames, NÃO inicie ATB sem coletar culturas, NÃO espere "completar 24h de febre".

QUESTÃO 47 ■ Pediatria ■ Diabetes ■ Gabarito: B

Um menino de 9 anos é levado pela mãe à Unidade Básica de Saúde com queixa de que, nas últimas três semanas, está urinando muito, acordando à noite para ir ao banheiro e bebendo água em excesso. A mãe também notou que ele emagreceu cerca de 3 kg no período, apesar de estar comendo bem. Nega febre, vômitos ou dor abdominal. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, corado, hidratado, afebril, eupneico. Peso atual no percentil 25 para idade. Glicemia capilar realizada na unidade: 287 mg/dL. A mãe questiona se o filho terá que usar insulina para sempre. Com base no quadro clínico apresentado, qual orientação deve ser fornecida à família?

- (A) Deve-se aguardar exames confirmatórios antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso.
- (B) ✓ **O tratamento com insulina será necessário ao longo de toda a vida do paciente.**
- (C) Medicamentos orais podem substituir a insulina após controle inicial da glicemia.
- (D) A insulino terapia será temporária, apenas até a normalização do peso corporal.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa sugere aguardar exames confirmatórios antes de iniciar tratamento. Perceba que, diante de sintomas clássicos de diabetes (poliúria, polidipsia, perda de peso) associados a glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL, o diagnóstico de DM está confirmado e não há necessidade de repetição. Além disso, em uma criança com quadro sugestivo de DM1, postergar o tratamento pode levar à evolução para Cetoacidose Diabética, uma emergência potencialmente fatal.

(B) ✓ **CORRETA** - O Diabetes Mellitus Tipo 1 é caracterizado pela destruição autoimune das células beta pancreáticas, resultando em deficiência absoluta de insulina. Diferentemente do DM2, onde há produção residual de insulina, no DM1 não existe alternativa: a insulino terapia é obrigatória e será necessária **ao longo de toda a vida** do paciente. Nenhum hipoglicemiante oral pode substituir a insulina nessa condição. Esta é a orientação correta a ser fornecida à família.

(C) ✗ **INCORRETA** - Medicamentos orais como metformina, sulfonilureias ou iSGLT2 são utilizados no DM2, onde existe resistência insulínica com produção residual de insulina. No DM1, o problema é a ausência de produção de insulina, e nenhuma medicação oral pode suprir essa função. Portanto, não há substituição possível da insulina por antidiabéticos orais no DM1.

(D) ✗ **INCORRETA** - A insulino terapia no DM1 não é temporária e não tem relação com o peso corporal. A necessidade de insulina decorre da destruição autoimune irreversível das células beta pancreáticas. Mesmo que a criança recupere o peso perdido, a produção endógena de insulina não será restaurada, tornando a insulino terapia permanente.

RESUMO (TLDR)

Diabetes Mellitus Tipo 1 na Infância: O Que Realmente Importa?

O DM1 é uma doença autoimune com destruição das células beta, resultando em **deficiência absoluta de insulina**.

1. Quadro Clínico Clássico

- Poliúria, Polidipsia, Polifagia, Perda de peso (4 Ps)
- Enurese noturna secundária em crianças
- CAD como apresentação inicial em 30-40%

2. Diagnóstico

- Sintomas clássicos + glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL = **confirma em uma aferição**

3. Tratamento

- **Insulina VITALÍCIA** - não existe substituição por orais
- Educação familiar é pilar fundamental

4. Pérola

No DM1, a pergunta não é "SE" vai usar insulina, mas "COMO" será o esquema!

QUESTÃO 48 ■ Pediatria ■ Hemoglobinopatias ■ Gabarito: B

Menino de 4 anos, com diagnóstico de anemia falciforme (HbSS) confirmado na triagem neonatal, é trazido à Unidade Básica de Saúde pela mãe para consulta de rotina. A criança está em uso regular de ácido fólico e penicilina V oral desde os 2 meses de vida. A mãe refere que o filho apresentou, nos últimos 12 meses, três episódios de crises álgicas com necessidade de atendimento em pronto-socorro, além de uma internação por síndrome torácica aguda há 4 meses. Exame físico sem alterações agudas. Hemograma recente: hemoglobina 7,2 g/dL, leucócitos 12.000/mm³, plaquetas 380.000/mm³. Considerando as diretrizes atuais para manejo ambulatorial da doença falciforme em pediatria, qual a conduta mais adequada para modificar a história natural da doença nesse paciente?

- (A) Manter conduta atual e reavaliar após novo episódio de crise vaso-oclusiva.
- (B) ✓ **Iniciar hidroxiureia para redução da frequência de complicações graves.**
- (C) Indicar esplenectomia profilática para prevenção de sequestro esplênico.
- (D) Programar transfusões crônicas mensais como terapia de primeira linha.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - Manter apenas a conduta atual (ácido fólico + penicilina) e aguardar novos episódios é uma abordagem inadequada e potencialmente perigosa. Note que o paciente já apresenta **critérios bem estabelecidos** para intensificação terapêutica: três crises álgicas no último ano e um episódio de síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda é uma das complicações mais graves da doença falciforme, com mortalidade significativa. Adiar a introdução de terapia modificadora de doença expõe a criança a risco de novas complicações, incluindo lesão orgânica progressiva e eventos potencialmente fatais.

(B) ✓ **CORRETA** - A hidroxiureia é o tratamento modificador de doença de primeira linha para pacientes com doença falciforme que apresentam complicações recorrentes. Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, a hidroxiureia é cada vez mais utilizada nos casos mais graves, inclusive em crianças. Este paciente preenche múltiplos critérios: ≥ 3 crises álgicas/ano e histórico de síndrome torácica aguda. O mecanismo de ação envolve o aumento da produção de hemoglobina fetal (HbF), que não participa da polimerização da HbS, reduzindo assim os eventos vaso-oclusivos e a hemólise. Estudos demonstram redução significativa de hospitalizações, crises álgicas e mortalidade com seu uso.

(C) **X INCORRETA** - A esplenectomia profilática não tem indicação na doença falciforme. Perceba que o baço desses pacientes sofre um processo de **autoesplenectomia** progressiva: os múltiplos infartos esplênicos por vaso-oclusão levam à fibrose e perda funcional do órgão ao longo dos primeiros anos de vida. A esplenectomia cirúrgica é reservada exclusivamente para casos de **sequestro esplênico agudo recorrente** com risco de vida iminente, situação na qual há aprisionamento súbito de grande volume de sangue no baço, causando choque hipovolêmico. Não é o caso deste paciente.

(D) **X INCORRETA** - O regime de transfusões crônicas (transfusão simples ou exsanguineotransfusão regular) não é terapia de primeira linha para prevenção de crises álgicas. Suas indicações específicas incluem: prevenção secundária de AVC (após evento isquêmico ou Doppler transcraniano com velocidades alteradas), falha ou intolerância à hidroxiureia, e algumas situações especiais como gestação de alto risco. Os riscos do regime transfusional crônico são consideráveis: aloimunização eritrocitária (dificultando transfusões futuras), sobrecarga de ferro com necessidade de quelação, e risco de infecções transmissíveis. Para este paciente, a hidroxiureia é a escolha correta.

RESUMO (TLDR)

Hidroxiureia na Doença Falciforme: O Essencial

A hidroxiureia é o único tratamento modificador de doença amplamente disponível para anemia falciforme.

1. Mecanismo

- Aumenta hemoglobina fetal (HbF)
- HbF não polimeriza → menos falcização → menos complicações

2. Indicações Principais

- ≥ 3 crises algicas graves/ano
- Síndrome torácica aguda prévia
- Anemia grave sintomática

3. O Que NÃO É Indicação de Hidroxiureia

- AVC prévio → transfusão crônica
- Doppler transcraniano alterado → transfusão crônica

4. Pérola

Síndrome torácica aguda = infiltrado pulmonar novo + sintomas respiratórios. É complicação grave e indicação absoluta de hidroxiureia!

V. Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva

QUESTÃO 49 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Atenção Primária à Saúde ■ Gabarito: B

Em uma Unidade Básica de Saúde com três equipes de Saúde da Família, a coordenadora apresenta, em reunião de colegiado gestor, os dados do painel de indicadores do Previn Brasil referentes ao último quadrimestre. Os resultados mostram que a equipe Alfa alcançou 78% da meta de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, a equipe Beta atingiu 45% e a equipe Gama ficou com 62%. A coordenadora propõe que cada equipe analise seus resultados e elabore um plano de ação. O médico da equipe Beta, ao revisar o processo de trabalho, identifica que muitas gestantes comparecem tardiamente à primeira consulta e que há falhas no agendamento de retornos. Considerando as ferramentas de gestão da clínica na Atenção Primária à Saúde, qual é a estratégia mais adequada para a equipe Beta melhorar esse indicador?

- (A) Aumentar o número de vagas disponíveis para pré-natal na agenda médica, priorizando atendimentos individuais e reduzindo as atividades de grupo educativo para gestantes.
- (B) ✓ **Implementar busca ativa de gestantes pelos agentes comunitários de saúde, revisar o fluxo de captação precoce e pactuar metas intermediárias em reuniões de equipe.**
- (C) Encaminhar as gestantes faltosas para acompanhamento no serviço de alto risco, considerando a baixa adesão como critério de vulnerabilidade para referenciamento.
- (D) Solicitar à gestão municipal a contratação de mais um profissional médico, visto que a sobrecarga assistencial é a principal causa da baixa cobertura de pré-natal.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Aumentar vagas na agenda não resolve o problema identificado, que é a **captação tardia**. Se as gestantes estão chegando tarde ao pré-natal, simplesmente ter mais vagas disponíveis não as fará procurar o serviço mais cedo. Além disso, reduzir atividades de grupo educativo é contraproducente, pois essas atividades fortalecem o vínculo, melhoram a adesão e são componentes importantes da atenção integral à gestante. A questão não menciona falta de vagas como problema.

(B) ✓ **CORRETA.** Esta alternativa representa a aplicação adequada das ferramentas de gestão da clínica. A **busca ativa pelos ACS** atua diretamente sobre o problema da captação tardia, identificando gestantes no território antes que elas procurem o serviço. A **revisão do fluxo de captação** organiza o processo de trabalho para garantir acesso oportuno. A **pactuação de metas intermediárias em reuniões de equipe** permite monitoramento frequente e corresponsabilização. Essa é a essência do ciclo PDCA: identificar causas e implementar ações específicas.

(C) ✗ **INCORRETA.** A baixa adesão ou falta às consultas **não é critério** para encaminhamento ao pré-natal de alto risco. O alto risco é definido por condições clínicas (hipertensão, diabetes, gemelaridade, malformações, etc.) e não por vulnerabilidade social ou comportamental. Encaminhar gestantes faltosas sobrecarregaria indevidamente a atenção especializada e não resolveria o problema, pois a causa da baixa cobertura está no processo de trabalho da equipe, não nas características das gestantes.

(D) ✗ **INCORRETA.** Solicitar contratação de mais profissionais é uma medida de **gestão administrativa/macrogestão**, não de gestão da clínica. A questão pede especificamente ferramentas de gestão da clínica, que trabalham com a otimização dos processos de trabalho utilizando os recursos existentes. Além disso, o enunciado não indica que a causa do problema seja sobrecarga assistencial, mas sim falhas na captação e no agendamento - problemas de organização do fluxo, não de quantidade de pessoal.

RESUMO (TLDR)

Gestão da Clínica na APS: O Que Realmente Importa?

A gestão da clínica trabalha com a **otimização de processos** usando os recursos existentes.

1. Ferramentas Principais

- Análise de indicadores em reuniões de equipe
- Busca ativa pelos ACS
- Revisão de fluxos e protocolos
- Ciclo PDCA (Planejar-Executar-Verificar-Agir)

2. O Que NÃO É Gestão da Clínica

- Solicitar contratações
- Pedir equipamentos
- Esperar recursos externos

3. Pérola

Se o indicador está baixo, a primeira pergunta é: "**O que no nosso processo de trabalho está falhando?**" - não "O que está faltando?"

QUESTÃO 50 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Atenção Primária à Saúde
■ Gabarito: A

Mulher de 42 anos comparece à Unidade Básica de Saúde queixando-se de dor lombar há 3 semanas. Relata que a dor começou após carregar caixas pesadas durante mudança de residência. Ao ser questionada pelo médico de família sobre como está lidando com o problema, a paciente responde: "Doutor, estou apavorada. Minha mãe teve câncer na coluna e começou assim. Não consigo mais fazer as tarefas de casa e tenho medo de ficar parálitica. Preciso de uma ressonância para ter certeza do que eu tenho." O exame físico revela dor muscular paravertebral à palpação, sem déficits neurológicos e com manobras de tensão radicular negativas. Considerando o Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), qual componente do acrônimo SIFE foi predominantemente explorado nesse relato da paciente?

(A) ✓ **Sentimentos**, pois a paciente expressa medo e preocupação com o diagnóstico.

(B) Ideias, pois a paciente acredita ter a mesma doença que acometeu sua mãe.

(C) Funcionalidade, pois a paciente relata limitação nas atividades domésticas.

(D) Expectativas, pois a paciente solicita a realização de exame de imagem.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A dimensão **Sentimentos** do SIFE refere-se às emoções experimentadas pelo paciente diante do problema de saúde. No relato, a paciente utiliza expressões como "estou **apavorada**" e "tenho **medo** de ficar parálitica", que são manifestações claras de emoções intensas (medo, angústia, pavor). Embora a fala contenha elementos das outras dimensões (ideia sobre câncer, impacto funcional, expectativa de exame), o **tom emocional predominante** é o medo. A crença sobre câncer e a demanda por ressonância são consequências secundárias desse sentimento central. Identificar corretamente o sentimento permite ao médico validar a emoção antes de abordar as outras dimensões.

(B) ✗ **INCORRETA.** A dimensão **Ideias** refere-se às crenças e interpretações que o paciente tem sobre sua condição. Embora a paciente mencione que a mãe teve câncer na coluna e isso influencie seu raciocínio, ela não verbaliza diretamente "acho que tenho câncer" ou "acredito que seja a mesma doença". O histórico materno funciona como **contexto** para o medo, não como a ideia predominante expressa. Se a fala fosse "Doutor, tenho certeza que é câncer, igual da minha mãe", aí sim a dimensão Ideias seria predominante. No caso, o que domina é a **emoção de medo** (Sentimentos), e a história familiar é o gatilho dessa emoção.

(C) ✗ **INCORRETA.** A dimensão **Funcionalidade** refere-se ao impacto do problema nas atividades cotidianas do paciente. A paciente de fato menciona que "não consigo mais fazer as tarefas de casa", o que configura prejuízo funcional. Porém, essa informação aparece como um **elemento secundário** na narrativa, quase como uma consequência do medo. O núcleo da comunicação não é a limitação funcional em si, mas o **pavor** diante da possibilidade de um diagnóstico grave. Se a queixa principal fosse "Doutor, não estou conseguindo trabalhar e isso está me prejudicando muito financeiramente", a Funcionalidade seria predominante.

(D) ✗ **INCORRETA.** A dimensão **Expectativas** refere-se ao que o paciente espera da consulta ou do médico. A paciente expressa claramente uma expectativa ao dizer "preciso de uma ressonância para ter certeza". No entanto, essa demanda é uma **consequência direta do medo** - ela quer o exame para aliviar a angústia, não como demanda primária. A expectativa pelo exame é instrumentalizada pelo sentimento de medo. Se a fala fosse "Doutor, vim aqui porque quero uma ressonância, já decidi que preciso" (sem o componente emocional intenso), aí sim a dimensão Expectativas seria predominante.

RESUMO (TLDR)**SIFE: O Que Realmente Importa?**

O acrônimo SIFE é a ferramenta do MCCP para explorar a **experiência da doença** (*illness*), complementando a avaliação biomédica (*disease*).

1. As 4 Dimensões

- Sentimentos: Emoções (medo, raiva, tristeza)
- Ideias: Crenças sobre a doença
- Funcionalidade: Impacto no dia a dia
- Expectativas: O que espera do médico

2. Como Diferenciar?

- Sentimento = emoção expressa ("estou com medo")
- Ideia = crença verbalizada ("acho que tenho X")
- Frequentemente se sobrepõem!

3. Pérola

Quando há múltiplos elementos, identifique o **núcleo emocional** - as outras dimensões costumam ser consequências do sentimento predominante.

QUESTÃO 51 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Indicadores de Saúde ■ Gabarito: A

Médico de família atua em uma Unidade Básica de Saúde em município do interior do Nordeste. Durante reunião com a equipe para análise dos indicadores locais, identifica-se que, no último ano, ocorreram 12 óbitos em menores de 1 ano de idade, para um total de 800 nascidos vivos. Dos 12 óbitos, 8 ocorreram nos primeiros 6 dias de vida, 2 entre 7 e 27 dias de vida, e 2 após 28 dias. O componente da mortalidade infantil que mais contribuiu para esse indicador e a principal estratégia de intervenção são, respectivamente:

- (A) ✓ **neonatal precoce; qualificação da assistência ao parto e ao recém-nascido.**
- (B) neonatal tardio; ampliação da cobertura vacinal e do aleitamento materno.
- (C) pós-neonatal; melhoria das condições de saneamento básico e nutrição.
- (D) perinatal; expansão do número de consultas de puericultura.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Dos 12 óbitos, 8 ocorreram nos primeiros 6 dias de vida, caracterizando o componente **neonatal precoce** como predominante (66,7% do total). Este componente reflete diretamente a qualidade da assistência ao trabalho de parto, ao parto propriamente dito e aos cuidados imediatos ao recém-nascido. A principal estratégia de intervenção é a **qualificação da assistência ao parto e ao recém-nascido**, incluindo: presença de profissional capacitado em reanimação neonatal, uso adequado do partograma, manejo correto da prematuridade e prevenção da asfixia perinatal.

(B) ✗ **INCORRETA.** O componente neonatal tardio (7-27 dias) representou apenas 2 óbitos (16,7%), não sendo o predominante. Embora a ampliação da cobertura vacinal e do aleitamento materno sejam medidas importantes, elas têm maior impacto no componente pós-neonatal e neonatal tardio, não sendo a intervenção prioritária para o cenário apresentado, onde predominam óbitos nos primeiros dias de vida.

(C) ✗ **INCORRETA.** O componente pós-neonatal (28 dias a 1 ano) também representou apenas 2 óbitos (16,7%). A melhoria do saneamento básico e da nutrição são intervenções clássicas para reduzir a mortalidade pós-neonatal, que se associa a doenças diarreicas e respiratórias. No entanto, esse não é o componente predominante no caso apresentado.

(D) ✗ **INCORRETA.** Primeiro, a mortalidade **perinatal** é um indicador diferente que inclui os óbitos fetais (natimortos) somados aos óbitos neonatais precoces – a questão não forneceu dados sobre natimortos. Segundo, a expansão de consultas de puericultura impacta principalmente o componente pós-neonatal, não sendo a estratégia prioritária para reduzir óbitos nos primeiros dias de vida, que dependem da qualidade da assistência ao parto.

RESUMO (TLDR)

Mortalidade Infantil: O Que Cai na Prova?

A mortalidade infantil é dividida em componentes que indicam ONDE está o problema.

1. Os Três Componentes

- **Neonatal Precoce (0-6 dias):** Problema na assistência ao parto → qualificar maternidade
- **Neonatal Tardio (7-27 dias):** Problema no cuidado pós-alta → aleitamento, visita domiciliar
- **Pós-Neonatal (28-364 dias):** Problema socioeconômico → saneamento, vacinas, nutrição

2. Transição Epidemiológica

- Antigamente: predominava pós-neonatal (diarreia, desnutrição)
- Hoje: predomina neonatal precoce (prematuridade, asfixia)

3. Pérola

Se a prova der os números, calcule qual componente predomina e associe à intervenção correta. É isso que a banca quer!

QUESTÃO 52 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Fundamentos da Epidemiologia ■ Gabarito: B

Homem de 62 anos, diabético tipo 2 há 15 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Refere controle glicêmico irregular nos últimos meses, com hemoglobina glicada de 8,9%. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 142 x 88 mmHg e índice de massa corporal de 31 kg/m². Após avaliação, o médico de família orienta mudanças no estilo de vida, ajusta a dose de metformina e solicita fundoscopia para rastreamento de retinopatia diabética. Em relação à solicitação da fundoscopia, qual o nível de prevenção correspondente a essa ação?

- (A) Prevenção primária.
- (B) ✓ **Prevenção secundária.**
- (C) Prevenção terciária.
- (D) Prevenção quaternária.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A prevenção primária ocorre no período de **pré-patogênese**, ou seja, antes da doença existir no organismo. Seu objetivo é evitar que a doença apareça, diminuindo a incidência. Exemplos incluem vacinação e orientação de hábitos saudáveis para pessoas sem a doença-alvo. No caso da questão, a retinopatia diabética pode já existir de forma assintomática no paciente diabético há 15 anos, portanto não estamos mais no período de pré-patogênese para essa complicação.

(B) **✓ CORRETA.** A prevenção secundária atua no período de **patogênese**, quando a doença já existe (mesmo que assintomática). Seu objetivo é o diagnóstico precoce e tratamento imediato para limitar a progressão. A fundoscopia em diabéticos é um exame de **rastreamento** para detectar retinopatia em fase inicial, antes que cause sintomas visuais. Conforme o PCDT Retinopatia Diabética (2021), esse rastreamento é recomendado anualmente em DM2 desde o diagnóstico. Todo rastreamento, por definição, é prevenção secundária.

(C) **X INCORRETA.** A prevenção terciária foca na **reabilitação** de sequelas já estabelecidas, visando a reintegração social do paciente. Seria o caso de reabilitação visual para um paciente que já desenvolveu cegueira por retinopatia avançada. No caso apresentado, o paciente não apresenta sequelas visuais - estamos buscando detectar precocemente uma complicação assintomática, o que caracteriza prevenção secundária.

(D) **X INCORRETA.** A prevenção quaternária, proposta por Marc Jamouille, visa proteger o paciente da **supermedicalização** e de intervenções médicas excessivas ou desnecessárias (iatrogenia). Seria o caso de evitar um exame sem indicação clínica clara. No entanto, a fundoscopia em diabético de longa data com controle irregular é uma recomendação baseada em evidências (PCDT 2021, SBD 2024), não configurando excesso médico.

RESUMO (TLDR)**Níveis de Prevenção: O Que Realmente Importa?**

O modelo de Leavell & Clark divide as ações preventivas conforme a fase da doença.

1. Classificação Rápida

- **Primária:** Doença **NÃO** existe → evitar que apareça
- **Secundária:** Doença **JÁ** existe → diagnóstico precoce e tratamento
- **Terciária:** Sequela **JÁ** existe → reabilitação
- **Quaternária:** Evitar excesso médico

2. Regra de Ouro

Todo **rastreamento** (screening) é Prevenção **Secundária**, pois busca uma doença que pode já existir de forma assintomática.

3. Pérola da Questão

Fundoscopia em diabético = rastreamento de retinopatia = Prevenção Secundária, conforme PCDT Retinopatia Diabética (2021).

QUESTÃO 53 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Medicina Legal ■
Gabarito: A

Médico plantonista de uma UPA é acionado para avaliar um homem de 62 anos, trazido pelo SAMU após ser encontrado inconsciente em via pública. Segundo testemunhas, o paciente estava sentado em um banco quando subitamente levou a mão ao peito, gemeu e caiu ao solo. Não houve relato de trauma. À chegada na UPA, após 40 minutos de manobras de ressuscitação cardiopulmonar sem sucesso, o óbito foi constatado. O paciente não portava documentos, não foi possível contatar familiares e não havia registro dele no sistema de saúde local. Ao exame do corpo, não foram identificados sinais de lesões traumáticas ou violência. Considerando as normativas vigentes sobre a Declaração de Óbito, qual é a conduta mais adequada do médico plantonista nessa situação?

(A) ✓ **Encaminhar o corpo ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para esclarecimento da causa mortis, sem preencher a Declaração de Óbito.**

(B) Recusar-se a preencher a Declaração de Óbito, pois não havia vínculo assistencial prévio, e encaminhar o corpo diretamente ao Instituto Médico Legal (IML).

(C) Preencher a Declaração de Óbito indicando causa indeterminada e encaminhar o corpo ao SVO para complementação diagnóstica.

(D) Encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, independentemente da ausência de sinais de violência, por se tratar de paciente não identificado.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta adequada! Diante de uma morte provavelmente natural (quadro sugestivo de evento cardíaco, sem sinais de violência), porém **sem assistência médica prévia e sem possibilidade de confirmar a causa**, a Resolução CFM nº 1779/2005 e o Manual de Preenchimento da DO do MS determinam que o corpo deve ser encaminhado ao **Serviço de Verificação de Óbito (SVO)** para elucidação diagnóstica. O médico plantonista **NÃO** preenche a Declaração de Óbito neste caso - apenas emite uma guia de encaminhamento. A DO será preenchida pelo médico do SVO após a necropsia clínica, pois a Declaração de Óbito é documento único e definitivo que não admite complementação posterior.

(B) ✗ **INCORRETA.** Esse é um erro conceitual grave! O médico plantonista de urgência/emergência **não pode se recusar** a atuar no caso alegando ausência de vínculo prévio. Em serviços de urgência, o plantonista assume a função de médico assistente para os pacientes atendidos. Além disso, o encaminhamento ao IML só é indicado em casos de morte violenta ou suspeita, o que não se aplica aqui – não há sinais de trauma ou violência. Recusar-se a preencher a DO pode configurar infração ética.

(C) ✗ **INCORRETA.** O erro está em afirmar que o médico plantonista deve preencher a Declaração de Óbito. Como não houve assistência médica prévia e a causa da morte é indeterminada, o médico **NÃO** tem elementos para preencher a DO. A Declaração de Óbito é um documento único que só pode ser emitido uma vez, portanto não existe "complementação" pelo SVO. O médico deve apenas encaminhar o corpo ao SVO, que realizará a necropsia clínica e preencherá a DO com a causa definitiva.

(D) ✗ **INCORRETA.** Note que o encaminhamento ao IML é indicado para mortes **violentas ou suspeitas**, não para pacientes não identificados. A identidade do paciente não determina o destino do corpo – o que importa é a **natureza da morte**. No caso, não há sinais de violência ou causa externa, então o corpo não deve ir ao IML. O SVO é o destino correto para elucidar mortes naturais de causa indeterminada, independentemente da identificação do paciente.

RESUMO (TLDR)**Declaração de Óbito: O Que Realmente Importa?**

A pergunta central é sempre: **morte natural ou violenta?**

1. Para onde vai o corpo?

- **IML:** Morte violenta ou suspeita de violência
- **SVO:** Morte natural sem causa definida
- **Médico assistente:** Morte natural com causa conhecida

2. Quem preenche a DO?

- Médico assistente/plantonista (morte natural)
- Médico legista (morte violenta)
- Médico do SVO (causa indeterminada)

3. Pérola

Paciente não identificado ≠ IML. O que importa é a natureza da morte, não a identidade!

QUESTÃO 54 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Saúde do Trabalhador ■ Gabarito: A

Homem de 45 anos, pintor industrial há 18 anos, é trazido à UPA por colegas de trabalho após apresentar confusão mental, tremores e vômitos no ambiente laboral. Os colegas relatam que o paciente trabalha em espaço confinado realizando pintura de tanques industriais, sem uso adequado de equipamentos de proteção individual. Ao exame físico: Glasgow 13, eupneico, PA 110x70 mmHg, FC 92 bpm, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Apresenta hálito com odor adocicado, ataxia de marcha e nistagmo horizontal. Hemograma revela discreta leucopenia com neutropenia relativa. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual achado laboratorial adicional é esperado neste paciente?

(A) ✓ **Elevação do ácido trans-trans mucônico urinário.**

(B) Aumento da atividade da colinesterase plasmática.

(C) Redução do chumbo sérico com reticulocitose.

(D) Aumento do mercúrio urinário com proteinúria.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** O **ácido trans-trans mucônico (ATTM)** é o principal biomarcador de exposição ao benzeno utilizado na prática clínica brasileira. O caso apresenta um quadro clássico de intoxicação por benzeno: pintor industrial em espaço confinado (exposição ocupacional típica), sintomas neurológicos agudos (confusão, ataxia, nistagmo, tremores), hálito adocicado (característico do benzeno) e leucopenia com neutropenia (efeito mielotóxico específico do benzeno). A confirmação laboratorial é feita através da dosagem dos metabólitos urinários, sendo o ATTM o mais utilizado por sua praticidade e disponibilidade.

(B) ✗ **INCORRETA.** O **aumento da atividade da colinesterase plasmática** não é esperado neste caso. Na verdade, a **redução** da colinesterase (não o aumento) é o achado característico das intoxicações por **organofosforados e carbamatos** (agrotóxicos). Esses compostos inibem a acetilcolinesterase, causando acúmulo de acetilcolina e a clássica síndrome colinérgica (DUMBELS: diarreia, urinação, miose, bradicardia/broncorreia, emese, lacrimejamento, sialorreia/sudorese). O quadro do paciente não apresenta esses achados.

(C) ✗ **INCORRETA.** A intoxicação por **chumbo (saturnismo)** cursa com **elevação** do chumbo sérico (não redução) e pontilhado basófilo nas hemácias. A anemia do saturnismo é tipicamente microcítica e hipocrômica, refratária à reposição de ferro. O quadro clínico inclui cólica saturnina (dor abdominal intensa), linha de Burton na gengiva, neuropatia periférica (classicamente "mão caída" por acometimento do nervo radial) e encefalopatia. A exposição ocupacional típica ocorre em indústrias de baterias e reciclagem de metais, diferente do cenário de pintura industrial apresentado.

(D) ✗ **INCORRETA.** O **aumento do mercúrio urinário com proteinúria** seria esperado na intoxicação por mercúrio (hidrargirismo). O quadro clínico típico inclui a tríade: estomatite mercurial (sialorreia, gengivite, afrouxamento dentário), tremores de intenção e eretismo mercurial (irritabilidade, alterações de personalidade). A exposição ocupacional clássica ocorre em fábricas de lâmpadas fluorescentes, garimpo de ouro e indústria de termômetros. O caso não apresenta os achados orais característicos nem o padrão de tremor típico do hidrargirismo.

RESUMO (TLDR)**Intoxicação por Benzeno: O Que Realmente Importa?**

Pintor industrial com quadro neurológico agudo + hálito adocicado + neutropenia = benzeno!

1. Identificação

- **Único** solvente mielotóxico (causa leucopenia/neutropenia)
- Carcinogênico (IARC Grupo 1 - leucemias)
- Exposição: tintas, vernizes, petroquímica, postos de combustível

2. Diagnóstico

- Clínico-epidemiológico (história + exame)
- Biomarcador: **ATTM urinário** (não sérico!)
- Hemograma: neutropenia é alteração mais precoce

3. Conduta

- **Afastar da exposição** (não há antídoto!)
- Notificar no SINAN + emitir CAT
- Monitoramento hematológico prolongado

4. Pérola

Se a questão trazer solvente + alteração hematológica → pense BENZENO!

QUESTÃO 55 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Testes Diagnósticos ■
Gabarito: A

Médica da Estratégia Saúde da Família de um município do interior avalia a implementação de um teste rápido para detecção de diabetes mellitus tipo 2 em adultos assintomáticos. O teste apresenta sensibilidade de 85% e especificidade de 90%. A prevalência estimada de diabetes na população adulta local é de 8%. Considerando esses parâmetros, qual é o valor preditivo positivo aproximado desse teste nessa população?

- (A) ✓ 42%.
 (B) 58%.
 (C) 74%.
 (D) 85%.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Aplicando o método da população hipotética: em 1.000 pessoas com prevalência de 8%, temos 80 doentes e 920 sadios. Com sensibilidade de 85%, teremos 68 verdadeiros positivos. Com especificidade de 90%, teremos 92 falsos positivos (10% dos 920 sadios). O VPP = $68 / (68 + 92) = 68 / 160 = 0,425 = 42\%$. Note que, apesar de boas características intrínsecas do teste, a baixa prevalência faz com que mais da metade dos resultados positivos sejam falsos-positivos.

(B) ✗ **INCORRETA.** O valor de 58% não corresponde ao cálculo correto do VPP. Se você obteve esse valor, provavelmente inverteu alguma etapa do cálculo ou confundiu com o complementar do VPP ($1 - 0,42 = 0,58$). O VPP é calculado dividindo os verdadeiros positivos pelo total de testes positivos, não pelo total de doentes.

(C) ✗ **INCORRETA.** O valor de 74% seria obtido em um cenário de prevalência muito maior. Esse erro ocorre quando se desconsidera o impacto da baixa prevalência nos valores preditivos. Lembre-se: quanto menor a prevalência, menor o VPP, independentemente da sensibilidade e especificidade do teste.

(D) ✗ **INCORRETA.** O valor de 85% corresponde à **sensibilidade** do teste, não ao VPP. Esse é um erro clássico de confundir propriedades intrínsecas (sensibilidade/especificidade) com propriedades extrínsecas (valores preditivos). A sensibilidade é fixa e não muda com a prevalência; o VPP, por outro lado, depende diretamente da frequência da doença na população testada.

RESUMO (TLDR)

Valores Preditivos: O Que Realmente Importa?

Os valores preditivos dependem da **prevalência** da doença na população!

1. A Regra de Ouro

- ↓ **Prevalência** → ↓ **VPP** (muitos falsos-positivos)
- ↑ **Prevalência** → ↑ **VPP** (resultado positivo mais confiável)

2. Método de Cálculo

- Monte tabela 2x2 com 1.000 pessoas
- Distribua por prevalência, sensibilidade e especificidade
- $VPP = VP / (VP + FP)$

3. Pérola Clínica

Na APS (baixa prevalência), teste positivo ≠ diagnóstico. Sempre confirme!

QUESTÃO 56 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Testes Diagnósticos ■
Gabarito: B

Um médico de família está capacitando sua equipe sobre a interpretação de testes diagnósticos. Ele explica que, ao escolher um exame para rastreamento de uma doença grave e potencialmente curável em estágios iniciais, deve-se priorizar determinada característica do teste. Considerando o objetivo de minimizar a chance de deixar passar casos verdadeiros da doença, a propriedade do teste que deve ser priorizada nessa situação é:

- (A) Especificidade.
 (B) ✓ **Sensibilidade.**
 (C) Valor preditivo positivo.
 (D) Acurácia.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A especificidade é a propriedade que deve ser priorizada em testes de **confirmação diagnóstica**, não em rastreamento. Um teste altamente específico minimiza os falsos positivos, sendo ideal quando você quer ter certeza de que um resultado positivo realmente indica doença. No contexto de rastreamento, priorizar especificidade resultaria em muitos falsos

negativos, deixando passar casos que deveriam ser detectados.

(B) ✓ CORRETA. A sensibilidade é a propriedade ideal para **rastreamento (screening)**. Um teste altamente sensível raramente deixa passar um doente verdadeiro, pois minimiza os falsos negativos. No contexto de uma doença grave e potencialmente curável, o objetivo principal é identificar todos os casos possíveis na fase inicial, mesmo que isso signifique alguns falsos positivos que serão esclarecidos posteriormente com testes confirmatórios.

(C) ✗ INCORRETA. O valor preditivo positivo (VPP) indica a probabilidade de um indivíduo com teste positivo realmente ter a doença. Embora seja uma informação clinicamente útil, o VPP **depende da prevalência** da doença na população, não sendo uma propriedade intrínseca do teste. Além disso, para rastreamento, o foco é não perder casos (minimizar FN), e não a proporção de positivos que são verdadeiros.

(D) ✗ INCORRETA. A acurácia representa a proporção total de acertos do teste ($VP + VN / \text{Total}$). Embora pareça uma boa medida geral, ela pode ser enganosa em populações com prevalência muito baixa ou muito alta. Para rastreamento de doenças graves, o objetivo específico é minimizar falsos negativos, o que é garantido pela sensibilidade, e não pela acurácia global do teste.

RESUMO (TLDR)

Sensibilidade e Especificidade: O Que Realmente Importa?

São propriedades intrínsecas do teste, independentes da prevalência.

1. Sensibilidade

- Foco nos **DOENTES**
- Fórmula: $VP / (VP + FN)$
- Uso: **RASTREAMENTO** → não perder casos

2. Especificidade

- Foco nos **SADIOS**
- Fórmula: $VN / (VN + FP)$
- Uso: **CONFIRMAÇÃO** → não rotular sadios

3. Pérola

REDE de segurança = Sensibilidade (captura tudo, não deixa escapar) → **RASTREAMENTO**

MIRA certa = Especificidade (só acerta o alvo) → **CONFIRMAÇÃO**

QUESTÃO 57 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Saúde Ambiental ■ Gabarito: B

Médica de família e comunidade atua em uma UBS localizada em município do interior do Nordeste brasileiro. Nas últimas semanas, a região enfrenta uma onda de calor prolongada, com temperaturas máximas acima de 40°C. A profissional observa aumento significativo de atendimentos de idosos hipertensos em uso de diuréticos e vasodilatadores, apresentando tontura, hipotensão postural e elevação de creatinina sérica. Considerando as orientações do Guia de Mudanças Climáticas e Saúde do Ministério da Saúde (2025), qual a conduta mais adequada para esses pacientes durante o período de calor extremo?

(A) Manter as doses habituais dos anti-hipertensivos e orientar aumento da ingestão hídrica, pois a hidratação compensa os efeitos do calor.

(B) ✓ CORRETA. Reavaliar a prescrição, considerando redução temporária de diuréticos e vasodilatadores, além de reforçar hidratação e medidas de proteção térmica.

(C) Suspender todos os anti-hipertensivos até o término da onda de calor, retomando posteriormente com as mesmas doses.

(D) Substituir os diuréticos por betabloqueadores, que apresentam menor risco de desidratação em situações de calor extremo.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ INCORRETA. Manter as doses habituais sem reavaliação é um erro grave! Note que os pacientes já estão sintomáticos (tontura, hipotensão postural, elevação de creatinina). A hidratação isolada não é suficiente para compensar o efeito combinado do calor extremo com diuréticos e vasodilatadores. Esses medicamentos potencializam a depleção volêmica e a vasodilatação, levando a hipotensão e lesão renal aguda pré-renal. A conduta correta exige reavaliação e possível ajuste de doses.

(B) ✓ CORRETA. Esta é a conduta preconizada pelo Guia de Mudanças Climáticas e Saúde do Ministério da Saúde (2025). Durante ondas de calor, pacientes idosos em uso de diuréticos e vasodilatadores têm risco aumentado de hipotensão, síncope e lesão renal aguda. A recomendação é **reavaliar individualmente** a prescrição, considerando redução temporária das doses desses medicamentos, associada a orientações de hidratação adequada e medidas de proteção térmica (evitar exposição solar, buscar ambientes frescos). Perceba que não é suspensão total, mas ajuste criterioso.

(C) ✗ INCORRETA. Suspender todos os anti-hipertensivos abruptamente é uma conduta perigosa! O paciente hipertenso tem risco de rebote pressórico, além de complicações cardiovasculares (AVC, IAM) caso fique sem tratamento. A recomendação é o ajuste individualizado, não a suspensão completa. Lembre-se: o objetivo é equilibrar o risco do calor com o risco da hipertensão não

controlada.

(D) X INCORRETA. Os betabloqueadores **não são alternativa segura** durante ondas de calor. Eles reduzem a capacidade de taquicardia compensatória, prejudicando a adaptação cardiovascular ao estresse térmico. Além disso, a simples troca de classe medicamentosa não resolve o problema da depleção volêmica já instalada. A conduta correta envolve reavaliação global da prescrição, não apenas substituição de uma classe por outra.

RESUMO (TLDR)

Ondas de Calor e Manejo na APS: O Essencial

O calor extremo é um agravo climático que exige atenção especial na APS, principalmente em populações vulneráveis.

1. Populações de Risco

- Idosos, crianças, doentes crônicos, trabalhadores ao ar livre

2. Medicamentos que Aumentam o Risco

- Diuréticos (depleção volêmica)
- Vasodilatadores (hipotensão)
- Betabloqueadores (reduzem taquicardia compensatória)

3. Conduta Durante Onda de Calor

- Reavaliar prescrição individualmente
- Considerar redução temporária de diuréticos/vasodilatadores
- Reforçar hidratação e proteção térmica
- Monitorar ativamente pacientes vulneráveis

Pérola

A resposta certa nunca é "suspender tudo" nem "manter igual" — é **individualizar o cuidado**.

QUESTÃO 58 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Saúde Ambiental ■ Gabarito: B

Uma médica de família atua em uma UBS localizada em município do interior do Nordeste, região que enfrenta seca severa há três anos consecutivos. Durante reunião de equipe, ela apresenta dados preocupantes: aumento de 40% nas internações por doença diarreica aguda em menores de 5 anos, elevação dos casos de dermatoses infecciosas e surto de conjuntivite bacteriana. A análise dos prontuários revela que as famílias afetadas residem em áreas onde a intermitência no abastecimento de água é mais crítica, obrigando o uso de fontes alternativas sem tratamento adequado. Considerando os conceitos de Vigilância Ambiental em Saúde e a abordagem dos determinantes socioambientais, qual é a interpretação mais adequada dessa situação?

(A) O aumento das doenças infecciosas decorre exclusivamente de falha comportamental das famílias, que deveriam ferver a água antes do consumo, independentemente das condições estruturais.

(B) ✓ A escassez hídrica configura um determinante ambiental distal que amplifica vulnerabilidades, devendo a equipe articular ações intersetoriais além das medidas clínicas individuais.

(C) A vigilância epidemiológica deve aguardar a confirmação laboratorial de todos os casos antes de iniciar qualquer intervenção de controle no território.

(D) O problema está fora do escopo da Atenção Primária, cabendo à equipe apenas encaminhar os casos para serviços especializados de infectologia.

COMENTÁRIOS

(A) X INCORRETA. Esta alternativa representa a falácia da "culpabilização da vítima" (*victim blaming*). Atribuir exclusivamente às famílias a responsabilidade pelo adoecimento ignora completamente os determinantes estruturais que condicionam suas escolhas. Quando o abastecimento de água é intermitente, as famílias não têm outra opção senão recorrer a fontes alternativas. Ferver água exige combustível (gás, lenha), que também pode estar escasso em contexto de pobreza. As DCN de Medicina e os princípios da Atenção Primária à Saúde preconizam uma abordagem que considere os determinantes socioambientais, não apenas comportamentos individuais isolados.

(B) ✓ CORRETA. Esta alternativa demonstra compreensão adequada do modelo de Dahlgren & Whitehead: a escassez hídrica é um determinante distal (camadas externas) que se propaga através das condições de vida até gerar adoecimento. A resposta apropriada envolve: (1) reconhecer que o problema transcende o consultório médico; (2) articular ações intersetoriais com saneamento, defesa civil e assistência social; (3) realizar vigilância ativa no território através do VIGIÁGUA; (4) implementar medidas clínicas e estruturais simultaneamente. Isso está alinhado às competências preconizadas pelas DCN de Medicina e aos princípios da Vigilância Ambiental em Saúde.

(C) X INCORRETA. A vigilância epidemiológica não deve aguardar confirmação laboratorial de todos os casos para agir. O princípio da **oportunidade** determina que as ações de controle devem ser iniciadas o mais rapidamente possível, mesmo com base

em dados clínico-epidemiológicos. Esperar confirmação laboratorial de cada caso atrasaria a resposta e permitiria a ampliação do surto. O diagnóstico de surto pode ser estabelecido pela ocorrência de casos acima do esperado para aquele território e período, mesmo sem confirmação laboratorial universal.

(D) X INCORRETA. Esta alternativa contradiz frontalmente os princípios da Atenção Primária à Saúde e as atribuições da Estratégia Saúde da Família. A APS é a porta de entrada preferencial do sistema e deve ser **resolutiva** para a maioria dos problemas de saúde da população. Doenças diarreicas, dermatoses e conjuntivites bacterianas são condições de manejo na APS. Além disso, a equipe tem papel fundamental na identificação de determinantes territoriais, vigilância em saúde e articulação intersetorial — funções que não podem ser "terceirizadas" para especialistas.

RESUMO (TLDR)

Saúde Ambiental: O Que Realmente Importa?

A escassez hídrica não é apenas "falta de água" — é um determinante distal que amplifica vulnerabilidades.

1. Modelo de Dahlgren & Whitehead

- Determinantes em camadas: do individual ao macrosocial
- Água e saneamento estão nas camadas distais
- Efeitos se propagam para camadas proximais

2. Vigilância Ambiental em Saúde

- **VIGIÁGUA:** monitora qualidade da água para consumo
- **VIGISOLO:** contaminação do solo
- **VIGIDESASTRES:** impactos de desastres naturais

3. Papel do Médico na APS

- Identificar determinantes territoriais
- Articular ações intersetoriais
- Não culpabilizar famílias por falhas estruturais

Pérola

Alternativas que responsabilizam exclusivamente o indivíduo por problemas estruturais são SEMPRE incorretas em questões de Saúde Coletiva!

QUESTÃO 59 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Sistemas de Saúde ■ Gabarito: C

Durante uma aula sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), o professor questiona os alunos sobre os princípios doutrinários que fundamentam a organização do sistema. Qual dos princípios a seguir garante que todo cidadão brasileiro tenha direito ao acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de cor, renda ou local de moradia?

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) ✓ **Universalidade.**
- (D) Descentralização.

COMENTÁRIOS

(A) X INCORRETA. A **Equidade** é o princípio que reconhece as diferenças nas condições de vida e saúde das pessoas, oferecendo mais recursos para quem tem maior necessidade. É o conceito de "tratar desigualmente os desiguais". A equidade não fala sobre o acesso de todos, mas sim sobre a **priorização** e distribuição justa dos recursos. A questão pergunta especificamente sobre o direito de acesso para todos, o que caracteriza a Universalidade.

(B) X INCORRETA. A **Integralidade** refere-se à visão ampliada do processo saúde-doença, considerando o indivíduo em sua totalidade biopsicossocial. Também significa que o sistema deve oferecer desde ações de promoção e prevenção até tratamento e reabilitação. A integralidade responde à pergunta "O QUE é oferecido?", não "QUEM tem direito?".

(C) ✓ CORRETA. A **Universalidade** é exatamente o princípio que garante que a saúde é direito de TODOS os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação. Conforme o Art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado". Isso significa que qualquer pessoa, independentemente de cor, renda, religião, local de moradia ou vínculo empregatício, tem direito ao acesso às ações e serviços de saúde.

(D) X INCORRETA. A **Descentralização** é um princípio ORGANIZATIVO (não doutrinário!) que define a transferência de responsabilidades da esfera federal para estados e, principalmente, municípios. Está relacionado à gestão e execução das políticas de saúde, não ao direito de acesso da população.

RESUMO (TLDR)

Princípios do SUS: O Que Realmente Importa?

Os princípios doutrinários são a base filosófica do SUS e caem em toda prova!

1. Os Três Princípios Doutrinários

- **Universalidade:** Direito de TODOS ao acesso
- **Equidade:** Dar mais a quem precisa mais
- **Integralidade:** Visão integral do indivíduo e do sistema

2. Não Confunda!

- Descentralização, Regionalização e Participação Social são princípios **ORGANIZATIVOS**

3. Pérola

Universalidade = QUEM (todos) | Equidade = QUANTO (conforme necessidade) | Integralidade = O QUÊ (tudo)

QUESTÃO 60 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Sistemas de Saúde ■ Gabarito: C

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família está organizando uma capacitação para agentes comunitários de saúde sobre os princípios do Sistema Único de Saúde. Durante a discussão, surge uma dúvida sobre quais são os princípios organizativos (diretrizes) do SUS, conforme estabelecido na Lei nº 8.080/90. Dentre os princípios abaixo, qual representa corretamente uma diretriz organizativa do SUS?

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado de ações e serviços.
- (C) ✓ **Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.**
- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A Universalidade de acesso é um **princípio doutrinário** (ético) do SUS, não uma diretriz organizativa. Ela representa o valor de que todos têm direito à saúde, independentemente de contribuição previdenciária. É o "porquê" do SUS existir, não o "como" ele se organiza.

(B) ✗ **INCORRETA.** A Integralidade de assistência também é um **princípio doutrinário** do SUS. Ela preconiza que o usuário deve ser visto como um todo, com acesso a ações preventivas e curativas, em todos os níveis de complexidade. Assim como a universalidade, é um valor fundamental, não uma estratégia organizacional.

(C) ✓ **CORRETA.** A Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo é uma **diretriz organizativa** (princípio organizativo) do SUS. Ela define COMO o sistema deve ser estruturado: redistribuindo poder entre União, Estados e Municípios, mas garantindo que cada esfera tenha apenas um gestor responsável. Está prevista tanto na CF/88 (Art. 198) quanto na Lei 8.080/90.

(D) ✗ **INCORRETA.** A Igualdade da assistência à saúde está listada no Art. 7º, inciso IV, da Lei 8.080/90 como um dos princípios do SUS. No entanto, ela NÃO é classificada como um dos três **princípios doutrinários** clássicos — que são Universalidade, Integralidade e Equidade (mnemônico: UIE). A Igualdade é um princípio ético-legal previsto na legislação, mas não integra a tríade doutrinária. Além disso, Igualdade (tratar todos da mesma forma) é conceitualmente diferente de Equidade (tratar diferente quem precisa mais — justiça distributiva). A alternativa D, portanto, não representa uma diretriz organizativa do SUS, sendo um princípio ético-legal, e não organizativo.

RESUMO (TLDR)

Princípios do SUS: O Que Realmente Importa?

A Lei 8.080/90 lista os princípios do SUS, mas eles se dividem em dois grupos:

1. Princípios Doutrinários (Valores)

- **Universalidade:** Todos têm direito
- **Integralidade:** Assistência completa
- **Equidade:** Priorizar quem mais precisa

2. Princípios Organizativos (Diretrizes)

- **Descentralização:** Poder distribuído, gestor único por esfera
- **Regionalização:** Redes organizadas por território
- **Participação:** Controle social (Conselhos/Conferências)

3. Pérola

Se a questão pedir "diretriz" ou "princípio organizativo", a resposta será Descentralização, Regionalização ou Participação da Comunidade!

QUESTÃO 61 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Fundamentos da Epidemiologia ■ Gabarito: B

Gestante de 28 anos, primigesta com 10 semanas, comparece à Unidade Básica de Saúde para primeira consulta de pré-natal. Nega comorbidades e uso de medicamentos. O médico solicita exames de rotina, incluindo sorologias para HIV, sífilis, hepatites B e C, toxoplasmose, hemograma, glicemia de jejum, urina tipo I e tipagem sanguínea com fator Rh. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para rastreamento no pré-natal, a solicitação dessas sorologias representa qual tipo de prevenção?

- (A) Prevenção primária.
- (B) ✓ **Prevenção secundária.**
- (C) Prevenção terciária.
- (D) Prevenção quaternária.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - A prevenção primária ocorre **antes** da doença existir no indivíduo. São medidas que visam reduzir a incidência, evitando que novos casos apareçam. Exemplos incluem vacinação, uso de preservativo, suplementação de ácido fólico periconcepcional. No caso das sorologias do pré-natal, não estamos evitando que a infecção ocorra; estamos buscando detectar infecções que **podem já estar presentes**. Portanto, não se trata de prevenção primária.

(B) ✓ **CORRETA** - A prevenção secundária engloba o diagnóstico precoce e o tratamento imediato de doenças já instaladas, mesmo que assintomáticas. O rastreamento (screening) é o exemplo clássico de prevenção secundária. As sorologias do pré-natal buscam identificar gestantes que possam ter HIV, sífilis ou hepatites **sem saber**, permitindo tratamento precoce para evitar a progressão da doença e, principalmente, a transmissão vertical. Como a doença pode já existir biologicamente na gestante, mesmo sem sintomas, a detecção precoce caracteriza prevenção secundária.

(C) ✗ **INCORRETA** - A prevenção terciária ocorre quando a doença já causou sequelas ou incapacidades estabelecidas. O foco é a **reabilitação** e a reintegração social do paciente. Exemplos incluem fisioterapia pós-AVC, reabilitação cardíaca após infarto, uso de próteses. No caso apresentado, a gestante está assintomática e não apresenta sequelas de doença; está sendo rastreada para detecção precoce de possíveis infecções.

(D) ✗ **INCORRETA** - A prevenção quaternária visa proteger o paciente de intervenções médicas desnecessárias ou potencialmente danosas (iatrogenia). Exemplos incluem evitar exames sem indicação, desprescrever medicamentos sem benefício e não realizar rastreamentos sem evidência. No caso apresentado, as sorologias do pré-natal são recomendadas pelo Ministério da Saúde com evidência de benefício na redução da transmissão vertical. Portanto, solicitar esses exames **não** configura excesso de intervenção.

RESUMO (TLDR)

Níveis de Prevenção: O Essencial

Os níveis de prevenção se relacionam com o momento da história natural da doença.

1. Prevenção Primária

- Ocorre **antes** da doença existir
- Objetivo: reduzir incidência
- Exemplos: vacinação, preservativo, ácido fólico

2. Prevenção Secundária

- Doença **já existe** (mesmo assintomática)
- Objetivo: diagnóstico precoce e tratamento
- Exemplos: **sorologias pré-natal**, mamografia, Papanicolaou

3. Prevenção Terciária

- Doença causou **sequelas**
- Objetivo: reabilitação
- Exemplos: fisioterapia pós-AVC

Pérola

Rastreamento = busca de doença em assintomáticos = **Secundária**

QUESTÃO 62 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Programas de Rastreamento ■ Gabarito: A

Mulher de 52 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Relata não realizar exames preventivos há mais de 5 anos. Nega comorbidades, uso de medicamentos ou história familiar de neoplasias. Ao exame físico: IMC de 26 kg/m², PA de 118 x 76 mmHg, sem alterações à inspeção das mamas ou ao exame ginecológico. A paciente questiona sobre quais exames de rastreamento de câncer estão indicados para ela neste momento, conforme as diretrizes atuais do Ministério da Saúde. A conduta correta é solicitar

- (A) ✓ **mamografia bienal e teste de DNA-HPV oncogênico, pois ambos estão indicados no rastreamento organizado para a faixa etária da paciente.**
- (B) mamografia anual e citopatológico do colo uterino, conforme recomendação exclusiva das sociedades médicas brasileiras.
- (C) mamografia bienal e citopatológico do colo uterino trienal, sendo a pesquisa de sangue oculto nas fezes opcional.
- (D) apenas mamografia bienal, pois o rastreamento de câncer de colo uterino não está mais indicado após os 50 anos.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Conforme as diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde publicadas em 2025, a paciente de 52 anos está dentro da faixa etária para ambos os rastreamentos organizados: (1) **Câncer de colo uterino:** A Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 13/2025 estabeleceu o teste de DNA-HPV oncogênico como método primário de rastreamento para mulheres de 25 a 64 anos, a cada 5 anos; (2) **Câncer de mama:** Mamografia bienal dos 50 aos 69 anos como rastreamento populacional organizado. Portanto, ambos os exames estão corretamente indicados para esta paciente.

(B) ✗ **INCORRETA.** Esta alternativa contém dois erros: (1) A mamografia **anual** é recomendação de sociedades médicas (FEBRASGO/SBM/CBR), e não do Ministério da Saúde, que preconiza periodicidade **bienal**; (2) O citopatológico do colo uterino não é mais o método primário de rastreamento segundo a Portaria SAES/SECTICS nº 13/2025 – foi substituído pelo teste de DNA-HPV oncogênico, passando a citologia a ser exame reflexo. Em provas que pedem "diretrizes do MS", siga estritamente as recomendações ministeriais.

(C) ✗ **INCORRETA.** Embora a mamografia bienal esteja correta, o citopatológico trienal não corresponde à diretriz atual do MS. A Portaria SAES/SECTICS nº 13/2025 estabeleceu o **teste de DNA-HPV oncogênico** como método primário, com periodicidade de 5 anos. A citologia passa a ser exame reflexo (realizada quando o teste DNA-HPV é positivo), e não mais o rastreamento inicial. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, embora possa ser oferecida oportunisticamente, não integra programa de rastreamento organizado pelo MS.

(D) ✗ **INCORRETA.** O rastreamento de câncer de colo uterino continua indicado para mulheres de **25 a 64 anos** que já iniciaram atividade sexual, conforme a Portaria SAES/SECTICS nº 13/2025. A paciente de 52 anos está dentro dessa faixa etária e deve realizar o teste de DNA-HPV oncogênico. Não existe limite de 50 anos para interrupção desse rastreamento – a faixa vai até os 64 anos.

RESUMO (TLDR)

Rastreamento Oncológico MS 2025: O Que Realmente Importa?

O Ministério da Saúde atualizou as diretrizes de rastreamento em 2025.

1. Câncer de Colo Uterino (NOVIDADE!)

- Método primário: **Teste de DNA-HPV oncogênico**
- Faixa etária: 25-64 anos
- Periodicidade: A cada **5 anos**
- Citologia: Agora é exame **reflexo** (quando HPV+)

2. Câncer de Mama

- Método: Mamografia
- Faixa etária organizada: 50-69 anos
- Periodicidade: **Bienal**
- Acesso ampliado: A partir de 40 anos (sob demanda)

3. Pérola

Perguntou "diretrizes do MS"? Marque DNA-HPV + mamografia bienal. Papanicolau trienal e mamografia anual são passado ou sociedades médicas!

QUESTÃO 63 ■ Medicina de Família e Comunidade / Saúde Coletiva ■ Saúde Global ■
Gabarito: A

Médico de família e comunidade atua em Unidade Básica de Saúde localizada em município da região sudeste. Nas últimas três semanas, identificou aumento significativo no número de pacientes com quadro febril agudo, acompanhado de cefaleia intensa, mialgia, artralgia e exantema maculopapular. A maioria dos casos ocorreu em moradores de bairros com precária infraestrutura sanitária e acúmulo de recipientes com água parada nos quintais. O profissional realizou notificação dos casos suspeitos ao sistema de vigilância epidemiológica local e agora precisa orientar a equipe sobre as medidas prioritárias de controle. Considerando tratar-se de provável surto de arbovirose urbana, a conduta mais adequada para o controle da transmissão nesse cenário é

- (A) ✓ **realizar busca ativa de casos febris na comunidade e intensificar ações de eliminação de criadouros do vetor.**
- (B) solicitar bloqueio vacinal em massa para toda a população residente nos bairros afetados.
- (C) prescrever quimioprofilaxia com doxiciclina para os contactantes domiciliares dos casos confirmados.
- (D) recomendar isolamento respiratório domiciliar de todos os casos suspeitos por período de 14 dias.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Essa é a conduta padrão-ouro no controle de surtos de arboviroses urbanas! A **busca ativa de casos febris** permite identificar pacientes que não procuraram atendimento espontaneamente, melhorando a vigilância epidemiológica e possibilitando manejo precoce. A **intensificação das ações de eliminação de criadouros** do *Aedes aegypti* é a medida mais efetiva para interromper a cadeia de transmissão, já que não há vacina em uso rotineiro para todas as arboviroses nem quimioprofilaxia disponível. As Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle das Arboviroses Urbanas (2024) enfatizam essa integração entre vigilância epidemiológica e controle vetorial como estratégia central.

(B) ✗ **INCORRETA.** Não existe vacina disponível para bloqueio de surto de arboviroses urbanas em geral. A vacina contra dengue (Qdenga®) está disponível no SUS desde 2024, mas tem indicações específicas (crianças de 10-14 anos em áreas endêmicas) e **não é utilizada para bloqueio vacinal em situações de surto**. Não há vacinas aprovadas para Zika ou Chikungunya. O bloqueio vacinal é estratégia utilizada para doenças imunopreveníveis com vacinas eficazes (ex: sarampo, febre amarela), não sendo aplicável ao cenário descrito.

(C) ✗ **INCORRETA.** A doxiciclina é utilizada como quimioprofilaxia para **leptospirose** em situações de exposição de risco (enchentes, por exemplo), mas **não tem indicação para arboviroses**. Não existe quimioprofilaxia eficaz para dengue, Zika ou Chikungunya. A transmissão dessas doenças ocorre pela picada do mosquito infectado, e não há medicamento capaz de prevenir a infecção nos contactantes. O tratamento das arboviroses é de suporte (hidratação, analgésicos, repouso).

(D) ✗ **INCORRETA.** O isolamento respiratório é indicado para doenças de transmissão por via aérea ou gotículas (ex: tuberculose, COVID-19, sarampo). As arboviroses têm **transmissão vetorial** (pelo mosquito *Aedes aegypti*), não respiratória. Portanto, isolamento respiratório é uma medida completamente inadequada e sem fundamento epidemiológico para esse cenário. A recomendação para pacientes com arboviroses é o uso de mosquiteiros e repelentes para evitar que o mosquito pique o doente e se infecte, perpetuando o ciclo de transmissão.

RESUMO (TLDR)

Arboviroses e Doenças Emergentes: O Que Realmente Importa?

As arboviroses urbanas (dengue, Zika, chikungunya) são transmitidas pelo *Aedes aegypti* e representam o principal desafio de doenças emergentes/reemergentes no Brasil.

1. Controle de Surtos - Os Dois Pilares

- **Vigilância epidemiológica ativa:** busca ativa de casos febris
- **Controle vetorial:** eliminação de criadouros é a medida mais efetiva

2. O Que NÃO Funciona

- Vacinação de bloqueio (não disponível)
- Quimioprofilaxia (não existe)
- Isolamento respiratório (transmissão é vetorial!)

3. Pérola Final

Em surtos de arboviroses, sempre pense: "**o problema é o mosquito, não o ar**" → Ataque o vetor, não isole o paciente!

VI. Urgência / Emergência

QUESTÃO 64 ■ Urgência / Emergência ■ Abdome Agudo ■ Gabarito: B

Homem de 45 anos, etilista crônico, é admitido no pronto-socorro com dor abdominal em faixa, de forte intensidade, com irradiação para o dorso, iniciada há 18 horas após episódio de libação alcoólica. Refere náuseas e vômitos persistentes. Ao exame físico: regular estado geral, desidratado ++/4+, taquicárdico (FC 110 bpm), febril (38,1°C), abdome distendido, doloroso difusamente à palpação, com defesa em epigástrio, ruídos hidroaéreos diminuídos. Exames laboratoriais: amilase 1.450 U/L (VR: até 100 U/L), lipase 2.100 U/L (VR: até 60 U/L), leucócitos 16.500/mm³, ureia 58 mg/dL, glicemia 180 mg/dL. A conduta inicial mais adequada para este paciente é

- (A) laparotomia exploradora de urgência para drenagem do pâncreas.
- (B) ✓ **hidratação venosa vigorosa, analgesia e jejum com monitorização clínica.**
- (C) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica nas primeiras 24 horas.
- (D) antibioticoterapia de amplo espectro imediata associada a nutrição parenteral.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - A laparotomia exploradora de urgência **não está indicada** no manejo inicial da pancreatite aguda. A cirurgia na fase aguda está associada a maior morbimortalidade. A intervenção cirúrgica é reservada para complicações tardias, como necrose pancreática infectada (geralmente após 4 semanas, quando há melhor demarcação do tecido necrótico) ou pseudocistos sintomáticos. Operar precocemente um pâncreas inflamado e edemaciado aumenta o risco de sangramento, fístulas e não melhora o desfecho.

(B) ✓ **CORRETA** - Este é o tripé clássico do manejo inicial da pancreatite aguda: **hidratação venosa vigorosa** (Ringer lactato, 250-500 mL/h inicialmente), **analgesia** (opioides são seguros) e **jejum** com monitorização. A ressuscitação volêmica agressiva nas primeiras 12-24 horas é crucial para prevenir necrose pancreática e falência orgânica. A monitorização permite identificar precocemente sinais de deterioração e ajustar a terapêutica.

(C) **X INCORRETA** - A CPRE precoce está indicada apenas em pancreatite de etiologia **biliar** associada a **colangite aguda** ou **obstrução biliar persistente**. No caso apresentado, a etiologia é claramente **alcoólica** (etilista crônico + libação prévia), não havendo indicação de CPRE. Realizar CPRE desnecessariamente expõe o paciente aos riscos do procedimento, incluindo perfuração e piora da pancreatite.

(D) **X INCORRETA** - A antibioticoterapia profilática **não é recomendada** na pancreatite aguda. Estudos demonstraram que não previne necrose infectada e aumenta o risco de infecções fúngicas e resistência bacteriana. Antibióticos estão indicados apenas quando há **necrose infectada documentada** (punção guiada por imagem com cultura positiva ou gás na TC). Quanto à nutrição parenteral, ela é reservada para casos onde a via enteral está contraindicada; a preferência atual é pela nutrição enteral precoce.

RESUMO (TLDR)

Pancreatite Aguda: O Que Realmente Importa?

O manejo inicial é **sempre clínico** – a cirurgia só entra em complicações tardias!

1. Diagnóstico (Atlanta)

- 2 de 3: dor típica + enzimas $\geq 3 \times$ LSN + imagem compatível
- Lipase > amilase em especificidade

2. Tratamento Inicial (HAJ)

- Hidratação vigorosa (Ringer lactato)
- Analgesia (opioides são seguros)
- Jejum com realimentação precoce

3. O Que NÃO Fazer

- Cirurgia de urgência
- Antibiótico profilático
- CPRE (exceto se biliar + colangite)

Pérola

Ringer lactato nas primeiras 12-24h é a intervenção mais importante – reduz necrose e mortalidade!

QUESTÃO 65 ■ Urgência / Emergência ■ Trauma e Emergência ■ Gabarito: C

Homem de 28 anos é trazido pelo SAMU ao pronto-socorro após ferimento por arma branca em região anterior do abdome, em mesogástrio. No atendimento inicial, apresenta-se consciente, orientado, com pressão arterial de 118 x 76 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e frequência respiratória de 18 irpm. O abdome apresenta ferimento único de aproximadamente 3 cm, sem sangramento ativo externo, com dor à palpação superficial perilesional, sem sinais de irritação peritoneal difusa. Realizada exploração local do ferimento sob anestesia, que evidenciou violação da aponeurose anterior da musculatura abdominal. Considerando o quadro clínico e os achados da exploração, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Realizar tomografia computadorizada de abdome com triplo contraste.
- (B) Indicar laparotomia exploradora imediata devido à violação fascial.
- (C) ✓ **Realizar videolaparoscopia diagnóstica para avaliação da cavidade.**
- (D) Manter observação clínica e alta hospitalar com reavaliação ambulatorial.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A tomografia computadorizada com triplo contraste (oral, retal e endovenoso) é uma excelente ferramenta diagnóstica, porém sua indicação principal é para ferimentos em **flanco** ou **dorso**, onde a musculatura é mais espessa e há estruturas retroperitoneais (rim, duodeno, cólon ascendente/descendente) que não são adequadamente avaliadas pela laparoscopia. Para ferimentos na parede abdominal **anterior**, como no caso apresentado (mesogástrio), a videolaparoscopia oferece vantagens superiores: visualização direta, possibilidade de tratamento simultâneo e menor taxa de exames inconclusivos.

(B) **X INCORRETA.** A laparotomia exploradora imediata baseada apenas na violação fascial é uma conduta **ultrapassada**. Essa abordagem resulta em taxas de laparotomia não terapêutica de 30-40%, com morbidade significativa (infecção de sítio cirúrgico, íleo prolongado, aderências, hérnia incisional). O paciente está hemodinamicamente estável, sem peritonite, sem evisceração — portanto, não há indicação de cirurgia imediata. A conduta moderna preconiza investigação complementar com laparoscopia ou TC para definir a real necessidade de intervenção.

(C) ✓ **CORRETA.** A videolaparoscopia diagnóstica é o **padrão-ouro** para avaliação de ferimentos por arma branca na parede abdominal anterior com violação fascial comprovada em pacientes hemodinamicamente estáveis. O método permite visualização direta da cavidade peritoneal, identificação de lesões específicas e, em casos selecionados, tratamento definitivo por via minimamente invasiva. A grande vantagem é a redução das taxas de laparotomia não terapêutica para menos de 5%, com menor morbidade que a cirurgia aberta.

(D) **X INCORRETA.** Esta alternativa representa negligência grave. O paciente apresenta violação fascial comprovada, ou seja, o objeto penetrou a cavidade abdominal. Dar alta sem investigação adequada coloca o paciente em risco de lesões não diagnosticadas (perfuração intestinal, lesão hepática, lesão diafragmática) que podem evoluir para peritonite, sepse e óbito. A observação clínica isolada, sem método de imagem ou laparoscopia, é insuficiente para excluir lesões potencialmente fatais.

RESUMO (TLDR)**FAB Abdominal: O Que Realmente Importa?**

No trauma penetrante por arma branca, a estabilidade hemodinâmica define a conduta.

1. Indicações de Laparotomia Imediata

- Instabilidade hemodinâmica
- Peritonite difusa
- Evisceração
- Empalamento

2. Paciente Estável com Violação Fascial

- **Parede anterior:** Videolaparoscopia (padrão-ouro)
- **Flanco/dorso:** TC com triplo contraste

3. Pérola

Laparotomia mandatória por violação fascial é conduta ultrapassada — resulta em 30-40% de cirurgias desnecessárias!

QUESTÃO 66 ■ Urgência / Emergência ■ Abdome Agudo ■ Gabarito: B

Homem de 72 anos, hipertenso e portador de fibrilação atrial crônica, é trazido ao pronto-socorro com dor abdominal intensa, de início súbito há 6 horas, localizada na região periumbilical. Refere que há 1 semana não está tomando os medicamentos por falta de receita. Ao exame físico, encontra-se ansioso, sudoreico, taquicárdico (FC 110 bpm) e normotenso. O abdome está flácido, levemente distendido, com dor difusa à palpação profunda, porém sem sinais de irritação peritoneal. Em relação à fisiopatologia dessa condição, é correto afirmar que:

- (A) a obstrução venosa mesentérica é a causa mais frequente nesse perfil clínico.
(B) ✓ a embolia arterial mesentérica decorre da formação de trombos em câmaras cardíacas.
(C) a isquemia não oclusiva ocorre por oclusão mecânica direta da artéria mesentérica.
(D) a trombose arterial mesentérica está associada predominantemente a estados de hipercoagulabilidade.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA** - A trombose venosa mesentérica é a causa **menos frequente** de isquemia mesentérica aguda, correspondendo a apenas 5-15% dos casos. Ela está associada a estados de hipercoagulabilidade (trombofilias, neoplasias, uso de anticoncepcionais), e não ao perfil clínico apresentado na questão (paciente com fibrilação atrial e suspensão de anticoagulação). Neste paciente idoso com FA, o mecanismo mais provável é a embolia arterial.

(B) ✓ **CORRETA** - Olha só, esta é a resposta! A embolia arterial mesentérica é a causa mais comum de isquemia mesentérica aguda (40-50% dos casos) e decorre da formação de **trombos nas câmaras cardíacas**, especialmente no átrio esquerdo em pacientes com fibrilação atrial. O êmbolo se desloca pela aorta e se aloja na artéria mesentérica superior. O cenário clínico é clássico: paciente idoso com FA que suspendeu anticoagulação há 1 semana, apresentando dor abdominal súbita e intensa, desproporcional ao exame físico.

(C) ✗ **INCORRETA** - A isquemia mesentérica não oclusiva (NOMI) ocorre justamente pelo mecanismo **oposto** ao descrito na alternativa. Não há oclusão mecânica direta do vaso! O mecanismo é a **vasoconstrição esplâncnica** em resposta a estados de baixo débito cardíaco (choque, uso de drogas vasoativas, pós-operatório de cirurgia cardíaca). É o tipo mais traiçoeiro porque não há obstrução demonstrável na angiografia.

(D) ✗ **INCORRETA** - Esta alternativa confunde os mecanismos etiológicos. A trombose **arterial** mesentérica está associada à **aterosclerose**, com formação de trombo sobre placa aterosclerótica preexistente. São pacientes com doença arterial difusa e frequentemente com história de "angina mesentérica" (dor pós-prandial crônica). Já os estados de hipercoagulabilidade estão associados à trombose **venosa** mesentérica, não à arterial.

RESUMO (TLDR)**Isquemia Mesentérica Aguda: O Que Realmente Importa?**

Condição grave com mortalidade >60% se diagnóstico tardio. A chave é a **alta suspeição clínica**.

1. Classificação Etiológica

- **Embolia arterial (40-50%)**: Mais comum! Trombo cardíaco em FA, valvopatias, IAM
- **Trombose arterial (20-35%)**: Aterosclerose, história de "angina mesentérica"
- **NOMI (20-25%)**: Vasoconstrição sem obstrução, pacientes em choque/UTI
- **Trombose venosa (5-15%)**: Hipercoagulabilidade, neoplasias

2. Quadro Clínico Clássico

- Dor abdominal intensa e súbita
- **Dor desproporcional ao exame físico** (abdome flácido, sem peritonismo)
- Fatores de risco cardiovascular

3. Pérola

Paciente com FA que suspendeu anticoagulação + dor abdominal súbita = **embolia arterial mesentérica até prova em contrário!**

QUESTÃO 67 ■ Urgência / Emergência ■ Cirurgia Neonatal e Emergências ■ Gabarito: B

Recém-nascido a termo, sexo feminino, nascida de parto cesáreo por apresentação pélvica, Apgar 8/9, peso de nascimento 2.850g. Ultrassonografia pré-natal do terceiro trimestre evidenciava polidrâmnio moderado e dilatação de alças intestinais fetais. Nas primeiras 12 horas de vida, a mãe relata que a criança apresentou dois episódios de vômitos biliosos e não eliminou mecônio. Ao exame físico, o recém-nascido encontra-se irritado, com abdome globoso e distendido, timpânico à percussão, sem sinais de irritação peritoneal. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Foi realizada radiografia de abdome na incidência anteroposterior, que evidenciou distensão de múltiplas alças intestinais com níveis hidroaéreos escalonados e ausência de gás na ampola retal. Considerando a principal hipótese diagnóstica e os achados clínico-radiológicos, qual a conduta mais adequada para este caso?

- (A) Realizar enema opaco terapêutico com solução de N-acetilcisteína diluída.
- (B) ✓ Indicar laparotomia exploradora para ressecção e anastomose intestinal.
- (C) Solicitar teste do suor e iniciar reposição de enzimas pancreáticas.
- (D) Prescrever dieta zero, sonda orogástrica e observação clínica por 48 horas.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** O enema opaco com solução de N-acetilcisteína ou gastrografina é a conduta terapêutica para o **íleo meconial não complicado** (obstrução por mecônio espesso em pacientes com fibrose cística). A substância hiperosmolar atrai água para a luz intestinal, amolecendo o mecônio impactado. Porém, no caso apresentado, os achados radiológicos (múltiplas alças dilatadas com níveis hidroaéreos escalonados) e a ausência de gás retal são compatíveis com **atresia intestinal**, uma obstrução mecânica completa que não responderá a enema terapêutico. O enema diagnóstico mostraria microcólon (cólon de desuso), confirmando a obstrução proximal.

(B) ✓ **CORRETA.** Diante de um recém-nascido com vômitos biliosos, distensão abdominal, ausência de eliminação de mecônio e radiografia mostrando múltiplas alças dilatadas com níveis hidroaéreos escalonados, a principal hipótese é **atresia jejunoileal**. O tratamento é **cirúrgico obrigatório**: laparotomia exploradora para ressecção do segmento atrésico e anastomose primária. Não existe tratamento conservador para atresia intestinal verdadeira. A cirurgia deve ser realizada após estabilização clínica inicial (hidratação, descompressão gástrica, correção eletrolítica), mas não deve ser postergada indefinidamente.

(C) ✗ **INCORRETA.** O teste do suor é o exame padrão-ouro para diagnóstico de **fibrose cística**, condição associada ao íleo meconial. Embora o íleo meconial também curse com obstrução intestinal neonatal, sua apresentação radiológica típica mostra aspecto de "vidro fosco" ou "bolhas de sabão" no quadrante inferior direito (ar misturado ao mecônio espesso), diferente do padrão de múltiplas alças dilatadas com níveis hidroaéreos escalonados. Além disso, mesmo que houvesse suspeita de fibrose cística, a investigação não substituiria a necessidade de tratamento cirúrgico da obstrução mecânica por atresia.

(D) ✗ **INCORRETA.** Embora dieta zero e sondagem orogástrica façam parte das medidas de estabilização inicial, a **observação clínica por 48 horas não é conduta adequada** para um recém-nascido com obstrução intestinal por provável atresia. A atresia jejunoileal não se resolve espontaneamente e a demora na intervenção aumenta os riscos de: perfuração intestinal, deterioração clínica, distúrbios hidroeletrólíticos graves e sepse. Após estabilização inicial (que não deve ultrapassar poucas horas), a cirurgia deve ser indicada.

RESUMO (TLDR)

Atresias Intestinais Neonatais: O Que Realmente Importa?

Obstrução intestinal congênita com interrupção completa da luz intestinal, exigindo tratamento cirúrgico obrigatório.

1. Suspeitar Quando:

- Vômitos biliosos nas primeiras 24-48h de vida
- Distensão abdominal progressiva
- Ausência ou escassez de eliminação de mecônio
- História pré-natal de polidrâmnio

2. Diferenciação Radiológica:

- **Dupla bolha** = Atresia duodenal
- **Múltiplas alças dilatadas + níveis** = Atresia jejunoileal
- **Vidro fosco em FID** = Íleo meconial

3. Conduta:

- Estabilização inicial: dieta zero + SOG + hidratação
- **Cirurgia:** Ressecção + anastomose (SEMPRE!)
- Enema terapêutico só serve para íleo meconial não complicado

4. Pérola

Vômitos biliosos no RN = emergência cirúrgica até prova em contrário. Nunca "observar" uma obstrução intestinal neonatal!

QUESTÃO 68 ■ Urgência / Emergência ■ Trauma Cranioencefálico (TCE) ■ Gabarito: B

Homem de 62 anos, em uso regular de varfarina por fibrilação atrial, é trazido ao pronto-socorro após queda da própria altura há 4 horas. Familiares relatam que ele bateu a cabeça no chão, permaneceu consciente, mas nas últimas 2 horas apresentou cefaleia progressiva, confusão mental e sonolência. Na admissão: Glasgow 12 (AO 3, RV 4, RM 5), pressão arterial 158 x 92 mmHg, frequência cardíaca 68 bpm. Ao exame neurológico: pupilas isocóricas e fotorreagentes, hemiparesia direita grau III, sinal de Babinski à direita. INR na admissão: 3,8. A tomografia computadorizada de crânio sem contraste é realizada e demonstra a imagem anexa. Considerando o quadro clínico e os achados tomográficos, qual é o diagnóstico e a conduta inicial mais adequada?

(A) Hematoma epidural agudo; reversão da anticoagulação com vitamina K e avaliação neurocirúrgica para craniotomia.

(B) ✓ **Hematoma subdural agudo; reversão urgente da anticoagulação com complexo protrombínico e avaliação neurocirúrgica imediata.**

(C) Contusão cerebral hemorrágica; reversão da anticoagulação com plasma fresco congelado e monitorização clínica intensiva.

(D) Hemorragia subaracnóidea traumática; controle pressórico rigoroso e arteriografia cerebral para pesquisa de aneurisma.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A descrição de "hematoma epidural" não corresponde aos achados de imagem esperados. O hematoma epidural apresenta formato **biconvexo** (em lente) na TC e tipicamente **respeita as suturas cranianas**, pois a dura-máter está aderida firmemente a elas. A imagem descrita no caso (formato em crescente, cruzando suturas) é característica de hematoma subdural. Além disso, a reversão com vitamina K isolada é inadequada em emergências — a vitamina K leva 12-24 horas para fazer efeito, tempo inaceitável em hemorragia intracraniana ativa.

(B) ✓ **CORRETA.** O quadro clínico (idoso, anticoagulado, queda com trauma craniano, deterioração neurológica progressiva com hemiparesia contralateral) associado à imagem típica em crescente que cruza suturas é patognomônico de **Hematoma Subdural Agudo**. A conduta imediata deve incluir: (1) **Reversão urgente da anticoagulação com Complexo Protrombínico (CCP)** — agente de escolha por agir em minutos; (2) Vitamina K 10mg IV concomitante; (3) **Avaliação neurocirúrgica imediata** para definição de craniotomia, dados os sinais de efeito de massa (desvio de linha média, déficit focal). As Brain Trauma Foundation Guidelines recomendam cirurgia quando espessura >10mm ou desvio >5mm.

(C) ✗ **INCORRETA.** A contusão cerebral hemorrágica apresenta-se na TC como área **hiperdensa irregular dentro do parênquima cerebral**, frequentemente com edema perilesional e efeito de massa variável. Não apresenta o formato característico em crescente acompanhando a convexidade. Além disso, o Plasma Fresco Congelado (PFC) não é o agente de escolha para reversão urgente de varfarina — seu início de ação é lento (12-32 horas para correção completa), requer grande volume de infusão e tem risco de TRALI. O CCP é superior em emergências.

(D) ✗ **INCORRETA.** A hemorragia subaracnóidea (HSA) apresenta-se na TC como **hiperdensidade preenchendo cisternas basais e sulcos cerebrais**, não como coleção em crescente na convexidade. Além disso, em contexto claramente traumático como este caso, a investigação com arteriografia para aneurisma não é a prioridade — a HSA traumática tem origem diferente da HSA aneurismática. A conduta prioritária neste paciente é reverter a coagulopatia e tratar o hematoma compressivo.

RESUMO (TLDR)

Hematoma Subdural Agudo: O Que Realmente Importa?

Paciente idoso, anticoagulado, com TCE aparentemente leve que deteriora nas horas seguintes é o cenário clássico do HSD.

1. Diagnóstico por Imagem

- **HSD:** Crescente (côncavo-convexo), CRUZA suturas
- **Epidural:** Lente (biconvexo), RESPEITA suturas

2. Conduta no Anticoagulado

- **CCP 4 fatores:** Agente de escolha (minutos)
- Vitamina K 10mg IV concomitante (manutenção)
- PFC: Segunda linha (lento, grande volume)

3. Indicações Cirúrgicas (BTF Guidelines)

- Espessura >10mm OU desvio >5mm
- Queda ≥2 pontos no Glasgow
- Glasgow ≤8 com lesão cirúrgica

4. Pérola

No idoso com atrofia cerebral, o HSD pode acumular grande volume antes de dar sintomas — a deterioração pode ser súbita e catastrófica!

QUESTÃO 69 ■ Urgência / Emergência ■ Doenças Pleurais ■ Gabarito: C

Homem de 32 anos, vítima de acidente automobilístico, é trazido pelo SAMU à UBS mais próxima do local do acidente. À admissão, apresenta-se agitado, com dispneia intensa e cianose de extremidades. Ao exame físico: pressão arterial de 78 x 50 mmHg, frequência cardíaca de 132 bpm, frequência respiratória de 36 irpm e saturação de oxigênio de 82% em ar ambiente. Observam-se turgência jugular bilateral, desvio da traqueia para a esquerda, ausência de murmúrio vesicular à direita com timpanismo à percussão ipsilateral. A equipe dispõe de materiais básicos de emergência, incluindo agulhas de grosso calibre, mas aguarda a chegada da ambulância de suporte avançado para transferência ao hospital de referência. Considerando o quadro clínico, a conduta imediata mais adequada é

- (A) aguardar transferência para realização de drenagem torácica em centro cirúrgico.
- (B) solicitar radiografia de tórax para confirmação diagnóstica antes de intervir.
- (C) ✓ **realizar toracocentese descompressiva no 2º espaço intercostal direito.**
- (D) iniciar reposição volêmica vigorosa com 2 litros de cristalóide em bolus.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Aguardar transferência para drenagem em centro cirúrgico seria uma conduta **catastrófica** neste caso. O pneumotórax hipertensivo é uma emergência com risco de morte iminente por choque obstrutivo. O paciente apresenta sinais de colapso cardiovascular (PA 78x50, FC 132, SatO₂ 82%) e não sobreviveria ao tempo de espera. A descompressão por agulha é um procedimento simples, que pode ser realizado em qualquer ambiente, inclusive em UBS, e é a medida salvadora de vida neste cenário.

(B) **X INCORRETA.** Solicitar radiografia de tórax para confirmação diagnóstica é um erro clássico de prova. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é **CLÍNICO** — baseado no contexto de trauma, instabilidade hemodinâmica e achados do exame físico (timpanismo, ausência de MV, turgência jugular, desvio de traqueia). O tempo gasto para realizar e interpretar o exame de imagem pode ser fatal. O ATLS 11ª edição é categórico: não se deve aguardar confirmação radiológica em pacientes instáveis.

(C) ✓ **CORRETA.** A toracocentese descompressiva (punção de alívio) no **2º espaço intercostal direito**, linha hemiclavicular, é a conduta imediata salvadora de vida. O paciente apresenta todos os sinais clássicos de pneumotórax hipertensivo à direita: ausência de MV à direita, timpanismo ipsilateral, desvio de traqueia para a esquerda (lado contralateral), turgência jugular e choque. A punção com agulha de grosso calibre permite a saída do ar sob pressão, aliviando o mecanismo valvular e restaurando o retorno venoso. É uma medida temporária até a drenagem definitiva.

(D) **X INCORRETA.** A reposição volêmica vigorosa com 2 litros de cristalóide **não resolve** o choque obstrutivo do pneumotórax hipertensivo. O problema é mecânico: a pressão positiva no hemitórax está comprimindo as grandes veias e impedindo o retorno venoso. Nenhuma quantidade de volume vai conseguir "vencer" essa obstrução mecânica. Além disso, o ATLS 11ª edição recomenda **máximo de 1 litro** de cristalóide como bolus inicial, abandonando a reposição de 2 litros. A conduta correta é descomprimir o tórax primeiro.

RESUMO (TLDR)

Pneumotórax Hipertensivo: O Que Realmente Importa?

É uma emergência com risco de morte iminente por **choque obstrutivo** (não apenas hipóxia).

1. Diagnóstico é CLÍNICO

- Timpanismo + ausência de MV no lado afetado
- Turgência jugular bilateral
- Desvio de traqueia para lado contralateral
- Hipotensão + taquicardia + cianose

2. Conduta Imediata

- **Punção de alívio:** 2º EIC, linha hemiclavicular, lado afetado
- Agulha de grosso calibre (14-16G)
- Depois: drenagem torácica definitiva (5º EIC, linha axilar média)

3. Pérola

NUNCA aguarde radiografia em paciente instável. O tempo mata!

QUESTÃO 70 ■ Urgência / Emergência ■ Distúrbios Hipertensivos na Gestação ■ Gabarito: B

Gestante de 29 anos, tercigesta (G3P2A0), com 32 semanas de idade gestacional, comparece à urgência obstétrica encaminhada da Unidade Básica de Saúde por alteração pressórica. Relata cefaleia frontal há 3 dias que melhora parcialmente com analgésicos comuns. Nega escotomas, epigastralgia ou sangramento vaginal. Pré-natal sem intercorrências até o momento, sem comorbidades prévias. Ao exame: lúcida, orientada, PA 152 x 98 mmHg (confirmada após 15 minutos em repouso), FC 82 bpm, FR 18 irpm. Altura uterina 30 cm, BCF 146 bpm com boa variabilidade, dinâmica uterina ausente. Edema de membros inferiores 2+/4+. Exames laboratoriais realizados na emergência: hemoglobina 12,4 g/dL, plaquetas 185.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL, TGO 28 U/L, TGP 32 U/L, LDH 180 U/L, proteinúria de amostra isolada com relação proteína/creatinina de 0,4. Considerando o quadro clínico e os achados laboratoriais, qual a conduta mais adequada neste momento?

(A) Prescrever sulfato de magnésio, hidralazina endovenosa e proceder à resolução imediata da gestação por cesariana.

(B) ✓ **Internar a paciente, monitorar sinais de deterioração clínica e laboratorial, e avaliar corticoterapia para maturação pulmonar fetal.**

(C) Prescrever metildopa 750 mg/dia, orientar repouso domiciliar e retorno em 48 horas para reavaliação clínica e laboratorial.

(D) Iniciar sulfato de magnésio profilático, anti-hipertensivo oral e programar resolução da gestação ao completar 34 semanas.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - Esta alternativa propõe uma conduta excessivamente agressiva para o caso apresentado. A paciente possui PE **sem sinais de gravidade**: PA < 160/110 mmHg, sem sintomas neurológicos refratários (a cefaleia melhora com analgésicos), exames laboratoriais normais e feto com boa vitalidade. O sulfato de magnésio está indicado na PE com sinais de gravidade ou iminência de eclâmpsia, o que não se aplica aqui. A resolução imediata por cesariana seria indicada em casos de instabilidade materna ou fetal grave, o que também não ocorre. Com 32 semanas de IG e quadro estável, a conduta expectante permite ganho de maturidade fetal sem exposição desnecessária aos riscos da prematuridade.

(B) ✓ **CORRETA** - Esta é a conduta adequada para PE sem sinais de gravidade em gestação de 32 semanas. A internação permite vigilância rigorosa dos parâmetros maternos e fetais, identificação precoce de sinais de deterioração e intervenção oportuna se necessário. A corticoterapia para maturação pulmonar fetal está indicada entre 24-34 semanas, preparando o feto para eventual necessidade de antecipação do parto. A conduta expectante nessa faixa de IG visa ganhar tempo de maturação fetal, uma vez que os riscos da prematuridade extrema superam os riscos de manter a gestação sob vigilância quando não há sinais de gravidade.

(C) **X INCORRETA** - O acompanhamento ambulatorial com retorno em 48 horas é inadequado para uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia, mesmo sem sinais de gravidade. A PE é uma condição dinâmica que pode evoluir rapidamente para formas graves, incluindo eclâmpsia, síndrome HELLP e descolamento prematuro de placenta. A internação hospitalar é mandatória para monitoramento contínuo, avaliação laboratorial seriada e vigilância fetal. Além disso, a dose de metildopa proposta (750 mg/dia) está abaixo da dose habitualmente utilizada, e o tratamento anti-hipertensivo isolado não constitui o manejo adequado da PE.

(D) **X INCORRETA** - O sulfato de magnésio profilático não está indicado na PE sem sinais de gravidade. Sua indicação é na PE grave (para prevenção de eclâmpsia) ou durante o trabalho de parto em pacientes com PE. Além disso, programar a resolução para 34 semanas de forma fixa não considera a possibilidade de conduta expectante até 37 semanas na PE sem gravidade, quando as condições materno-fetais permitem. A decisão de interromper deve ser individualizada, baseada na evolução clínica e laboratorial, não em uma data pré-determinada arbitrariamente.

RESUMO (TLDR)

Pré-eclâmpsia: O Que Realmente Importa?

A PE é definida por hipertensão após 20 semanas + proteinúria ou disfunção de órgãos-alvo.

1. Diagnóstico de Proteinúria

- Padrão-ouro: ≥ 300 mg/24h
- Alternativa rápida: Relação P/C $\geq 0,3$

2. Sinais de Gravidade

- PA $\geq 160/110$ mmHg
- Plaquetas < 100.000
- Creatinina $> 1,1$ mg/dL
- Transaminases $> 2x$ o normal
- Sintomas neurológicos REFRATÁRIOS

3. Conduta por IG (PE sem gravidade)

- < 37 sem: Internação + vigilância + corticoide se 24-34 sem
- ≥ 37 sem: Resolução da gestação

4. Pérola

Sulfato de magnésio é para PE GRAVE ou trabalho de parto, não para toda PE!

QUESTÃO 71 ■ Urgência / Emergência ■ Sepses ■ Gabarito: B

Lactente de 8 meses é trazido à Unidade de Pronto Atendimento pela mãe, que relata febre alta há 18 horas, recusa alimentar e irritabilidade. A criança nasceu a termo, sem intercorrências, com vacinação em dia. Ao exame físico: temperatura axilar de $39,2^{\circ}\text{C}$; frequência cardíaca de 178 bpm; frequência respiratória de 52 irpm; tempo de enchimento capilar de 4 segundos; pele com livedo reticular em membros inferiores; fontanela anterior normotensa; oroscopia com hiperemia de orofaringe sem exsudato; otoscopia com membrana timpânica direita abaulada e hiperemiada; ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações; abdome flácido, sem visceromegalias. Diurese referida como presente nas últimas horas, porém em menor quantidade que o habitual. Considerando as ferramentas de reconhecimento precoce de sepsis em pediatria, qual achado clínico deste paciente representa o sinal de alerta mais específico para deterioração hemodinâmica?

- (A) Febre acima de 39°C com duração superior a 12 horas.
- (B) ✓ **Tempo de enchimento capilar prolongado com livedo.**
- (C) Taquicardia com frequência cardíaca acima de 160 bpm.
- (D) Taquipneia com frequência respiratória acima de 50 irpm.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A febre é um critério de SIRS e indica resposta inflamatória sistêmica, mas é extremamente inespecífica em pediatria. Uma criança com otite média aguda não complicada pode apresentar febre alta de $39-40^{\circ}\text{C}$ sem nenhum comprometimento hemodinâmico. A duração da febre também não é um marcador confiável de gravidade. O que diferencia a infecção localizada da sepsis são os sinais de disfunção orgânica, não a magnitude ou duração da febre.

(B) ✓ **CORRETA.** O tempo de enchimento capilar prolongado (>3 segundos) associado ao livedo reticular são os sinais mais específicos de hipoperfusão tecidual e deterioração hemodinâmica neste caso. Enquanto taquicardia e taquipneia podem ocorrer apenas pela febre, o TEC prolongado indica que a criança está utilizando mecanismos compensatórios (vasoconstrição periférica) para manter a pressão arterial. O livedo reticular confirma essa redistribuição do fluxo sanguíneo. Esses achados indicam que o paciente está evoluindo para choque séptico compensado e necessita de intervenção imediata.

(C) ✗ **INCORRETA.** A taquicardia é um achado comum em lactentes febris e pode ocorrer por diversos motivos: febre (a FC aumenta cerca de 10 bpm para cada 1°C de elevação térmica), dor, agitação, choro ou desidratação. Embora a taquicardia faça parte dos critérios de SIRS e deva ser monitorizada, ela isoladamente não é específica para deterioração hemodinâmica. Uma criança com OMA simples e febre de 39°C frequentemente apresentará FC >160 bpm sem nenhum comprometimento sistêmico.

(D) ✗ **INCORRETA.** A taquipneia, assim como a taquicardia, é um achado inespecífico que pode ocorrer em resposta à febre, acidose metabólica, ansiedade ou patologia pulmonar primária. Em um lactente febril, a FR elevada pode representar apenas a resposta fisiológica ao aumento do metabolismo. A taquipneia se torna mais preocupante quando associada a sinais de esforço respiratório (tiragens, batimento de asa nasal) ou quando há outros sinais de hipoperfusão. Neste caso, a ausculta pulmonar está normal, diminuindo a relevância da taquipneia isolada.

RESUMO (TLDR)

Reconhecimento Precoce de Sepses Pediátrica: O Que Realmente Importa?

Em crianças, a hipotensão é sinal TARDIO de choque. O reconhecimento precoce depende dos sinais de perfusão tecidual.

1. Sinais Inespecíficos (SIRS)

- Taquicardia, taquipneia, febre → podem ocorrer em qualquer infecção

2. Sinais Específicos de Hipoperfusão

- TEC >3 segundos
- Livedo reticular
- Extremidades frias
- Oligúria
- Alteração de consciência

3. Pérola

Criança febril + qualquer sinal de hipoperfusão = sepsis até que se prove o contrário. Não espere a PA cair!

QUESTÃO 72 ■ Urgência / Emergência ■ Reanimação Neonatal ■ Gabarito: D

Recém-nascido a termo, de parto vaginal, nasce hipotônico e em apnéia. O cordão umbilical é clampeado imediatamente e o neonato é levado à mesa de reanimação. Após realização dos passos iniciais em 30 segundos, o recém-nascido permanece em apnéia. É iniciada ventilação com pressão positiva por máscara facial com técnica adequada. Após 30 segundos de VPP, a frequência cardíaca aferida pelo monitor cardíaco é de 50 bpm. Qual é a próxima conduta a ser adotada?

- (A) Iniciar massagem cardíaca e manter ventilação por máscara facial.
- (B) Intubar e iniciar massagem cardíaca sincronizada à ventilação.
- (C) Administrar adrenalina endovenosa e manter ventilação por máscara.
- (D) ✓ **Checar técnica da VPP, considerar via aérea alternativa e ventilar.**

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Iniciar massagem cardíaca mantendo ventilação por máscara facial é um erro grave! A massagem cardíaca só é indicada quando a FC permanece < 60 bpm **após VPP efetiva por via aérea avançada** (cânula traqueal ou máscara laríngea). Fazer massagem com ventilação possivelmente ineficaz é inútil – você comprime um coração que não está recebendo oxigênio adequadamente. O protocolo exige que se garanta a via aérea antes de progredir.

(B) ✗ **INCORRETA.** Embora a intubação esteja parcialmente correta (garantir via aérea), a alternativa pula uma etapa crucial: **checar a técnica da VPP** (MR. SOPA) antes de intubar. Além disso, não se inicia massagem cardíaca imediatamente após a intubação – deve-se realizar mais 30 segundos de VPP efetiva pela via avançada e reavaliar a FC. Se ainda estiver < 60 bpm, aí sim inicia-se a massagem.

(C) ✗ **INCORRETA.** A adrenalina é a última medida do algoritmo de reanimação! Ela só é indicada quando a FC permanece < 60 bpm **após 60 segundos de massagem cardíaca + ventilação coordenadas** por via aérea avançada. Administrar adrenalina neste momento seria pular diversas etapas obrigatórias do protocolo (correção de técnica, via aérea avançada, massagem cardíaca).

(D) ✓ **CORRETA.** Quando a FC permanece baixa após VPP por máscara, o protocolo do PRN-SBP (base ILCOR) determina que se deve **checar a técnica** utilizando o mnemônico MR. SOPA e considerar via aérea alternativa (máscara laríngea em RN ≥34 semanas ou intubação orotraqueal). Somente após garantir ventilação efetiva por via aérea avançada e manter 30 segundos adicionais de VPP é que se reavalia a necessidade de massagem cardíaca.

RESUMO (TLDR)

Reanimação Neonatal Avançada: O Que Realmente Importa?

A bradicardia neonatal é quase sempre por **falta de oxigênio**, não problema cardíaco primário.

1. Quando a FC não sobe após VPP por máscara

- **CHECAR TÉCNICA** (MR. SOPA)
- Considerar **via aérea alternativa** (máscara laríngea ou IOT)

2. Massagem Cardíaca: Quando?

- FC < 60 bpm **APÓS** VPP efetiva por via aérea avançada
- Nunca antes de garantir ventilação adequada!

3. Pérola da Questão

Se a questão diz que a VPP foi feita por **máscara facial** e a FC continua baixa, a resposta quase sempre é **checar técnica e/ou garantir via aérea avançada** – não é hora de massagem nem adrenalina!

QUESTÃO 73 ■ Urgência / Emergência ■ Diabetes ■ Gabarito: A

Menino de 6 anos, previamente hígido, é trazido ao pronto-socorro com queixa de náuseas, vômitos e dor abdominal há 8 horas. A mãe refere que há 3 semanas o filho apresenta poliúria, polidipsia e emagrecimento de 3 kg. Ao exame físico: sonolento, desidratado 3+/4+, taquipneico com respiração profunda, hálito cetônico, FC 130 bpm, PA 90x60 mmHg. Exames laboratoriais: glicemia capilar 380 mg/dL; gasometria venosa com pH 7,18, bicarbonato 12 mEq/L, pCO₂ 28 mmHg; potássio sérico 4,8 mEq/L; cetonúria 3+. Iniciada hidratação com soro fisiológico 0,9% (20 mL/kg em 30 minutos). Após a primeira hora de tratamento, qual é a próxima conduta mais adequada?

- (A) ✓ **Iniciar insulina regular + reposição de potássio intravenosa em infusão contínua.**
- (B) Administrar bicarbonato de sódio intravenoso.
- (C) Realizar bolus de insulina regular intravenosa.
- (D) Aguardar normalização da glicemia para iniciar insulina.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Após a primeira hora de hidratação, o próximo passo é iniciar **insulina regular intravenosa em infusão contínua** na dose de 0,05-0,1 UI/kg/hora. O potássio sérico do paciente (4,8 mEq/L) está adequado para iniciar a insulino terapia (não há contraindicação se K⁺ > 3,3 mEq/L). A insulina em infusão contínua permite controle fino da glicemia e evita quedas abruptas da osmolaridade, reduzindo o risco de edema cerebral. Este é o protocolo recomendado pelas diretrizes ISPAD 2022 e SBP.

(B) ✗ **INCORRETA.** O bicarbonato de sódio **NÃO está indicado** neste caso. Suas indicações são excepcionais: pH < 6,9 com comprometimento cardiovascular ou hipercalcemia grave com risco de vida. O pH do paciente é 7,18, muito acima do limiar para considerar bicarbonato. O uso inadequado de bicarbonato aumenta o risco de edema cerebral (por acidose paradoxal do SNC) e de hipocalcemia (por shift de potássio para o intracelular).

(C) ✗ **INCORRETA.** O **bolus de insulina é PROIBIDO** na CAD pediátrica! Esta é uma das regras mais importantes do manejo. O bolus causa queda abrupta da glicemia e da osmolaridade sérica, criando um gradiente osmótico que puxa água para dentro dos neurônios e precipita **edema cerebral** – a principal causa de óbito na CAD em crianças. A insulina deve ser administrada exclusivamente em infusão contínua.

(D) ✗ **INCORRETA.** Não se deve aguardar a normalização da glicemia para iniciar insulina. O objetivo da insulino terapia na CAD não é apenas reduzir a glicemia, mas principalmente **bloquear a cetogênese e corrigir a acidose**. A insulina deve ser iniciada após a primeira hora de hidratação, independentemente do nível glicêmico (desde que K⁺ > 3,3 mEq/L). Quando a glicemia cair para 250-300 mg/dL, adiciona-se glicose à solução para manter a insulina e continuar corrigindo a acidose.

RESUMO (TLDR)

Cetoacidose Diabética Pediátrica: O Essencial

Emergência endocrinológica mais comum em pediatria, frequentemente marca a estreia do DM1.

1. Diagnóstico

- Glicemia > 200 + pH < 7,3 (ou $\text{HCO}_3^- < 18$) + cetonemia/cetonúria

2. Tratamento: A Ordem Importa!

- **1ª hora:** APENAS hidratação (SF 0,9% 10-20 mL/kg)
- **Após 1ª hora:** Insulina regular IV contínua (0,05-0,1 UI/kg/h) + **reposição de potássio** (se $\text{K}^+ < 5,5$ mEq/L e diurese presente)
 - ■ Se $\text{K}^+ < 3,5$: repor potássio ANTES de iniciar insulina
 - ■ NUNCA bolus de insulina
 - ■ Bicarbonato quase nunca (só se pH < 6,9)

3. Pérola Final

O potássio sérico pode estar normal ou alto na admissão, mas o corpo está DEPLETADO. Reponha assim que iniciar insulina (se $\text{K}^+ < 5,5$ mEq/L).

QUESTÃO 74 ■ Urgência / Emergência ■ Doenças da Tireoide ■ Gabarito: A

Mulher de 38 anos, previamente hígida, é admitida na emergência com quadro de agitação psicomotora, febre de 39,8°C, taquicardia (FC 148 bpm), tremores e vômitos há 2 dias. Familiar refere que a paciente apresentava "caroço no pescoço" há meses e perdeu 8 kg nos últimos 3 meses. Ao exame: exoftalmia bilateral, bócio difuso com sopro tireoidiano e mixedema pré-tibial. Escala de Burch-Wartofsky: 55 pontos. Considerando a necessidade de controlar rapidamente a síntese e a liberação hormonal, qual a sequência terapêutica mais adequada para essa paciente?

- (A) ✓ **Propiltiouracil em dose de ataque, seguido de solução de Lugol após 1 hora, associado a propranolol e hidrocortisona.**
- (B) Solução de Lugol imediatamente, seguida de metimazol após 1 hora, associado a atenolol e dexametasona.
- (C) Metimazol em dose de ataque, associado a iodo radioativo após estabilização clínica e propranolol.
- (D) Carbimazol isolado em altas doses, seguido de tireoidectomia de urgência e reposição de corticoide.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Esta é a sequência terapêutica preconizada pelas diretrizes da American Thyroid Association (ATA 2016). O **Propiltiouracil (PTU)** é administrado primeiro em dose de ataque (600-1000 mg) para bloquear a síntese de novos hormônios. A **solução de Lugol** (iodo inorgânico) é administrada **após pelo menos 1 hora** para aproveitar o efeito Wolff-Chaikoff e bloquear a liberação de hormônios pré-formados - se administrado antes da tionamida, o iodo serviria de substrato para produção hormonal (efeito Jod-Basedow). O **propranolol** é o betabloqueador de escolha por também inibir a conversão periférica de $\text{T}_4 \rightarrow \text{T}_3$. A **hidrocortisona** (100 mg IV 8/8h) bloqueia a conversão periférica e trata a insuficiência adrenal relativa que pode acompanhar a crise.

(B) ✗ **INCORRETA.** O erro fatal desta alternativa está na **sequência invertida**: administrar Lugol ANTES da tionamida desencadeia o **efeito Jod-Basedow**, no qual o iodo serve como substrato para síntese de mais hormônio tireoidiano, agravando catastroficamente a crise. A ordem correta é SEMPRE tionamida primeiro, iodo depois (mínimo 1 hora de intervalo). O atenolol, embora seja um betabloqueador, não possui o efeito adicional de inibir a conversão periférica de $\text{T}_4 \rightarrow \text{T}_3$ que o propranolol oferece em doses elevadas.

(C) ✗ **INCORRETA.** O **iodo radioativo está absolutamente contraindicado** na crise tireotóxica! A radioiodoterapia causa destruição dos folículos tireoidianos com liberação maciça dos hormônios armazenados na circulação, o que agravaria fatalmente o quadro. O iodo radioativo só pode ser considerado como tratamento definitivo do hipertireoidismo APÓS estabilização completa do paciente e restauração do eutireoidismo com medicamentos. Além disso, o metimazol, embora eficaz, é menos preferido que o PTU na crise por não inibir a conversão periférica de $\text{T}_4 \rightarrow \text{T}_3$.

(D) ✗ **INCORRETA.** A **tireoidectomia de urgência é proibida** em pacientes em crise tireotóxica. O risco de arritmias graves, instabilidade hemodinâmica e mortalidade intraoperatória é proibitivo. A cirurgia só pode ser realizada APÓS tornar o paciente eutireoideo com tratamento clínico por semanas. O carbimazol (pró-droga do metimazol) isolado, sem as outras medidas (iodo, betabloqueador), é insuficiente para controlar a crise. A abordagem cirúrgica é reservada para casos refratários ao tratamento clínico ou quando há contraindicação às tionamidas.

RESUMO (TLDR)

Crise Tireotóxica: O Que Realmente Importa?

Emergência endócrina com mortalidade de 10-30%. O diagnóstico é clínico (Burch-Wartofsky ≥ 45).

1. Sequência Obrigatória

- 1º **PTU** (bloqueia síntese + conversão)
- 2º **Lugol** (≥ 1 h após PTU - bloqueia liberação)
- 3º **Propranolol** (bloqueia efeitos adrenérgicos)
- 4º **Hidrocortisona** (bloqueia conversão + trata insuficiência adrenal)

2. Contraindicações Absolutas

- Iodo radioativo (libera hormônio)
- Cirurgia na fase aguda (risco de arritmia fatal)
- Iodo ANTES de tionamida (efeito Jod-Basedow)

3. Pérola

A ordem é tudo: PTU $\rightarrow$ (1h) $\rightarrow$ Lugol. Inverter = catástrofe!

QUESTÃO 75 ■ Urgência / Emergência ■ Intoxicações Agudas ■ Gabarito: C

Homem de 28 anos é trazido pelo SAMU à emergência após ser encontrado desacordado em via pública. Acompanhante refere que o paciente é usuário crônico de múltiplas drogas e que, nas últimas horas, fez uso de cocaína e heroína simultaneamente ("speedball"). Ao exame inicial: Glasgow 7, pupilas anisocóricas (direita midriática, esquerda miótica), PA 185x115 mmHg, FC 52 bpm, FR 6 irpm, Tax 39,4°C, SatO₂ 76% em ar ambiente, rigidez muscular e sudorese profusa. Após intubação orotraqueal e estabilização ventilatória, qual a análise mais adequada sobre o manejo farmacológico?

- (A) Naloxona em dose plena (2 mg IV) deve ser administrada imediatamente, pois reverterá a depressão respiratória e também a hipertermia.
- (B) Betabloqueadores simples são a primeira escolha para controle da hipertensão, antagonizando diretamente os efeitos adrenérgicos da cocaína.
- (C) ✓ **Naloxona titulada está indicada para depressão respiratória; benzodiazepínicos são preferidos para hipertermia e manifestações simpatomiméticas.**
- (D) Flumazenil associado à naloxona garante reversão completa da depressão do SNC neste paciente poliusuário de substâncias.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A naloxona em dose plena (2 mg IV) em usuários crônicos de opioides pode precipitar síndrome de abstinência aguda grave, com agitação intensa, vômitos e instabilidade hemodinâmica. As Diretrizes AHA 2023 recomendam iniciar com doses baixas (0,04-0,4 mg IV) e titular conforme resposta, objetivando restaurar a ventilação adequada (FR > 12 irpm), não o despertar completo. Além disso, a naloxona **não** reverte a hipertermia — este é um efeito da cocaína, não do opioide, e requer benzodiazepínicos e resfriamento ativo.

(B) ✗ **INCORRETA.** Os betabloqueadores simples (propranolol, metoprolol, atenolol) são **contraindicados** na intoxicação por cocaína! A cocaína estimula receptores α (vasoconstrição) e β (vasodilatação compensatória). Ao bloquear apenas receptores β , permite-se estimulação α sem oposição, resultando em vasoconstrição paradoxal, piora da hipertensão e risco de espasmo coronariano. Os benzodiazepínicos são a primeira linha para controle pressórico neste contexto.

(C) ✓ **CORRETA.** Esta alternativa reflete as recomendações atuais das Diretrizes AHA 2023. A naloxona deve ser administrada de forma titulada (0,04-0,4 mg IV) para reverter a depressão respiratória do componente opioide, evitando precipitar abstinência aguda em usuários crônicos. Já os benzodiazepínicos são a primeira linha para as manifestações simpatomiméticas da cocaína (hipertensão, hipertermia, agitação), pois reduzem a descarga simpática central de forma segura, sem risco de vasoconstrição paradoxal.

(D) ✗ **INCORRETA.** O flumazenil é antagonista de benzodiazepínicos, **não** de opioides. Portanto, não tem papel na reversão da depressão do SNC causada por heroína. Além disso, seu uso em pacientes poliusuários é perigoso: pode precipitar convulsões intratáveis, especialmente quando há coingestão de substâncias pró-convulsivantes como a cocaína. O flumazenil não faz parte do "coquetel de coma" rotineiro e está contraindicado neste cenário.

RESUMO (TLDR)

Speedball: O Que Realmente Importa?

Intoxicação por cocaína + heroína cria uma toxíndrome mista confusa.

1. Prioridade: ABCDE

- Via aérea protegida primeiro
- Ventilação antes de antídotos

2. Tratamento do Componente Opioide

- Naloxona **titulada** (0,04-0,4 mg IV)
- Objetivo: restaurar ventilação, NÃO despertar

3. Tratamento do Componente Cocaínico

- Benzodiazepínicos = primeira linha
- Controla PA, temperatura, agitação e convulsões
- Betabloqueadores simples = contraindicados!

4. Pérola

Anisocoria em intoxicado exige TC crânio após estabilização — pode ser AVC hemorrágico pela cocaína!

QUESTÃO 76 ■ Urgência / Emergência ■ Trauma e Emergência ■ Gabarito: C

Homem de 32 anos, vítima de colisão frontal de automóvel contra poste, sem uso de cinto de segurança, é trazido pelo SAMU ao pronto-socorro. Na avaliação primária, apresenta-se consciente, orientado, com frequência respiratória de 32 irpm, saturação de oxigênio de 82% em ar ambiente, frequência cardíaca de 118 bpm e pressão arterial de 88 x 52 mmHg. Ao exame físico, observa-se escoriações em hemitórax esquerdo, murmúrio vesicular abolido à esquerda com macicez à percussão, e turgência jugular bilateral. Realizada drenagem pleural fechada em selo d'água no 5º espaço intercostal esquerdo, com saída imediata de 1.700 mL de sangue. Após a drenagem e reposição volêmica com 2 litros de cristalóide aquecido, o paciente mantém PA 82 x 50 mmHg, FC 124 bpm, com extremidades frias e tempo de enchimento capilar de 5 segundos. A radiografia de tórax pós-drenagem é mostrada a seguir. Considerando a evolução clínica e os achados apresentados, qual é a conduta mais apropriada para este paciente?

- (A) Solicitar tomografia computadorizada de tórax para melhor avaliação das lesões.
- (B) Manter observação clínica rigorosa e monitorar débito do dreno nas próximas horas.
- (C) ✓ **Indicar toracotomia exploradora de urgência pelo volume de sangue drenado.**
- (D) Realizar arteriografia para identificar e embolizar o vaso sangrante.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Solicitar tomografia computadorizada em um paciente hemodinamicamente instável com hemotórax maciço é um erro grave. O paciente apresenta sinais de choque hemorrágico classe III-IV (hipotensão refratária à reposição volêmica, taquicardia, má perfusão periférica) e hemotórax maciço (≥ 1.500 mL). O tempo gasto no deslocamento e realização do exame pode ser fatal. A TC é indicada para pacientes **estáveis** nos quais se deseja avaliar lesões adicionais. Quando há indicação cirúrgica clara (drenagem ≥ 1.500 mL + instabilidade hemodinâmica persistente), a prioridade é o controle da hemorragia na sala de cirurgia.

(B) **X INCORRETA.** Manter observação clínica seria apropriado para um paciente **estável** com drenagem inicial menor (por exemplo, < 1.000 mL). No entanto, este paciente apresenta dois critérios absolutos para intervenção cirúrgica imediata: (1) drenagem inicial de 1.700 mL (≥ 1.500 mL) e (2) instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica (PAS 82 mmHg, FC 124 bpm, má perfusão periférica). Aguardar evolução do débito significa permitir que o paciente continue sangrando ativamente, aumentando drasticamente o risco de óbito por exsanguinação.

(C) ✓ **CORRETA.** A toracotomia exploradora de urgência está inequivocamente indicada neste caso. O paciente preenche **dois critérios clássicos** do ATLS (11ª edição): (1) drenagem inicial ≥ 1.500 mL de sangue e (2) instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica. A macicez à percussão com abolição do murmúrio vesicular à esquerda confirmava a presença de coleção líquida intratorácica (hemotórax), e a turgência jugular decorria da compressão mediastinal pelo grande volume de sangue. Após drenagem de 1.700 mL e manutenção do choque, a toracotomia é mandatória para controle cirúrgico direto do sangramento ativo. Outros critérios para toracotomia incluem: débito > 200 mL/h por 2-4 horas consecutivas ou necessidade de hemotransfusão contínua.

(D) **X INCORRETA.** A arteriografia com embolização é uma alternativa minimamente invasiva que pode ser considerada em cenários **muito específicos**: paciente estável, sangramento de menor volume e suspeita de lesão de artéria intercostal ou mamária interna. No entanto, em um paciente com choque hemorrágico grave e hemotórax maciço refratário à reposição volêmica, o tempo necessário para mobilizar a equipe de radiologia intervencionista é incompatível com a gravidade da situação. A toracotomia oferece controle direto e imediato do sangramento.

RESUMO (TLDR)

Hemotórax Maciço: O Que Realmente Importa?

Paciente com trauma torácico, hemotórax e instabilidade hemodinâmica = decisão rápida pode salvar a vida.

1. Definição de Hemotórax Maciço

- Drenagem inicial ≥ 1.500 mL de sangue
- OU débito >200 mL/h por 2-4 horas

2. Indicações Absolutas de Toracotomia

- Hemotórax maciço
- Instabilidade hemodinâmica persistente
- Sangramento contínuo refratário

3. Pérola

Não existe "estabilizar antes de operar" em hemotórax maciço – a estabilização só acontece quando você fecha a torneira do sangramento!

QUESTÃO 77 ■ Urgência / Emergência ■ Trauma Ortopédico ■ Gabarito: A

Homem de 32 anos, vítima de acidente motociclístico há 2 horas, é admitido no pronto-socorro. Apresenta fratura fechada de fêmur direito com grande edema de coxa. Durante a avaliação inicial, o paciente refere dor intensa e desproporcional ao estímulo, com piora à extensão passiva dos dedos do pé direito. A perna encontra-se tensa à palpação, com enchimento capilar de 4 segundos. Os pulsos pedioso e tibial posterior estão presentes, porém diminuídos em comparação ao membro contralateral. Considerando a evolução clínica e os achados do exame físico, qual é a melhor conduta para este paciente?

- (A) ✓ **Realizar fasciotomia de urgência.**
- (B) Solicitar arteriografia para avaliar lesão vascular.
- (C) Iniciar anticoagulação plena por suspeita de TVP.
- (D) Manter elevação do membro e reavaliar em 6 horas.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** O quadro clínico é absolutamente clássico de **síndrome compartimental aguda**: dor desproporcional, dor à extensão passiva dos dedos (teste do compartimento posterior profundo/anterior da coxa), compartimento tenso à palpação e enchimento capilar prolongado. Note que os pulsos estão presentes - isso é esperado nas fases iniciais da SCA, pois a pressão compartimental compromete a microcirculação antes de ocluir as artérias maiores. A **fasciotomia de urgência** é mandatória e não pode ser postergada. Cada hora de atraso aumenta exponencialmente o risco de necrose muscular irreversível, contratura de Volkmann e até amputação.

(B) ✗ **INCORRETA.** A arteriografia seria indicada se houvesse suspeita de **lesão arterial traumática**, como ausência de pulso desde o momento do trauma, hematoma pulsátil ou sangramento ativo. No caso apresentado, os pulsos estão presentes (embora diminuídos), e o quadro clínico é típico de síndrome compartimental - não de lesão vascular. Solicitar arteriografia atrasaria o tratamento definitivo e resultaria em dano irreversível ao membro.

(C) ✗ **INCORRETA.** A trombose venosa profunda (TVP) pode causar edema e dor no membro, mas o quadro clínico é diferente: edema difuso de todo o membro, empastamento de panturrilha, sinal de Homans positivo, mas **sem dor à extensão passiva** e sem tensão compartimental. Além disso, TVP em contexto de trauma recente com fratura torna a anticoagulação plena perigosa pelo risco de sangramento. O diagnóstico aqui é síndrome compartimental, não TVP.

(D) ✗ **INCORRETA.** Esta é a alternativa mais perigosa. A síndrome compartimental é uma emergência cirúrgica onde **tempo é músculo**. Aguardar 6 horas com elevação do membro (que, aliás, é contraindicada na SCA pois reduz ainda mais a pressão de perfusão) resultaria em necrose muscular extensa e irreversível. A janela para fasciotomia eficaz é de poucas horas - atrasos de 6-8 horas frequentemente resultam em amputação ou déficits funcionais permanentes.

RESUMO (TLDR)

Síndrome Compartimental Aguda: O Que Realmente Importa?

Emergência ortopédica onde a pressão dentro do compartimento fascial compromete a perfusão muscular.

1. Diagnóstico Clínico

- **Dor desproporcional** à lesão
- **Dor à extensão passiva** (sinal mais sensível!)
- **Tensão** no compartimento
- Pulso presente **NÃO exclui**

2. Tratamento

- **Fasciotomia de urgência** - única conduta
- Tempo é músculo - cada hora conta

3. Pérola de Prova

Se tem dor desproporcional + dor à extensão passiva + tensão = SCA → fasciotomia imediata. Não espere ausência de pulso!

QUESTÃO 78 ■ Urgência / Emergência ■ Emergências Urológicas ■ Gabarito: C

Homem de 32 anos, vítima de acidente motociclístico há 2 horas, é admitido no pronto-socorro de hospital terciário. Refere dor em flanco esquerdo e hematúria macroscópica. Ao exame físico, apresenta-se consciente, orientado, com frequência cardíaca de 88 bpm, pressão arterial de 118 x 72 mmHg e escoriações em região lombar esquerda. Tomografia computadorizada de abdome com contraste evidencia laceração renal esquerda de 1,5 cm de profundidade, sem acometimento do sistema coletor, com hematoma perirrenal contido. Não há extravasamento de contraste na fase arterial nem na fase excretora. Diante desse quadro, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Indicar nefrectomia parcial de urgência.
- (B) Realizar angioembolização seletiva imediata.
- (C) ✓ **Manter observação clínica e hematócrito seriado.**
- (D) Proceder com exploração cirúrgica do retroperitônio.

COMENTÁRIOS

(A) **✗ INCORRETA.** A nefrectomia parcial de urgência é um procedimento cirúrgico reservado para situações muito específicas, como tumores renais ou lesões traumáticas com indicação cirúrgica absoluta. No caso apresentado, o paciente está hemodinamicamente estável, com lesão grau III (laceração > 1 cm sem acometimento do sistema coletor) e sem evidência de sangramento ativo na TC. A abordagem cirúrgica inicial aumentaria a morbidade sem benefício clínico comprovado.

(B) **✗ INCORRETA.** A angioembolização seletiva é uma excelente ferramenta no manejo do trauma renal, porém tem indicações precisas: presença de **sangramento ativo (blush arterial)** na tomografia, pseudoaneurisma ou fístula arteriovenosa. No caso apresentado, a TC não evidenciou extravasamento de contraste na fase arterial, ou seja, não há sangramento ativo que justifique esse procedimento. Realizar angioembolização sem indicação adequada expõe o paciente a riscos desnecessários.

(C) ✓ **CORRETA.** Este é o caso clássico de trauma renal com indicação de tratamento conservador. Temos um paciente **hemodinamicamente estável** (FC 88 bpm, PA 118x72 mmHg), com lesão classificada como **grau III** pela AAST (laceração > 1 cm sem acometimento do sistema coletor), hematoma perirrenal **contido** e **sem sangramento ativo** (ausência de blush na fase arterial). A conduta padrão é observação clínica com repouso, monitorização de sinais vitais e hematócrito seriado para detectar precocemente eventual sangramento tardio.

(D) **✗ INCORRETA.** A exploração cirúrgica do retroperitônio no trauma renal está indicada em situações específicas: instabilidade hemodinâmica persistente apesar da ressuscitação, lesões grau V com avulsão vascular, hematoma pulsátil ou em expansão, ou necessidade de exploração abdominal por outras lesões. O paciente do caso está estável, com lesão contida e sem sinais de complicação que justifiquem abordagem cirúrgica. A exploração desnecessária aumenta risco de nefrectomia e complicações.

RESUMO (TLDR)

Trauma Renal: O Que Realmente Importa?

O manejo do trauma renal é guiado por **estabilidade hemodinâmica** e **achados tomográficos**.

1. Classificação AAST

- Grau I-II: Lesões menores (hematoma, laceração < 1 cm)
- **Grau III: Laceração > 1 cm SEM sistema coletor**
- Grau IV: Atinge sistema coletor ou lesão vascular
- Grau V: Rim estilhaçado ou avulsão vascular

2. Conduta por Cenário

- **Estável + Sem blush** → Observação
- **Estável + Blush arterial** → Angioembolização
- **Instável refratário** → Cirurgia

3. Pérola

A maioria dos traumas renais (80-90%) é tratada conservadoramente. Cirurgia é exceção, não regra!

VII. Saúde Mental / Psiquiatria

QUESTÃO 79 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Emergências Psiquiátricas ■ Gabarito: B

Mulher de 28 anos é atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) após solicitação de consulta pela enfermeira da equipe de Saúde da Família. A paciente compareceu para renovar receita de escitalopram 10 mg/dia, em uso há 4 meses por diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Durante a consulta, refere tristeza persistente, desesperança e pensamentos de que "seria melhor se não existisse". Nega plano estruturado, mas admite que há 2 semanas pesquisou na internet sobre métodos de suicídio. Relata término de relacionamento há 1 mês, dificuldades financeiras e distanciamento da família, que reside em outro estado. Mora sozinha em apartamento no 8º andar. Nega uso de álcool ou drogas ilícitas. Nega tentativas prévias de suicídio. Ao exame, encontra-se vígil, orientada, com discurso coerente, afeto constrito e humor deprimido. Diante do quadro clínico apresentado, qual o fator que mais contribui para classificar essa paciente como de alto risco de suicídio?

- (A) Presença de transtorno psiquiátrico prévio em tratamento farmacológico.
- (B) ✓ **Pesquisa ativa sobre métodos associada à ausência de rede de apoio social.**
- (C) Término de relacionamento afetivo recente como fator precipitante.
- (D) Tristeza persistente e desesperança há mais de duas semanas.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** A presença de transtorno psiquiátrico prévio (ansiedade generalizada) é, sim, um fator de risco para suicídio, especialmente quando há comorbidade depressiva. No entanto, o fato de a paciente estar em tratamento farmacológico há 4 meses indica que esse fator já está sendo abordado. Isoladamente, não é o elemento que mais contribui para classificá-la como alto risco nesse momento. O transtorno de base é o "pano de fundo", mas não o determinante principal da gravidade atual.

(B) ✓ **CORRETA.** A pesquisa ativa sobre métodos de suicídio na internet representa um passo além da ideação passiva: indica que a paciente está buscando informações para concretizar o ato, caracterizando planejamento inicial. Quando associada à ausência de rede de apoio (mora sozinha, família em outro estado), configura o cenário de maior risco. Não há quem a monitore 24 horas, não há quem intervenha em momento de crise, e ela tem acesso a método letal (morar no 8º andar). Essa combinação é o que mais eleva o risco nesse caso.

(C) ✗ **INCORRETA.** O término de relacionamento recente é um **fator precipitante** ou **gatilho**, não um determinante principal do risco de suicídio. Eventos estressores de vida são comuns em pacientes com comportamento suicida, mas não estratificam isoladamente a gravidade. Muitas pessoas passam por terminos sem desenvolver ideação suicida. O que transforma o gatilho em risco é a combinação com vulnerabilidades pré-existentes (transtorno mental, isolamento, acesso a meios).

(D) ✗ **INCORRETA.** Tristeza persistente e desesperança são sintomas nucleares de um episódio depressivo e, de fato, a desesperança é um dos preditores mais consistentes de comportamento suicida. Contudo, a questão pede o fator que **mais contribui** para o alto risco. Sintomas depressivos são condição de base, mas a progressão para pesquisa de métodos e a ausência de suporte social são os elementos que transformam a ideação em risco iminente de ação.

RESUMO (TLDR)

Risco de Suicídio: O Que Realmente Importa?

Na avaliação do risco de suicídio, não basta identificar a ideação - é preciso avaliar o **tripé: ideação + planejamento + intenção**.

1. O que eleva o risco imediato?

- Pesquisa ou escolha de método
- Acesso facilitado a meios letais
- Ausência de rede de apoio social
- Tentativa prévia (maior preditor isolado)

2. O que é fator precipitante (não determinante)?

- Eventos estressores (término, perda de emprego)
- Conflitos interpessoais

3. Conduta prática

- Restringir acesso a meios
- Desenvolver Plano de Segurança
- Não deixar sozinho se risco alto
- Encaminhar para CAPS/emergência psiquiátrica

QUESTÃO 80 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Transtornos do Humor ■ Gabarito: A

Gestante de 28 anos, primigesta, com 32 semanas de idade gestacional, comparece à consulta de pré-natal na maternidade de referência. Relata que nas últimas três semanas tem se sentido constantemente triste, sem vontade de realizar atividades que antes lhe davam prazer, com dificuldade para dormir mesmo quando o bebê não a incomoda, e que perdeu o apetite, tendo emagrecido 2 kg no período. Refere ainda dificuldade de concentração no trabalho e sensação de cansaço extremo, mesmo sem esforço físico. Nega pensamentos de morte ou de fazer mal a si mesma. Ao ser questionada, menciona preocupação excessiva com a saúde do bebê, mas nega sintomas psicóticos. Exame físico obstétrico sem alterações, feto com batimentos cardíacos presentes e movimentação ativa. Considerando o quadro clínico apresentado e as particularidades do manejo no período gestacional, qual é a conduta mais adequada?

- (A) ✓ **Iniciar psicoterapia cognitivo-comportamental como primeira linha de tratamento.**
 (B) Prescrever fluoxetina 20 mg/dia e reavaliar em duas semanas.
 (C) Orientar que os sintomas são normais da gestação e reagendar retorno.
 (D) Encaminhar imediatamente para internação em unidade psiquiátrica.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** A paciente apresenta um quadro de Transtorno Depressivo Maior de gravidade leve a moderada (6 sintomas, sem ideação suicida ou psicose), no contexto de gestação. Conforme as diretrizes atuais do American College of Physicians (2023) e recomendações das sociedades de obstetrícia, a **psicoterapia cognitivo-comportamental (TCC)** é a primeira linha de tratamento para depressão leve a moderada, especialmente na gestação, onde se busca evitar exposição desnecessária a fármacos. A TCC demonstrou eficácia comparável aos antidepressivos nesses casos e não oferece risco ao feto.

(B) ✗ **INCORRETA.** Embora a fluoxetina seja um ISRS que pode ser utilizado na gestação, ela **não** é a primeira escolha para casos leves a moderados. As diretrizes atuais recomendam iniciar com psicoterapia nessas situações, reservando a farmacoterapia para casos moderados a graves, refratários ou quando a psicoterapia não está disponível. Além disso, quando a farmacoterapia é indicada na gestação, a sertralina costuma ser preferida por seu melhor perfil de segurança.

(C) ✗ **INCORRETA.** Esta é uma conduta **perigosa e inadequada**. Embora alguns sintomas como fadiga e alterações de sono sejam comuns na gestação fisiológica, a presença de anedonia persistente, tristeza diária por semanas, perda de peso significativa e dificuldade de concentração **não** são normais. Normalizar esses sintomas pode levar a agravamento do quadro, com consequências para a mãe (progressão para depressão grave, risco de depressão pós-parto) e para o bebê (prematuridade, baixo peso ao nascer, prejuízo do vínculo).

(D) ✗ **INCORRETA.** A internação psiquiátrica é um recurso **excepcional**, reservado para situações de risco iminente à vida (ideação suicida com plano, sintomas psicóticos graves, incapacidade completa de autocuidado). A paciente nega pensamentos de morte ou de fazer mal a si mesma e não apresenta sintomas psicóticos. Portanto, o acompanhamento pode ser feito em nível ambulatorial, com psicoterapia e reavaliações periódicas.

RESUMO (TLDR)**Depressão na Gestação: O Que Realmente Importa?**

A depressão perinatal afeta 10-20% das gestantes e **NÃO** deve ser normalizada.

1. Diagnóstico

- Mesmos critérios do DSM-5: ≥5 sintomas por ≥2 semanas
- Diferenciar de sintomas fisiológicos pela **persistência e intensidade**

2. Tratamento por Gravidade

- **Leve-Moderada:** TCC ou terapia interpessoal (primeira linha)
- **Moderada-Grave:** ISRS (sertralina preferida) + psicoterapia
- **Grave com risco:** Internação + farmacoterapia

3. Pérola

Não tratar a depressão também tem riscos fetais (prematuridade, baixo peso). A decisão é sempre uma balança risco-benefício!

QUESTÃO 81 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Dependência Química ■ Gabarito: C

Homem de 52 anos é trazido ao pronto-socorro pela esposa, que relata que o marido parou de beber álcool há aproximadamente 36 horas após consumo diário de uma garrafa de cachaça por mais de 15 anos. Ela refere que ele está cada vez mais agitado, suando muito e "vendo coisas que não existem". Ao exame físico: pressão arterial 162 x 98 mmHg, frequência cardíaca 118 bpm, temperatura axilar 38,2°C, sudorese profusa, tremor grosseiro de extremidades, paciente desorientado no tempo e espaço, com discurso desconexo e alucinações visuais de insetos. Exames laboratoriais iniciais mostram hipocalcemia e hipomagnesemia. Considerando o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica adequada, além das medidas de suporte clínico, o tratamento farmacológico de primeira linha para este paciente é

- (A) haloperidol intramuscular, pela rápida sedação e controle das alucinações.
- (B) fenitoína intravenosa, para profilaxia de convulsões relacionadas à abstinência.
- (C) ✓ **diazepam intravenoso, com doses repetidas conforme necessidade de sedação.**
- (D) clorpromazina intramuscular, pelo efeito sedativo e menor risco de convulsões.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O haloperidol é um antipsicótico de alta potência que pode auxiliar no controle de agitação e alucinações, porém **não deve ser usado como monoterapia** na SAA. O grande problema? Ele **reduz o limiar convulsivo**, aumentando o risco de convulsões - justamente uma das complicações que queremos evitar! Além disso, não atua na fisiopatologia central da abstinência (o desbalanço GABA/Glutamato). Pode ser usado como adjuvante após sedação adequada com benzodiazepínicos em casos de agitação refratária.

(B) **X INCORRETA.** A fenitoína é uma pegadinha clássica de prova! Apesar de ser um anticonvulsivante eficaz em outros contextos (epilepsia, pós-TCE), ela **NÃO é eficaz** na prevenção ou tratamento de convulsões por abstinência alcoólica. Isso ocorre porque o mecanismo das convulsões na SAA é diferente - resulta da hiperexcitabilidade por desbalanço GABA/Glutamato, não de focos epileptogênicos clássicos. Os benzodiazepínicos são superiores porque atuam diretamente no receptor GABA.

(C) ✓ **CORRETA.** O diazepam intravenoso é o **tratamento de primeira linha** para a Síndrome de Abstinência Alcoólica, incluindo o Delirium Tremens. Os benzodiazepínicos atuam como agonistas do receptor GABA-A, compensando a down-regulation causada pelo uso crônico de álcool. O diazepam tem meia-vida longa, o que permite um desmame mais suave e reduz o risco de rebote. Pode ser administrado em doses repetidas conforme necessidade (protocolo guiado por sintomas/CIWA-Ar) ou em esquema de dose fixa.

(D) **X INCORRETA.** A clorpromazina é um antipsicótico de baixa potência e apresenta vários problemas no contexto da SAA: (1) **reduz o limiar convulsivo**, aumentando o risco de crises; (2) causa **hipotensão significativa** por bloqueio alfa-adrenérgico, o que é perigoso em um paciente com instabilidade autonômica; (3) não trata a fisiopatologia subjacente. A afirmação de "menor risco de convulsões" está incorreta - na verdade, o risco é **MAIOR** com antipsicóticos comparados aos benzodiazepínicos.

RESUMO (TLDR)**Delirium Tremens: O Que Realmente Importa?**

O DT é a forma mais grave da SAA, com mortalidade de até 20% se não tratado.

1. Quando Suspeitar?

- Abstinência em etilista crônico há 48-96h
- Confusão + agitação + instabilidade autonômica + alucinações

2. Tratamento de Primeira Linha

- **Benzodiazepínicos** (diazepam IV) - SEMPRE!
- **Tiamina** antes da glicose - previne Wernicke
- Correção de K⁺, Mg⁺⁺, fosfato

3. Pérola de Prova

- Fenitoína **NÃO** funciona para convulsões de abstinência
- Antipsicóticos reduzem limiar convulsivo - só adjuvantes!
- Cronologia: Tremor (6h) → Alucinação (12h) → Convulsão (24h) → DT (48h)

QUESTÃO 82 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Transtornos Alimentares ■ Gabarito: A

Adolescente de 16 anos é trazida pela mãe ao pronto-socorro com queixa de tontura e fraqueza há 3 dias. A mãe relata que a filha vem perdendo peso nos últimos 8 meses, de forma intencional, pois "se achava gorda". Refere que a paciente diminuiu drasticamente a alimentação e pratica exercícios físicos por várias horas diárias. Nega vômitos provocados ou uso de laxantes. Ao exame físico: consciente, orientada, emagrecida, pele seca, lanugo em dorso. Peso: 38 kg; altura: 1,62 m (IMC: 14,5 kg/m²). Sinais vitais: PA 85 x 55 mmHg, FC 48 bpm, temperatura axilar 35,4°C. Exames laboratoriais: potássio 2,9 mEq/L, glicemia 58 mg/dL, hemoglobina 10,2 g/dL. Eletrocardiograma evidência bradicardia sinusal com intervalo QT prolongado. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta inicial adequada?

- (A) ✓ **Anorexia nervosa tipo restritivo; internação em enfermaria de clínica médica para estabilização.**
(B) Anorexia nervosa tipo purgativo; internação em enfermaria de psiquiatria para suporte nutricional.
(C) Bulimia nervosa; acompanhamento ambulatorial com fluoxetina 60 mg/dia e terapia cognitivo-comportamental.
(D) Transtorno alimentar restritivo/evitativo; encaminhamento para nutricionista e seguimento em UBS.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** O quadro clínico é clássico de **Anorexia Nervosa tipo restritivo**: adolescente com perda de peso intencional por restrição alimentar e exercício excessivo, distorção da imagem corporal ("se achava gorda"), ausência de comportamentos purgativos (nega vômitos ou laxantes), IMC extremamente baixo (14,5 kg/m²) e sinais físicos de desnutrição (lanugo, pele seca). A paciente apresenta **múltiplos critérios de instabilidade clínica**: bradicardia grave (48 bpm), hipotensão (85x55 mmHg), hipotermia (35,4°C), hipoglicemia, hipocalemia severa e QT prolongado no ECG. Esses achados indicam risco iminente de arritmia fatal e complicações metabólicas. A conduta correta é **internação em enfermaria de Clínica Médica** para estabilização hemodinâmica, correção de eletrólitos e realimentação monitorizada (com vigilância para síndrome de realimentação), antes de qualquer abordagem psiquiátrica estruturada.

(B) ✗ **INCORRETA.** Embora o diagnóstico de Anorexia Nervosa esteja correto, o **subtipo está errado** (a paciente nega comportamentos purgativos, caracterizando subtipo **restritivo**, não purgativo). Além disso, a conduta proposta é inadequada: a internação em **enfermaria de Psiquiatria** seria indicada para pacientes clinicamente **estáveis** com risco psiquiátrico (suicídio, recusa alimentar sem instabilidade). Esta paciente está **cl clinicamente instável** (bradicardia, hipotensão, hipotermia, hipocalemia grave, QT prolongado) e necessita de monitorização cardíaca e suporte clínico que a enfermaria psiquiátrica tipicamente não oferece.

(C) ✗ **INCORRETA.** A **Bulimia Nervosa** caracteriza-se por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios (vômitos, laxantes, exercício) em paciente com peso **normal ou elevado**. A paciente do caso tem IMC extremamente baixo (14,5 kg/m²), não apresenta episódios de compulsão alimentar, e sua perda de peso é por restrição contínua. Além disso, mesmo se fosse bulimia, o acompanhamento ambulatorial seria contraindicado frente à gravidade clínica apresentada (instabilidade hemodinâmica). A fluoxetina 60 mg é o tratamento farmacológico de escolha para Bulimia, não para Anorexia Nervosa.

(D) ✗ **INCORRETA.** O **Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo (TARE)** caracteriza-se por restrição alimentar que leva a déficit nutricional, porém **sem medo de ganhar peso e sem distorção da imagem corporal**. Os pacientes restringem por desinteresse pela comida, aversão sensorial (textura, cor) ou medo de consequências negativas (engasgar, vomitar). A paciente do caso tem claramente distorção de imagem ("se achava gorda") e medo de ganhar peso, critérios que definem Anorexia Nervosa e excluem TARE. Ademais, encaminhamento para nutricionista e UBS seria totalmente inadequado frente à instabilidade clínica grave.

RESUMO (TLDR)**Anorexia Nervosa na Urgência: O Que Realmente Importa?**

Paciente com AN grave chega instável → sua prioridade é **estabilização clínica**, não psicoterapia!

1. Diagnóstico

- Tríade: restrição + medo de engordar + distorção de imagem
- Restritivo (sem purgação) vs. Purgativo (com vômitos/laxantes)

2. Sinais de Alarme (= Clínica Médica!)

- FC < 50, PA < 90/60, Temp < 36°C
- K⁺ < 3,0, QT prolongado, glicemia baixa
- IMC < 15 kg/m²

3. Pérola

QT prolongado = risco de morte súbita. Interna em Clínica Médica, monitora, corrige eletrólitos, realimenta devagar!

QUESTÃO 83 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Emergências Psiquiátricas ■ Gabarito: C

Mulher de 28 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Durante a anamnese, menciona espontaneamente que nas últimas semanas tem pensado que "seria melhor se não existisse", mas nega planos concretos ou tentativas prévias. Refere término de relacionamento há 3 meses e dificuldade para dormir desde então. Trabalha como professora, mora com os pais e mantém atividades de lazer aos finais de semana. Nega uso de álcool ou drogas ilícitas. Ao exame, apresenta-se vígil, orientada, com humor entristecido, mas colaborativa e com discurso fluente. Considerando a avaliação do risco de suicídio nessa paciente, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Prescrever antidepressivo e agendar retorno em 30 dias para reavaliação.
- (B) Encaminhar para internação psiquiátrica involuntária imediata.
- (C) ✓ **Iniciar antidepressivo (ISRS), agendar acompanhamento ambulatorial frequente na própria UBS e elaborar Plano de Segurança com a paciente.**
- (D) Orientar retorno apenas se houver piora dos sintomas ou surgimento de plano suicida.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - Prescrever antidepressivo sem avaliação psiquiátrica especializada e agendar retorno apenas em 30 dias é conduta inadequada por dois motivos: primeiro, a introdução de antidepressivo em paciente com ideação suicida requer monitorização próxima nas primeiras semanas (risco de ativação e piora paradoxal); segundo, 30 dias é intervalo muito longo para paciente com qualquer nível de ideação suicida. O correto é retorno em 7-14 dias e, se houver indicação de antidepressivo, este deve ser prescrito com acompanhamento mais frequente.

(B) **X INCORRETA** - A internação psiquiátrica involuntária está reservada para pacientes com **risco iminente**: plano estruturado, acesso aos meios, intenção clara de execução e/ou ausência de suporte social que permita vigilância. A paciente do caso apresenta ideação passiva, sem plano, com excelente rede de apoio (mora com os pais, trabalha, mantém atividades sociais). Internar seria desproporcional e poderia inclusive prejudicar a aliança terapêutica.

(C) ✓ **CORRETA**. Esta é a conduta adequada para um paciente com ideação suicida **sem plano estruturado**, sem tentativa prévia e sem risco iminente de vida. O manejo envolve três pilares: (1) **Tratamento farmacológico** com antidepressivo (ISRS como primeira linha), considerando que a paciente apresenta sintomas depressivos associados à ideação suicida; (2) **Acompanhamento ambulatorial frequente** (semanal ou quinzenal) na APS, para monitoramento do risco e da resposta terapêutica; e (3) **Plano de Segurança** — um instrumento estruturado que inclui identificação de sinais de alerta, estratégias de enfrentamento, contatos de suporte e acesso a serviços de emergência. O Plano de Segurança demonstrou redução de até 43% nas tentativas de suicídio em estudos controlados.

(D) **X INCORRETA** - Orientar retorno "apenas se houver piora" é conduta negligente e potencialmente perigosa. Qualquer paciente que verbaliza ideação suicida — mesmo passiva — necessita de seguimento ativo e programado. Deixar a responsabilidade de buscar atendimento exclusivamente com o paciente ignora que pessoas em sofrimento psíquico podem ter dificuldade em perceber piora ou em buscar ajuda. O seguimento proativo é parte fundamental do manejo seguro.

RESUMO (TLDR)**Avaliação do Risco de Suicídio: O Que Realmente Importa?**

Toda ideação suicida exige avaliação, mas nem toda exige internação.

1. O Tripé da Avaliação

- **Ideação:** Passiva vs. Ativa
- **Planejamento:** Método definido? Acesso aos meios?
- **Intenção:** Determinação real de executar?

2. Fatores que Modulam o Risco

- **Risco:** Tentativa prévia, isolamento, substâncias, psicose
- **Proteção:** Família, emprego, religião, aliança terapêutica

3. Conduta por Nível de Risco

- **Baixo/Moderado:** Ambulatorial + Plano de Segurança + retorno breve
- **Alto/Iminente:** Internação (voluntária ou involuntária)

Pérola

O Plano de Segurança é ferramenta obrigatória — construa com o paciente!

QUESTÃO 84 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Transtorno Depressivo Maior ■ Gabarito: B

Mulher de 34 anos procura atendimento na Unidade Básica de Saúde queixando-se de tristeza persistente, desânimo e dificuldade para dormir há cerca de 10 semanas. Relata que, nos últimos dois meses, perdeu interesse pelas atividades que antes lhe davam prazer, tem se alimentado pouco com perda de 4 kg no período, apresenta fadiga constante e dificuldade de concentração no trabalho. Nega ideação suicida, uso de substâncias psicoativas ou episódios prévios semelhantes. Nega comorbidades clínicas. Exame físico sem alterações. Exames laboratoriais (hemograma, glicemia, TSH, função renal e hepática) dentro da normalidade. É aplicado o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), que totaliza 18 pontos. O médico da equipe de Saúde da Família elabora o plano terapêutico inicial. Considerando as diretrizes atuais para o manejo do transtorno depressivo maior na Atenção Primária, a conduta mais adequada neste momento é:

- (A) Encaminhar ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para início de psicoterapia isolada, sem farmacoterapia, reavaliando em 12 semanas.
- (B) ✓ **Iniciar inibidor seletivo da recaptação de serotonina em dose baixa, com orientação sobre latência terapêutica e reavaliação em 2 a 4 semanas.**
- (C) Prescrever amitriptilina em dose plena associada a benzodiazepínico de longa ação para controle imediato da insônia e da ansiedade.
- (D) Solicitar avaliação psiquiátrica antes de qualquer intervenção terapêutica, mantendo a paciente em observação clínica até o parecer do especialista.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** O PHQ-9 de 18 pontos classifica a depressão como **moderadamente grave**. Para essa faixa de gravidade, a diretriz ACP (2023) e as Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde recomendam que a **farmacoterapia seja iniciada** como componente essencial do tratamento — psicoterapia isolada é opção preferencial apenas para depressão **leve**. Além disso, o encaminhamento ao CAPS não é necessário neste momento, pois a paciente não apresenta risco suicida, sintomas psicóticos ou outros critérios de gravidade que justifiquem atenção especializada imediata. A condução inicial pode e deve ser feita na própria UBS.

(B) ✓ **CORRETA.** Esta é a conduta mais adequada. Diante de um quadro de TDM moderadamente grave (PHQ-9 = 18), sem ideação suicida ou sintomas psicóticos, o início de um **ISRS em dose baixa** é a primeira linha na APS. Fluoxetina e sertralina estão disponíveis na RENAME. Perceba que a alternativa contempla dois elementos fundamentais: (1) a **orientação sobre latência terapêutica** — o efeito antidepressivo demora 2 a 4 semanas, e o paciente precisa ser informado para não abandonar o tratamento precocemente — e (2) a **reavaliação em 2 a 4 semanas**, que permite monitorar adesão, efeitos adversos e risco de suicídio na fase inicial.

(C) **X INCORRETA.** Esta alternativa contém **dois erros graves**. Primeiro, a amitriptilina (um tricíclico) **não é primeira linha** para TDM na APS, por conta do perfil desfavorável de efeitos adversos (anticolinérgicos, cardiotoxicidade) e da alta letalidade em sobredose. Segundo, a prescrição de benzodiazepínico de longa ação de rotina é contraindicada: benzodiazepínicos **não são antidepressivos**, geram dependência e tolerância, e seu uso crônico pode agravar o quadro depressivo. Mesmo para controle de insônia, o uso deve ser pontual e por curto período.

(D) **X INCORRETA.** Aguardar avaliação psiquiátrica antes de iniciar qualquer tratamento é uma conduta que **atrasa desnecessariamente** o cuidado. O médico da Estratégia de Saúde da Família tem competência e respaldo para iniciar farmacoterapia com ISRS em quadros de TDM moderado a grave sem complicações (sem ideação suicida estruturada, sem psicose, sem suspeita de bipolaridade). As diretrizes brasileiras e internacionais enfatizam que o início precoce do tratamento na APS melhora desfechos e reduz o tempo de sofrimento. O encaminhamento é reservado para falha terapêutica ou situações de maior complexidade.

RESUMO (TLDR)

Depressão na APS: O Que Realmente Importa?

O médico da APS é protagonista no manejo do TDM — a maioria dos casos pode ser tratada na UBS.

1. Diagnóstico

- ≥ 5 sintomas por ≥ 2 semanas (obrigatório: humor deprimido e/ou anedonia)
- PHQ-9 $\geq 10 \rightarrow$ sensibilidade e especificidade $> 80\%$
- Sempre excluir causas orgânicas (TSH, hemograma)

2. Tratamento por Gravidade

- Leve $\rightarrow$ psicoterapia isolada pode ser suficiente
- Moderada a grave (PHQ-9 ≥ 10) $\rightarrow$ **ISRS obrigatório** ($\pm$ psicoterapia)
- Primeira linha: fluoxetina ou sertralina (RENAME)

3. Regras de Ouro

- Dose baixa inicial, subir em 1-2 semanas
- Orientar latência de 2-4 semanas
- Reavaliar em 2-4 semanas (adesão + efeitos adversos + risco suicida)
- Tricíclicos: **NÃO** são primeira linha na APS
- Benzodiazepínicos: **NÃO** tratam depressão

4. Pérola

- Se PHQ-9 ≥ 15 e a alternativa não inclui fármaco $\rightarrow$ está errada!

QUESTÃO 85 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Transtornos de Ansiedade ■ Gabarito: B

Mulher de 34 anos procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de "preocupação constante" há cerca de 10 meses. Relata que se sente tensa e inquieta a maior parte do dia, com dificuldade para relaxar, mesmo nos finais de semana. Refere insônia inicial, fadiga ao longo do dia, dificuldade de concentração no trabalho e episódios frequentes de cefaleia tensional e dor muscular cervical. Nega uso de substâncias psicoativas. Nega episódios de medo súbito e intenso com sintomas autonômicos abruptos. Nega humor persistentemente deprimido ou anedonia. Exame físico sem alterações relevantes; TSH e T4 livre normais. Aplicado o instrumento GAD-7, que pontua 14 (ansiedade moderada a grave). A paciente deseja iniciar tratamento e questiona o médico sobre qual a melhor abordagem. Considerando o diagnóstico mais provável e as diretrizes atuais, a conduta inicial mais adequada é:

- (A) Iniciar clonazepam em dose baixa como monoterapia de manutenção, associado a orientações sobre higiene do sono.
- (B) ✓ **Iniciar inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como sertralina, associado ao encaminhamento para terapia cognitivo-comportamental.**
- (C) Prescrever buspirona em monoterapia e reavaliar em 12 semanas, sem necessidade de psicoterapia complementar.
- (D) Encaminhar diretamente ao psiquiatra para introdução de pregabalina, por ser primeira linha no transtorno de ansiedade generalizada.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA** - O clonazepam é um benzodiazepínico de alta potência. Embora seja eficaz no alívio rápido dos sintomas ansiosos, seu uso como **monoterapia de manutenção** no TAG é inadequado e contraindicado pelas diretrizes atuais. Os benzodiazepínicos têm risco elevado de dependência, tolerância e comprometimento cognitivo com uso prolongado. Seu papel no TAG é restrito a **adjuvância por curto prazo** (2-4 semanas), enquanto o ISRS atinge o efeito terapêutico. Além disso, higiene do sono isolada não constitui abordagem psicoterápica estruturada.

(B) ✓ **CORRETA** - A associação de um **ISRS (sertralina)** com **Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)** é a conduta de primeira linha mais bem embasada para o TAG moderado a grave, conforme as diretrizes da ABP (2023) e protocolos da APS. A sertralina é um ISRS com boa evidência, perfil de segurança favorável e disponibilidade no SUS (Rename). A TCC é a modalidade psicoterapêutica com maior evidência de eficácia no TAG, atuando na reestruturação cognitiva e nas estratégias de enfrentamento. A combinação farmacoterapia + psicoterapia apresenta os melhores desfechos em termos de remissão e prevenção de recaídas.

(C) **X INCORRETA** - A buspirona é um agonista parcial do receptor 5-HT_{1A} que pode ser útil como adjuvante em casos leves ou como alternativa para pacientes que não toleram ISRS. No entanto, sua eficácia como **monoterapia** em TAG moderado a grave (GAD-7 = 14) é limitada. Além disso, afirmar que não há necessidade de psicoterapia complementar contradiz as evidências: a TCC é componente fundamental do tratamento do TAG e sua associação à farmacoterapia melhora significativamente os desfechos.

(D) **X INCORRETA** - A pregabalina é uma alternativa terapêutica para o TAG, mas **não é primeira linha**. Ela está indicada como segunda linha para pacientes que não responderam ou não toleraram ISRS/IRSN. Além disso, o manejo inicial do TAG **pode e deve** ser feito na Atenção Primária, sem necessidade de encaminhamento direto ao psiquiatra. O encaminhamento é reservado para refratariedade, comorbidades psiquiátricas complexas ou dúvida diagnóstica. O enunciado não apresenta nenhuma dessas indicações.

RESUMO (TLDR)

TAG: O Que Realmente Importa?

Preocupação excessiva e difusa por ≥ 6 meses com sintomas somáticos e prejuízo funcional.

1. Diagnóstico

- ≥ 3 sintomas: inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia
- Excluir causas orgânicas (TSH, substâncias)
- GAD-7 $\geq 10 \rightarrow$ investigar e tratar

2. Tratamento de 1ª Linha

- **Farmacológico:** ISRS (sertralina, escitalopram) ou IRSN (venlafaxina)
- **Psicoterapia:** TCC
- **Combinação ISRS + TCC** = melhor resultado

3. O Que NÃO É 1ª Linha

- Benzodiazepínicos $\rightarrow$ apenas adjuvante por curto prazo (2-4 semanas)
- Pregabalina $\rightarrow$ 2ª linha
- Buspirona $\rightarrow$ eficácia limitada como monoterapia em quadros moderados/graves

4. Pérola

- O TAG é manejado na APS. Encaminha ao psiquiatra apenas se refratário, comorbidade complexa ou risco de suicídio.

QUESTÃO 86 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Esquizofrenia e Psicoses ■ Gabarito: A

Homem de 22 anos é trazido ao pronto-socorro por familiares após quadro de agitação psicomotora intensa, com início há aproximadamente 48 horas. A mãe relata que, nas últimas três semanas, o paciente passou a apresentar comportamento progressivamente estranho: trancava-se no quarto, recusava alimentação por acreditar que a comida estava envenenada, conversava sozinho e afirmava ouvir vozes que comentavam seus atos. Não há história pessoal prévia de transtorno psiquiátrico, uso de substâncias psicoativas ou episódios semelhantes. Nega trauma cranioencefálico recente. Ao exame físico geral: temperatura axilar de $36,7^\circ\text{C}$, frequência cardíaca de 98 bpm, pressão arterial de 130×82 mmHg, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais neurológicos focais. Ao exame do estado mental: paciente vigil, porém desconfiado e hostil, com discurso desorganizado, delírios persecutórios estruturados e alucinações auditivas verbais em terceira pessoa. Hemograma, função renal, função hepática, glicemia, eletrólitos, TSH e exame qualitativo de urina para drogas de abuso resultaram normais. Tomografia computadorizada de crânio sem contraste sem alterações. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável e a abordagem inicial adequada, qual é a conduta prioritária neste momento?

(A) ✓ **Iniciar antipsicótico de segunda geração em dose baixa, com titulação progressiva, e programar acompanhamento ambulatorial em serviço especializado de intervenção precoce em psicose.**

(B) Solicitar ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma antes de qualquer intervenção farmacológica, mantendo o paciente apenas em observação clínica.

(C) Prescrever benzodiazepínico de ação prolongada como monoterapia para controle da agitação e encaminhar para consulta psiquiátrica ambulatorial em até 30 dias.

(D) Iniciar antipsicótico de primeira geração em dose alta para obter remissão rápida dos sintomas e solicitar internação compulsória de longa permanência.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ **CORRETA.** Olha só, essa é a conduta ideal no Primeiro Episódio Psicótico. Note que o caso já descartou causas orgânicas (exames laboratoriais normais, toxicológico negativo, TC de crânio sem alterações) e o quadro clínico é altamente sugestivo de psicose primária (provável esquizofrenia). O próximo passo é iniciar tratamento farmacológico para reduzir a Duração de Psicose Não Tratada (DUP). Os **antipsicóticos de segunda geração (atípicos) em dose baixa** são a primeira escolha no PEP, pois apresentam menor risco de efeitos extrapiramidais, o que favorece a adesão — fator crítico em pacientes virgens de tratamento. A titulação progressiva respeita o princípio "start low, go slow". O encaminhamento para serviço especializado de intervenção precoce em psicose completa a abordagem integrada recomendada pelas diretrizes, que inclui farmacoterapia, psicoeducação, psicoterapia e reabilitação psicossocial.

(B) ✗ **INCORRETA.** Perceba que o paciente já realizou TC de crânio sem alterações, exames laboratoriais completos normais e toxicológico negativo. A ressonância magnética de crânio e o eletroencefalograma são exames de **segunda linha**, indicados quando há sinais neurológicos focais, crises epiléticas, alteração do nível de consciência ou apresentação clínica atípica — nenhum desses elementos está presente neste caso. Manter o paciente "apenas em observação" sem iniciar antipsicótico **aumenta a DUP**, piorando diretamente o prognóstico. Essa é uma armadilha clássica: postergar indefinidamente o tratamento em busca de exames adicionais sem indicação clínica precisa. A propedêutica básica já foi suficiente para excluir as causas orgânicas mais relevantes.

(C) **X INCORRETA.** Os benzodiazepínicos têm papel **adjuvante** no manejo agudo da agitação psicomotora, mas **nunca** como monoterapia no PEP. Eles não atuam sobre os sintomas psicóticos (delírios e alucinações) — apenas promovem sedação, mascarando a apresentação clínica sem modificar a doença de base. Além disso, um benzodiazepínico de ação prolongada como monoterapia traz riscos adicionais: sedação excessiva, depressão respiratória e potencial de dependência. O encaminhamento para "consulta ambulatorial em até 30 dias" sem tratamento antipsicótico específico significaria uma DUP de pelo menos mais um mês, com impacto negativo direto no prognóstico.

(D) **X INCORRETA.** Essa alternativa comete dois erros graves. Primeiro: antipsicóticos de **primeira geração em dose alta** são especialmente problemáticos no PEP. Pacientes virgens de tratamento têm alta sensibilidade a efeitos extrapiramidais (distonia aguda, acatisia, parkinsonismo), e doses elevadas aumentam drasticamente o risco desses efeitos, comprometendo a adesão ao tratamento. As diretrizes recomendam justamente o oposto: doses baixas com titulação gradual. Segundo: a **internação compulsória de longa permanência** viola os princípios da Lei 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que determina que a internação compulsória é recurso excepcional, de curta duração, aplicável somente quando esgotadas todas as alternativas extra-hospitalares. A abordagem moderna do PEP prioriza o tratamento comunitário e ambulatorial.

RESUMO (TLDR)

Primeiro Episódio Psicótico: O Que Realmente Importa?

O PEP é uma **janela de oportunidade** — o manejo inicial define o prognóstico a longo prazo.

1. Avaliação Inicial

- Exclusão de causas orgânicas é **obrigatória**: lab completo + toxicológico + TC crânio
- RM/EEG só se houver sinais focais, crises ou apresentação atípica

2. Tratamento Farmacológico

- **Atípicos em dose baixa** são primeira escolha (menor risco extrapiramidal → melhor adesão)
- Princípio: *start low, go slow*
- Benzodiazepínicos são **adjuvantes** para agitação, nunca monoterapia

3. Seguimento

- Encaminhar a serviço de **intervenção precoce em psicose**
- Abordagem integrada: fármaco + psicoterapia + psicoeducação familiar + reabilitação

4. Pérola

- **DUP curta = melhor prognóstico.** Não atrase o tratamento com exames desnecessários quando a propedêutica básica já descartou causas orgânicas.

QUESTÃO 87 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Transtorno Bipolar ■ Gabarito: A

Homem de 26 anos é trazido ao ambulatório de psiquiatria por familiares, que relatam mudança importante no comportamento nas últimas duas semanas. Segundo a mãe, o paciente abandonou o emprego dizendo que "não precisa mais trabalhar porque vai abrir uma empresa milionária", passou a dormir apenas 2-3 horas por noite sem apresentar cansaço, fala incessantemente sobre projetos grandiosos e fez compras de alto valor com cartões de crédito de familiares. Há relato de um episódio depressivo grave há 8 meses, tratado com sertralina por médico da UBS, com remissão parcial. Nega uso de substâncias psicoativas; exames toxicológicos negativos. Exames laboratoriais (hemograma, função tireoidiana, glicemia, função renal e hepática) sem alterações. Ao exame do estado mental: vigil, orientado, humor expansivo e eufórico, pensamento acelerado com fuga de ideias, autoestima inflada com ideias de grandeza ("sou o homem mais inteligente do país"), loquaz, sem alucinações ou delírios persecutórios, juízo de realidade parcialmente comprometido. Considerando o quadro clínico e a história psiquiátrica pregressa, qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta farmacológica inicial mais adequada?

(A) **✓ Transtorno bipolar tipo I — iniciar lítio como estabilizador de humor e suspender a sertralina.**

(B) Transtorno bipolar tipo II — manter sertralina e associar lamotrigina para prevenção de novos episódios depressivos.

(C) Transtorno de personalidade borderline — iniciar fluoxetina e encaminhar para psicoterapia dialético-comportamental.

(D) Episódio depressivo com características mistas — aumentar a dose de sertralina e associar benzodiazepínico.

COMENTÁRIOS

(A) **✓ CORRETA.** Perceba que o paciente preenche todos os critérios para um episódio maníaco pelo DSM-5-TR: humor expansivo/eufórico há 2 semanas, grandiosidade ("sou o homem mais inteligente do país"), redução da necessidade de sono sem cansaço, loquacidade com pressão de fala, fuga de ideias, atividade dirigida aumentada (abandonou emprego para "abrir empresa milionária") e exposição a riscos (compras com cartão de familiares). São mais de 3 sintomas com humor elevado, duração > 7 dias e claro prejuízo funcional. A existência de um episódio depressivo prévio associado a um episódio maníaco completo classifica como **TAB tipo I**. A conduta correta na mania aguda é iniciar estabilizador de humor — o **lítio** é primeira linha conforme o PCDT do Ministério da Saúde e as diretrizes CANMAT/ISBD 2023. Além disso, a **sertralina deve ser suspensa**, pois antidepressivos em

monoterapia podem agravar a mania, prolongar o episódio e induzir ciclagem rápida.

(B) X INCORRETA. Essa alternativa erra em dois pontos fundamentais. Primeiro, o diagnóstico: o episódio atual é claramente **maníaco** (≥ 7 dias, prejuízo funcional grave, grandiosidade exuberante), o que define TAB **tipo I**, e não tipo II. Para ser TAB tipo II, o paciente jamais poderia ter apresentado um episódio maníaco completo — apenas hipomania (≥ 4 dias, sem prejuízo funcional grave, sem psicose). Segundo, a conduta: manter sertralina durante um episódio maníaco é contraindicado, pois pode agravar a mania. Além disso, a **lamotrigina** não é eficaz no tratamento da mania aguda — sua indicação é na **profilaxia de episódios depressivos** bipolares em fase de manutenção.

(C) X INCORRETA. O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um diagnóstico diferencial importante, mas o quadro deste paciente não é compatível. Note que o TPB se caracteriza por instabilidade emocional **crônica e contínua**, reativa a estressores interpessoais, com medo de abandono, relações instáveis e autoimagem cronicamente perturbada. No caso apresentado, o episódio é **discreto** (início definido há 2 semanas), com grandiosidade exuberante, redução de sono sem cansaço e curso espontâneo — padrão episódico típico do TAB, não do TPB. Além disso, o tratamento do TPB **não** envolve antidepressivos como primeira linha isolada; a psicoterapia dialético-comportamental é a intervenção central, mas a escolha farmacológica seria outra e o diagnóstico está equivocado.

(D) X INCORRETA. Esta alternativa comete dois erros graves. Primeiro, o diagnóstico: o quadro é de **mania franca** (humor expansivo/eufórico, grandiosidade, energia aumentada), e não de depressão com características mistas. Embora o DSM-5-TR reconheça especificadores "com características mistas" (sintomas do polo oposto presentes durante o episódio), o polo predominante aqui é claramente o **maníaco**. Segundo, e mais perigoso: **aumentar a dose de sertralina** em um paciente com mania ativa é absolutamente contraindicado — pode intensificar o episódio maníaco, precipitar psicose e induzir ciclagem rápida. O uso de benzodiazepínico pode ter papel adjuvante pontual na agitação, mas nunca como conduta principal e nunca combinado com escalonamento de antidepressivo na mania.

RESUMO (TLDR)

Transtorno Bipolar: O Que Realmente Importa?

Reconhecer mania e diferenciar de outras condições é essencial para a conduta correta.

1. Diagnóstico de Mania (DSM-5-TR)

- Humor elevado/expansivo ou irritável + energia por ≥ 7 dias
- ≥ 3 sintomas (ou ≥ 4 se só irritável): grandiosidade, insônia sem cansaço, loquacidade, fuga de ideias, distraibilidade, atividade dirigida, riscos
- Um episódio maníaco = TAB tipo I

2. Conduta na Mania Aguda

- **Iniciar:** Estabilizador de humor (lítio ou valproato) $\pm$ antipsicótico atípico
- **Suspender:** Antidepressivos — risco de virada maníaca e ciclagem rápida
- Lamotrigina **NÃO** trata mania aguda (é para profilaxia de depressão bipolar)

3. Diferencial TAB vs. TPB

- TAB: episódico, espontâneo, grandiosidade, sono reduzido sem cansaço
- TPB: crônico, reativo a estressores interpessoais, vazão crônico, autoestima baixa

4. Pérola

Se a prova diz "episódio com início definido + grandiosidade + energia aumentada" → pense TAB. Se diz "padrão crônico + reatividade interpessoal" → pense TPB.

QUESTÃO 88 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Dependência Química ■ Gabarito: B

Homem de 52 anos é trazido ao pronto-socorro pelo SAMU após ser encontrado agitado e confuso em via pública. Familiares referem que o paciente faz uso diário de destilados há mais de 20 anos, consumindo cerca de uma garrafa por dia, e que interrompeu abruptamente a ingestão de álcool há aproximadamente 72 horas, após episódio de hematêmese tratado em outro serviço. Ao exame físico: Glasgow 13 (AO 3, RV 4, RM 6), desorientado em tempo e espaço, agitação psicomotora importante, sudorese profusa, tremores grosseiros de extremidades, temperatura axilar de 38,4°C, frequência cardíaca de 124 bpm, pressão arterial de 168 × 102 mmHg. Durante a avaliação, apresenta episódio de alucinação visual (relata ver insetos caminhando pela parede). A escala CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised) totaliza 26 pontos. A respeito do manejo inicial mais adequado para este paciente, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar haloperidol endovenoso como medicação de primeira linha para controle da agitação e das alucinações, associado à reposição de tiamina intramuscular.

(B) ✓ Administrar diazepam endovenoso para controle dos sintomas de abstinência, associado à reposição de tiamina intramuscular antes da administração de glicose.

(C) Administrar carbamazepina via oral como medicação de primeira linha para profilaxia de crises convulsivas, associada à hidratação venosa vigorosa.

(D) Administrar fenobarbital endovenoso como medicação de primeira escolha para controle da abstinência grave, reservando benzodiazepínicos apenas para refratariedade.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** O haloperidol é um antipsicótico típico que **não é primeira linha** no tratamento da SAA. Embora possa ser utilizado como adjuvante em baixa dose para alucinações refratárias ao tratamento com benzodiazepínicos, ele não atua na causa fisiopatológica da abstinência (desequilíbrio GABA/glutamato). Além disso, a clorpromazina — outro antipsicótico típico — é contraindicada por reduzir o limiar convulsivo. As diretrizes brasileiras (Linhas de Cuidado MS) recomendam que, se necessário antipsicótico, dê-se preferência ao haloperidol em baixa dose, mas **sempre associado** a benzodiazepínicos, nunca como monoterapia inicial. Neste caso, com CIWA-Ar de 26 (grave) e sinais de delirium tremens, a prioridade absoluta são os benzodiazepínicos endovenosos.

(B) ✓ **CORRETA.** Perceba que este paciente apresenta SAA grave (CIWA-Ar = 26, > 18) com sinais de delirium tremens (rebaixamento de consciência, desorientação, alucinações visuais, hiperatividade autonômica intensa, 72h de abstinência). O manejo correto envolve duas medidas simultâneas e complementares:

1. **Diazepam endovenoso** — droga de primeira linha na SAA grave e no delirium tremens. Atua no receptor GABA-A, compensando farmacologicamente a hiperexcitabilidade neuronal causada pela retirada abrupta do álcool. A via EV é obrigatória pela gravidade do quadro e pela necessidade de titulação rápida.

2. **Tiamina intramuscular ANTES da glicose** — todo etilista crônico tem risco de deficiência de tiamina. A administração de glicose sem reposição prévia de tiamina pode precipitar a encefalopatia de Wernicke (confusão + ataxia + oftalmoplegia), condição potencialmente irreversível.

Esta alternativa contempla corretamente as duas prioridades do manejo: tratar a abstinência grave (BZD EV) e prevenir complicação neurológica (tiamina antes de glicose).

(C) ✗ **INCORRETA.** A carbamazepina é um anticonvulsivante que pode ter papel no manejo ambulatorial da SAA leve a moderada, mas apresenta múltiplos problemas neste cenário:

- **Via oral em paciente com Glasgow 13, agitado e confuso** → risco de broncoaspiração e absorção errática
- **Não é primeira linha na SAA grave** → evidência inferior aos benzodiazepínicos para prevenção de delirium tremens e redução de mortalidade
- **"Hidratação venosa vigorosa"** não é adequada de forma indiscriminada em etilista crônico, que frequentemente apresenta hepatopatia com risco de descompensação ascítica e hipertensão portal

Além disso, esta alternativa omite completamente a reposição de tiamina, que é obrigatória.

(D) ✗ **INCORRETA.** O fenobarbital é um barbitúrico com ação GABAérgica que, de fato, pode ser eficaz na SAA refratária aos benzodiazepínicos. No entanto, ele **não é primeira escolha**. As razões são:

- **Margem terapêutica estreita** → risco elevado de depressão respiratória, especialmente em hepatopatas
- **Meia-vida muito longa** → acúmulo e dificuldade de titulação
- **Indicação restrita** → reservado para protocolos de UTI em casos refratários a doses altas de benzodiazepínicos

A inversão proposta pela alternativa (fenobarbital como primeira linha e BZD como resgate) é o contrário do preconizado pelas diretrizes. Os benzodiazepínicos são sempre a primeira linha, com fenobarbital ou propofol reservados para refratariedade em ambiente de terapia intensiva.

RESUMO (TLDR)

SAA e Delirium Tremens: O Que Realmente Importa?

A SAA é uma emergência com mortalidade de até 5%. O manejo correto salva vidas.

1. Classificação (CIWA-Ar)

- Leve (< 10): suporte, sem BZD obrigatório
- Moderada (10-18): BZD via oral
- Grave (> 18): BZD endovenoso — diazepam titulado

2. As Duas Prioridades Simultâneas

- Tiamina IM/EV → antes de qualquer glicose (previne Wernicke)
- Diazepam EV → primeira linha na SAA grave e delirium tremens

3. O Que NÃO Fazer

- Haloperidol como monoterapia inicial
- Carbamazepina VO em paciente com rebaixamento de consciência
- Fenobarbital como primeira escolha (reservar para refratariedade em UTI)

4. Pérola

Delirium tremens ≠ alucinação alcoólica: no DT há **rebaixamento de consciência + desorientação**. Na alucinação, o sensorio está preservado.

QUESTÃO 89 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Rede de Atenção Psicossocial ■ Gabarito: C

Uma médica de família e comunidade atua em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em um município de médio porte. Ela percebe que, nos últimos meses, houve aumento significativo no número de pacientes com queixas de sofrimento psíquico — insônia, ansiedade, uso abusivo de álcool e tentativas de suicídio — que retornam frequentemente ao serviço sem melhora adequada. A profissional solicita apoio ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município para discutir os casos mais complexos e receber orientações sobre o manejo dessas situações na própria Atenção Primária. O CAPS agenda encontros periódicos com a equipe da UBS para discussão conjunta de casos, elaboração de projetos terapêuticos singulares e capacitação dos profissionais da equipe de saúde da família. Essa estratégia de articulação entre CAPS e Atenção Primária à Saúde, que visa ampliar a resolutividade do cuidado em saúde mental no território, é denominada

- (A) interconsulta psiquiátrica.
- (B) referência e contrarreferência.
- (C) ✓ **apoio matricial em saúde mental.**
- (D) regulação assistencial da rede psicossocial.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A **interconsulta psiquiátrica** é um modelo de parecer especializado, tipicamente pontual e unidirecional. Nela, o médico generalista solicita avaliação do psiquiatra para um caso específico, e o especialista emite um parecer ou conduta. A relação é verticalizada — não envolve a discussão conjunta continuada, a capacitação da equipe nem a corresponsabilização pelo cuidado. No cenário descrito, há encontros periódicos, discussão compartilhada e construção de PTS, o que ultrapassa o conceito de interconsulta.

(B) **X INCORRETA.** O sistema de **referência e contrarreferência** é o mecanismo tradicional de encaminhamento de pacientes entre níveis de atenção. A equipe da APS "refere" o paciente ao especialista, que o atende e depois "contrarrefere" de volta com orientações. Perceba que, nesse modelo, há transferência temporária da responsabilidade do cuidado. O cenário da questão descreve algo diferente: o paciente permanece sob responsabilidade da equipe da UBS, e o CAPS oferece suporte colaborativo — exatamente a lógica do matriciamento.

(C) **✓ CORRETA.** O **apoio matricial em saúde mental** (ou matriciamento) é exatamente a estratégia descrita no enunciado. Seus elementos-chave estão todos presentes: (1) a equipe do CAPS oferece suporte técnico-pedagógico e assistencial à equipe da UBS; (2) há discussão conjunta de casos e elaboração de PTS; (3) o objetivo é ampliar a resolutividade da APS; (4) não há transferência da responsabilidade — o paciente continua vinculado à equipe de referência. O matriciamento é uma diretriz fundamental da RAPS, com metas de monitoramento vinculadas ao cofinanciamento federal (COFI-RAPS).

(D) **X INCORRETA.** A **regulação assistencial** é um mecanismo administrativo de ordenação do acesso dos usuários aos serviços de saúde. Envolve a gestão de vagas, filas de espera, cotas de atendimento e encaminhamentos regulados entre os pontos da rede. Trata-se de um sistema logístico, e não de uma estratégia de troca de saberes, capacitação ou corresponsabilização clínica. O cenário apresentado não descreve um processo regulatório, mas sim uma articulação colaborativa direta entre profissionais.

RESUMO (TLDR)

Matriciamento em Saúde Mental: O Que Realmente Importa?

O matriciamento é a estratégia que conecta CAPS e APS de forma colaborativa, sem transferir o cuidado.

1. O Que É

- Suporte técnico-pedagógico e assistencial do CAPS para a equipe da APS
- Relação horizontal, com corresponsabilização e cogestão
- Ferramentas: discussão de casos, consultas compartilhadas, PTS

2. O Que NÃO É

- Não é interconsulta (pontual)
- Não é referência/contrarreferência (transfere responsabilidade)
- Não é regulação (administrativo)

3. Pérola

- O paciente **permanece** na APS — o CAPS apoia, mas não assume o caso
- Meta federal: mínimo 4 matriciamentos/quadrimestre por CAPS (COFI-RAPS)

QUESTÃO 90 ■ Saúde Mental / Psiquiatria ■ Psicofarmacologia ■ Gabarito: B

Adolescente de 16 anos, sexo masculino, é acompanhado no ambulatório de psiquiatria de um centro de atenção psicossocial infantojuvenil (CAPSiJ) por diagnóstico de transtorno bipolar tipo I, confirmado há oito meses, após episódio maníaco com sintomas psicóticos. Após estabilização do quadro agudo com antipsicótico atípico, foi iniciado carbonato de lítio como estabilizador do humor para profilaxia de novos episódios. O paciente encontra-se eutímico há quatro meses, sem queixas atuais, e o responsável questiona sobre os cuidados necessários durante o uso contínuo da medicação. A litemia de controle, coletada há uma semana, foi de 0,8 mEq/L. Exames laboratoriais recentes demonstram: TSH 6,8 mUI/L (referência: 0,4–4,0), T4 livre 0,7 ng/dL (referência: 0,8–1,8), creatinina sérica 0,9 mg/dL, ureia 28 mg/dL, sódio 141 mEq/L, potássio 4,2 mEq/L. Considerando o quadro clínico e os resultados laboratoriais, a conduta mais adequada neste momento é:

(A) Suspender o lítio imediatamente e substituí-lo por ácido valproico, pois a alteração tireoidiana é contraindicação absoluta ao uso continuado do lítio.

(B) ✓ **Manter o lítio na dose atual e iniciar reposição com levotiroxina, com reavaliação da função tireoidiana em seis a oito semanas.**

(C) Reduzir a dose do lítio pela metade e solicitar nova dosagem de TSH e T4 livre em duas semanas, antes de considerar reposição hormonal.

(D) Manter o lítio e apenas observar clinicamente, pois a elevação do TSH é transitória e autolimitada na maioria dos pacientes jovens.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** A suspensão imediata do lítio seria um erro conceitual importante. O hipotireoidismo induzido por lítio **não** é contraindicação absoluta ao seu uso continuado. Perceba que o paciente está eutímico há quatro meses com um estabilizador de humor de primeira linha, com evidência única de redução de suicídio. Trocar por ácido valproico significaria abrir mão desse benefício prognóstico sem necessidade, uma vez que a alteração tireoidiana é facilmente manejável com reposição hormonal (levotiroxina). A suspensão do lítio estaria indicada apenas em situações como intoxicação, nefrotoxicidade grave com perda significativa de função renal ou intolerância não manejável — e não por hipotireoidismo corrigível.

(B) ✓ **CORRETA.** Essa é a conduta preconizada. O paciente apresenta hipotireoidismo clínico (TSH elevado + T4 livre baixo) induzido pelo lítio, um efeito adverso que ocorre em até 20-30% dos usuários. A litemia está em faixa terapêutica (0,8 mEq/L), a função renal é normal e o paciente está eutímico em profilaxia de transtorno bipolar tipo I — ou seja, o lítio está sendo eficaz. Conforme o PCDT do Transtorno Bipolar Tipo I (CONITEC, 2024) e as recomendações da AAPB (2024), a conduta é **manter o lítio e iniciar reposição com levotiroxina**, reavaliando a função tireoidiana em 6-8 semanas para ajuste posológico. Essa abordagem preserva os benefícios do lítio (estabilização do humor e redução do risco de suicídio) enquanto corrige o efeito adverso tireoidiano.

(C) **X INCORRETA.** Reduzir a dose do lítio pela metade seria inadequado por dois motivos. Primeiro, a litemia atual (0,8 mEq/L) está dentro da faixa terapêutica e o paciente está eutímico — reduzir a dose comprometeria a eficácia profilática e aumentaria o risco de recaída. Segundo, o hipotireoidismo por lítio nem sempre é dose-dependente de forma linear; reduzir a dose pode não resolver a alteração tireoidiana e, simultaneamente, desproteger o paciente contra novos episódios. A conduta correta é manter a dose eficaz e tratar o hipotireoidismo com levotiroxina.

(D) **X INCORRETA.** A "observação clínica" sem intervenção seria inadequada neste caso. Note que o paciente já apresenta hipotireoidismo franco (não apenas subclínico): TSH 6,8 mUI/L com T4 livre abaixo do limite inferior (0,7 ng/dL). Embora elevações leves e transitórias do TSH possam ocorrer no início do tratamento com lítio, este paciente já está em uso há vários meses e apresenta alteração laboratorial consistente. Hipotireoidismo não tratado em adolescentes pode comprometer crescimento, desenvolvimento cognitivo e, paradoxalmente, piorar o quadro do humor (a depressão do hipotireoidismo pode mimetizar ou

agravar a depressão bipolar). Portanto, a reposição com levotiroxina é necessária.

RESUMO (TLDR)

Manejo do Lítio: O Que Realmente Importa?

O lítio é o padrão-ouro no transtorno bipolar, com evidência única de redução de suicídio.

1. Monitorização Obrigatória

- Litemia (12h pós-dose): manutenção 0,6-1,0 mEq/L
- TSH + T4L: a cada 6 meses
- Creatinina + TFG_e: a cada 6 meses
- Cálcio: anualmente

2. Hipotireoidismo por Lítio

- Ocorre em 20-30% dos pacientes
- **Conduta:** manter lítio + iniciar levotiroxina
- NÃO é indicação para suspender o lítio

3. Quando Suspender o Lítio?

- Intoxicação (>1,5 mEq/L)
- Nefrotoxicidade grave progressiva
- Ineficácia clínica

Pérola

Se a questão traz lítio eficaz + tireoide alterada → a resposta é SEMPRE manter + levotiroxina.

VIII. Conhecimentos Gerais

QUESTÃO 91 ■ Conhecimentos Gerais ■ Inteligência Artificial em Saúde ■ Gabarito: B

Um hospital universitário está avaliando a implantação de um sistema de inteligência artificial (IA) para auxiliar no diagnóstico de sepse no pronto-socorro. Durante a validação do algoritmo, identificou-se que o sistema apresenta sensibilidade significativamente menor para pacientes pretos e pardos, pois os dados utilizados para treinar o modelo eram predominantemente de pacientes brancos de hospitais norte-americanos. Diante dessa constatação, a conduta mais adequada da equipe gestora é

- (A) implantar o sistema informando aos profissionais sobre a limitação, para que cada médico decida se aceita ou rejeita a sugestão do algoritmo.
- (B) ✓ **suspender a implantação até que o algoritmo seja submetido a auditoria independente e retreinado com dados representativos da população atendida.**
- (C) implantar o sistema normalmente, pois a decisão final permanece com o médico e a IA funciona apenas como ferramenta auxiliar.
- (D) rejeitar permanentemente qualquer uso de IA no hospital, já que algoritmos são fundamentalmente incompatíveis com a prática médica.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Implantar um sistema com viés identificado, mesmo com ressalvas, expõe um grupo populacional a risco de subdiagnóstico. O princípio da não maleficência exige que o problema seja corrigido ANTES da implantação, não transferido ao médico individualmente.

(B) ✓ **CORRETA.** Diante de viés algorítmico comprovado, a conduta ética é suspender a implantação, realizar auditoria independente, retreinar o modelo com dados representativos e revalidar. Essa abordagem respeita os princípios de equidade, transparência e não maleficência em IA aplicada à saúde.

(C) ✗ **INCORRETA.** A autonomia do médico não neutraliza o viés do algoritmo. Se o sistema fornece resultados enviesados, mesmo como "auxílio", ele pode influenciar negativamente as decisões clínicas para pacientes pretos e pardos, perpetuando desigualdades.

(D) ✗ **INCORRETA.** Rejeitar toda e qualquer IA é uma postura desproporcional. Sistemas de IA bem desenvolvidos e validados podem melhorar o cuidado em saúde. O problema identificado é específico (viés nos dados) e tem solução técnica (retreinamento e revalidação).

RESUMO (TLDR)

Ética e Viés em IA na Saúde: O Que Realmente Importa?

A IA pode melhorar o cuidado, mas só se for equitativa, transparente e segura para todos.

1. Viés Algorítmico

- Ocorre quando dados de treinamento não representam a diversidade da população-alvo
- Pode amplificar desigualdades raciais, de gênero e etárias no cuidado
- Exemplo clássico: menor sensibilidade diagnóstica em pacientes de pele escura

2. Princípios Éticos OMS (2021/2024)

- Autonomia humana, bem-estar, transparência, responsabilização, equidade, sustentabilidade
- A decisão final é sempre do profissional, mas o sistema precisa ser seguro *antes* da implantação

3. O Que Fazer Diante de Viés?

- **Suspender** a implantação
- **Auditar** de forma independente
- **Retreinar** com dados representativos locais
- **Revalidar** o desempenho por subgrupos

4. Pérola

Nunca aceite "implantar mesmo assim" nem "rejeitar tudo". O caminho ético é: **corrigir e revalidar**.

QUESTÃO 92 ■ Conhecimentos Gerais ■ Mudanças Climáticas e Saúde ■ Gabarito: A

Uma equipe de vigilância epidemiológica de um município do interior de São Paulo observa, no primeiro trimestre de 2025, aumento expressivo de casos de dengue em bairros periféricos que antes tinham baixa incidência. O Levantamento Rápido de Índice para *Aedes aegypti* (LIRAa) revela Índice de Infestação Predial (IIP) de 4,8%. Os dados meteorológicos apontam elevação de 1,1 °C na temperatura média local na última década, com prolongamento do período chuvoso. Sobre a situação descrita, é correto afirmar:

(A) ✓ O IIP acima de 3,9% classifica o município em situação de risco para arboviroses, e a elevação da temperatura favorece a expansão da atividade do vetor, exigindo medidas emergenciais integradas.

(B) A temperatura local não influencia a transmissão de arboviroses, pois a presença do vetor depende apenas de fatores urbanísticos como acúmulo de lixo e água parada.

(C) O IIP de 4,8% classifica o município em nível de alerta moderado, sendo suficiente manter as ações rotineiras de educação em saúde.

(D) A vigilância deve limitar-se à notificação de casos no SINAN, sem necessidade de integrar dados entomológicos ou climáticos ao plano de contingência.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. O IIP $\geq 3,9\%$ classifica o município em **situação de risco** (não apenas alerta), exigindo medidas emergenciais. A elevação da temperatura favorece a expansão geográfica do *Aedes aegypti*, acelerando o ciclo reprodutivo e aumentando a competência vetorial. A resposta adequada exige vigilância integrada (epidemiológica + entomológica + ambiental).

(B) ✗ INCORRETA. A temperatura é um dos fatores mais importantes na dinâmica de transmissão das arboviroses. Temperaturas mais altas encurtam o ciclo de desenvolvimento do mosquito, aumentam a taxa de picadas e aceleram a replicação viral dentro do vetor.

(C) ✗ INCORRETA. O IIP de 4,8% está acima de 3,9%, classificando o município em **risco** (não alerta). A classificação do LIRAa é: $< 1\%$ = satisfatório; $1-3,9\%$ = alerta; $\geq 3,9\%$ = risco. Situações de risco exigem medidas emergenciais, não apenas ações rotineiras.

(D) ✗ INCORRETA. A vigilância de arboviroses deve ser integrada, combinando dados epidemiológicos (SINAN), entomológicos (LIRAa) e climáticos para uma resposta efetiva. Restringir-se apenas à notificação de casos é insuficiente para o controle vetorial.

RESUMO (TLDR)**Arboviroses e Mudanças Climáticas: O Que Realmente Importa?**

A expansão das arboviroses no Brasil está diretamente ligada a determinantes socioambientais amplificados pelas mudanças climáticas.

1. Estratificação de Risco (LIRAa)

- IIP $< 1,0\%$ → Satisfatório (rotina)
- IIP $1,0\%-3,9\%$ → Alerta (intensificar)
- IIP $\geq 3,9\%$ → **Risco** (medidas emergenciais)

2. Impacto Climático

- Temperatura $\uparrow$ → ciclo do mosquito mais curto → mais gerações/ano
- Chuvas concentradas → criadouros peridomiciliares
- Sazonalidade atenuada → transmissão mais prolongada

3. Vigilância Integrada

- Epidemiológica (casos) + Entomológica (IIP, ovitrampas) + Ambiental (clima, saneamento)
- Articulação intersetorial obrigatória
- Plano de contingência é **municipal** (com apoio estadual/federal)

Pérola

Se a questão pedir "análise mais adequada" em cenário de arboviroses com dados climáticos, a resposta quase sempre envolve **vigilância integrada + articulação intersetorial**.

QUESTÃO 93 ■ Conhecimentos Gerais ■ Conflito de Interesses na Prática Médica ■ Gabarito: B

Um médico de Unidade Básica de Saúde é convidado por um representante de laboratório farmacêutico para participar de um congresso internacional, com todas as despesas custeadas pela empresa. Em troca, o representante pede que o médico passe a prescrever preferencialmente um novo anti-hipertensivo do laboratório, mesmo havendo medicamentos equivalentes disponíveis no SUS. Diante dessa situação, o médico deve

- (A) aceitar o convite e manter sua prática prescritiva habitual, já que congressos são oportunidades legítimas de educação continuada.
- (B) ✓ **recusar o convite, pois aceitar benefícios materiais condicionados à prescrição preferencial viola a independência profissional e o Código de Ética Médica.**
- (C) aceitar, uma vez que a decisão de prescrição permanece sendo do médico e o medicamento tem eficácia comprovada.
- (D) denunciar o representante ao CRM, pois qualquer contato entre médicos e a indústria farmacêutica constitui infração ética.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Embora congressos sejam oportunidades legítimas de educação, este convite está **condicionado a prescrição preferencial** — configurando conflito de interesses. A Resolução CFM 1.595/2000 proíbe vincular prescrição a vantagens materiais.

(B) ✓ **CORRETA.** Aceitar benefícios condicionados a prescrição preferencial viola a Resolução CFM 1.595/2000 e os artigos 68 e 69 do Código de Ética Médica, que protegem a independência profissional. O médico deve recusar qualquer proposta que vincule prescrição a contrapartidas comerciais.

(C) ✗ **INCORRETA.** Mesmo que a eficácia seja comprovada, a **vinculação entre benefício material e prescrição** é antiética. A questão não é a qualidade do medicamento, mas sim a subordinação da autonomia prescritiva a interesses comerciais.

(D) ✗ **INCORRETA.** Nem todo contato entre médicos e indústria é infração ética. A relação é permitida quando não compromete a independência profissional. A infração aqui é a **exigência de contrapartida prescritiva**, não o contato em si.

RESUMO (TLDR)**Conflito de Interesses Médico-Indústria: O Que Realmente Importa?**

O médico deve preservar sua **autonomia prescritiva** acima de qualquer benefício material.

1. O que é proibido?

- Vincular prescrição a vantagens materiais (Resolução CFM nº 1.595/2000)
- Exercer medicina com dependência da indústria (CEM, Art. 68)
- Obter vantagens pela comercialização de medicamentos (CEM, Art. 69)
- Exercício mercantilista da medicina (CEM, Art. 58)

2. O que é permitido?

- Participar de congressos patrocinados **sem** contrapartida prescritiva
- Dialogar com representantes farmacêuticos
- Colaborar em pesquisas clínicas (com aprovação ética)

3. Pérola

Na prova: se houver **vinculação explícita entre benefício e prescrição**, a resposta é sempre **recusar**. E cuidado com o distrator que diz "todo contato é proibido" — isso é exagero e está errado.

QUESTÃO 94 ■ Conhecimentos Gerais ■ Novas Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina (DCN 2025) ■ Gabarito: D

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina, instituídas pela Resolução CNE/CES nº 3, de setembro de 2025, trouxeram diversas inovações à formação médica brasileira. Dentre as mudanças a seguir, qual **NÃO** corresponde a uma determinação das novas DCN de 2025?

- (A) Criação obrigatória do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) para promoção da saúde mental de discentes e docentes.
- (B) Inclusão de competências em inteligência artificial, big data e telemedicina no currículo médico.
- (C) Destinação de pelo menos 30% da carga horária do internato a atividades em Medicina de Família e Comunidade e Urgência/Emergência.
- (D) ✓ **Prazo de cinco anos para as Instituições de Ensino Superior adequarem integralmente seus Projetos Pedagógicos de Curso.**

COMENTÁRIOS

(A) **X ESTÁ NAS DCN 2025** — portanto não é a resposta. O NAPED é uma das inovações centrais das novas DCN, com objetivo de acolhimento psicossocial e promoção da saúde mental de estudantes e docentes.

(B) **X ESTÁ NAS DCN 2025** — portanto não é a resposta. As novas DCN incluem competências em tecnologias emergentes (IA, big data, telemedicina) como parte obrigatória do currículo médico.

(C) **X ESTÁ NAS DCN 2025** — portanto não é a resposta. O internato deve destinar pelo menos 30% de sua carga horária a atividades em MFC e Urgência/Emergência, fortalecendo a formação em atenção primária e emergências.

(D) **✓ NÃO ESTÁ NAS DCN 2025** — esta é a resposta correta. O prazo estabelecido pelas novas DCN é de **2 anos** (não 5) para adequação dos Projetos Pedagógicos. A urgência na implementação é uma das marcas da nova legislação.

RESUMO (TLDR)

DCN de Medicina 2025: O Que Realmente Importa?

As novas DCN (Resolução CNE/CES nº 3/2025) substituem as DCN de 2014 e trazem mudanças estruturais na formação médica brasileira.

1. Principais Inovações

- **NAPED obrigatório:** saúde mental de discentes e docentes
- **Tecnologias emergentes:** IA, big data e telemedicina como competências curriculares
- **Internato:** ≥30% em MFC + Urgência/Emergência
- **Prova nacional:** avaliação abrangente no 4º ano (base do ENAMED)
- **Diversidade:** equidade étnico-racial, de gênero e sustentabilidade como eixos transversais

2. Prazo de Transição

- **2 anos** (até setembro/2027) — NÃO é 5 anos!

3. Pérola de Prova

- Questões sobre DCN 2025 cobram dados numéricos (prazo, percentual do internato) e inovações que não existiam nas DCN 2014 (NAPED, IA, prova nacional)

QUESTÃO 95 ■ Conhecimentos Gerais ■ Bioética Contemporânea ■ Gabarito: B

Homem de 74 anos, portador de câncer gástrico metastático em fase terminal, está internado em enfermaria de cuidados paliativos. Nas últimas semanas, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e não responde a estímulos. O prontuário contém registro de que, há quatro meses, estando lúcido, o paciente declarou ao médico assistente, diante de duas testemunhas, que não desejava ser submetido a intubação orotraqueal ou reanimação cardiopulmonar em caso de parada. A filha do paciente, presente na enfermaria, solicita transferência para UTI e medidas invasivas. A conduta mais adequada da equipe médica é

- (A) atender ao pedido da filha e transferir para UTI, pois a família é representante legal do paciente incapaz.
- (B) **✓ respeitar as diretivas antecipadas de vontade registradas no prontuário, mantendo cuidados paliativos e conforto.**
- (C) solicitar autorização judicial antes de qualquer decisão, pois há conflito entre a vontade registrada e a da família.
- (D) desconsiderar o registro do prontuário por não ter sido feito em cartório e seguir a orientação da família.

COMENTÁRIOS

(A) **X INCORRETA.** Segundo a Resolução CFM 1.995/2012, as diretivas antecipadas de vontade (DAV) do paciente **prevalecem sobre os desejos dos familiares** quando o paciente está incapaz de se expressar. A família não tem poder de decisão que se sobreponha à vontade prévia do paciente.

(B) **✓ CORRETA.** A Resolução CFM 1.995/2012 determina que as DAV registradas em prontuário pelo médico assistente são válidas e prevalecem sobre qualquer parecer não médico, incluindo a vontade da família. A equipe deve manter os cuidados paliativos conforme a vontade do paciente.

(C) **X INCORRETA.** Não é necessária autorização judicial. A Resolução CFM 1.995/2012 já regulamenta as DAV e sua prevalência sobre a vontade familiar. O médico tem respaldo ético e legal para seguir a DAV sem recorrer ao judiciário.

(D) **X INCORRETA.** O registro em cartório NÃO é obrigatório para validade das DAV. O registro em prontuário médico, feito pelo médico assistente, é plenamente válido conforme a Resolução CFM 1.995/2012.

RESUMO (TLDR)

Diretivas Antecipadas de Vontade: O Que Realmente Importa?

As DAV são a expressão da autonomia do paciente sobre cuidados futuros, regulamentadas pela Resolução CFM 1.995/2012.

1. Validade do Registro

- Registro em **prontuário** é válido — cartório **NÃO** é obrigatório
- Paciente deve estar **capaz** no momento da declaração

2. Hierarquia de Decisão

- DAV **prevalece sobre** desejos de familiares (Art. 2º, §3º)
- Família só decide quando **NÃO há** DAV registrada

3. Conflitos Éticos

- Em caso de dúvida → **Comissão de Ética** ou **CRM** (não Judiciário)
- Médico não é obrigado a cumprir DAV que contrarie o CEM

4. Pérola

- Se a prova mencionar "não tem cartório" + DAV em prontuário → a DAV continua válida. É a pegadinha clássica!

QUESTÃO 96 ■ Conhecimentos Gerais ■ Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e CONITEC
■ Gabarito: B

Um médico da Secretaria Municipal de Saúde participa de um grupo de trabalho que avalia a solicitação judicial de um medicamento biológico de alto custo para artrite reumatoide. O medicamento não consta na RENAME, e a CONITEC publicou relatório contrário à sua incorporação, apontando custo elevado sem superioridade clínica em relação ao tratamento já disponível no SUS. Sobre o papel da CONITEC e a avaliação de tecnologias em saúde, é correto afirmar:

- (A) A decisão judicial garante acesso irrestrito a qualquer medicamento, independentemente das análises técnicas da CONITEC.
- (B) ✓ A CONITEC avalia evidências de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário antes de recomendar a incorporação de tecnologias ao SUS.**
- (C) A CONITEC avalia exclusivamente o impacto orçamentário, sem analisar evidências clínicas de eficácia e segurança.
- (D) Decisões judiciais obrigam a incorporação imediata do medicamento à RENAME, sobrepondo-se automaticamente aos pareceres da CONITEC.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ INCORRETA. O direito à saúde não garante acesso irrestrito a qualquer tecnologia. O STF firmou entendimento de que decisões judiciais devem considerar a existência de alternativas terapêuticas no SUS e as avaliações técnicas da CONITEC.

(B) ✓ CORRETA. A CONITEC (Lei 12.401/2011) realiza Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) considerando múltiplos critérios: evidências de eficácia e segurança, custo-efetividade (medida pela RCEI), impacto orçamentário e consulta pública. Não se restringe apenas ao custo.

(C) ✗ INCORRETA. A CONITEC tem competência ampla: avalia evidências clínicas de eficácia e segurança, além do custo-efetividade e impacto orçamentário. A análise de evidências clínicas é parte central de seu trabalho, não restrita à Anvisa.

(D) ✗ INCORRETA. A Lei 12.401/2011 não estabelece que decisões judiciais se sobreponham automaticamente à CONITEC. A judicialização não obriga a incorporação na RENAME — são processos distintos.

RESUMO (TLDR)

ATS e CONITEC: O Que Realmente Importa?

A incorporação de tecnologias no SUS segue um processo técnico-científico regulado pela Lei 12.401/2011.

1. O Que a CONITEC Avalia?

- Eficácia e efetividade (evidência clínica)
- Segurança
- Custo-efetividade (RCEI, QALY)
- Impacto orçamentário
- Consulta pública obrigatória

2. Conceitos Econômicos Essenciais

- **RCEI** = $\Delta\text{Custo} \div \Delta\text{Efetividade} \rightarrow$ quanto custa a mais para cada QALY ganho
- **QALY** = ano de vida ajustado por qualidade (combina sobrevida + qualidade)
- Análise é sempre **comparativa** (nova tecnologia vs. tratamento disponível)

3. Judicialização

- Obriga fornecimento **individual**, NÃO altera a RENAME
- Gera tensão entre direito individual e sustentabilidade do sistema
- STF tem valorizado pareceres técnicos da CONITEC

4. Pérola

CONITEC $\neq$ ANVISA: a ANVISA **registra** (autoriza comercialização); a CONITEC decide se o SUS vai **pagar**.

QUESTÃO 97 ■ Conhecimentos Gerais ■ Desinformação e Saúde Pública ■ Gabarito: B

Uma médica da Estratégia Saúde da Família observa queda na cobertura vacinal da pentavalente em crianças de sua área, de 89% para 71% em 12 meses. Na busca ativa, identifica que a maioria das famílias relata ter visto vídeos em redes sociais afirmando que vacinas causam autismo e contêm substâncias tóxicas. A estratégia mais adequada para enfrentar essa situação é

- (A) distribuir panfletos com dados estatísticos sobre segurança vacinal e acionar o Conselho Tutelar para notificar as famílias que recusaram vacinar seus filhos.
- (B) ✓ **promover rodas de conversa com escuta qualificada das famílias, fornecer informações baseadas em evidências e articular ações com escolas e lideranças comunitárias.**
- (C) encaminhar denúncia ao Ministério Público contra os responsáveis pela desinformação e manter apenas oferta passiva de vacinas na unidade.
- (D) solicitar contratação de profissional de comunicação para redes sociais e adiar a busca ativa até que o material digital esteja pronto.

COMENTÁRIOS

(A) ✗ **INCORRETA.** Panfletos com dados estatísticos isolados raramente superam a desconfiança gerada por desinformação. Além disso, acionar o Conselho Tutelar como primeira medida é punitivo e pode aumentar a resistência das famílias em vez de promover adesão.

(B) ✓ **CORRETA.** A abordagem recomendada para hesitação vacinal combina: (1) escuta qualificada dos receios, (2) informação baseada em evidências com linguagem acessível, e (3) articulação comunitária (escolas, líderes, ACS). É a estratégia mais efetiva e alinhada aos princípios da APS.

(C) ✗ **INCORRETA.** Denúncia ao MP pode ser complementar, mas não é a estratégia principal. Manter apenas oferta passiva é insuficiente — a busca ativa e a abordagem comunitária são essenciais na ESF.

(D) ✗ **INCORRETA.** Adiar a busca ativa é inadmissível com cobertura vacinal em queda. Material digital pode complementar, mas a ação presencial comunitária é prioritária na APS.

RESUMO (TLDR)

Hesitação Vacinal e Fake News: O Que Realmente Importa?

A hesitação vacinal é uma das 10 maiores ameaças à saúde global (OMS, 2019) e resulta de múltiplos fatores, não apenas "falta de informação".

1. Modelo dos 3 Cs (OMS)

- **Confiança:** nas vacinas e no sistema de saúde
- **Complacência:** percepção de baixo risco da doença
- **Conveniência:** facilidade de acesso ao serviço

2. O que Funciona no Enfrentamento

- Escuta qualificada sem julgamento
- Comunicação empática, bidirecional, com linguagem acessível
- Articulação intersetorial (escolas, lideranças, ACS)
- Busca ativa contínua

3. O que NÃO Funciona

- Panfletos sem diálogo (comunicação unidirecional)
- Abordagem punitiva como primeira medida
- Postura passiva (esperar a família vir ao posto)
- Adiar ações por falta de recursos ideais

Pérola

Na prova, a resposta certa para hesitação vacinal sempre combina **escuta + evidências + comunidade**. Nunca é punição nem passividade.

QUESTÃO 98 ■ Conhecimentos Gerais ■ Telemedicina e Telessaúde ■ Gabarito: A

Médica de família atua em UBS no interior da Amazônia, com comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Um paciente de 62 anos, hipertenso e diabético, mora a seis horas de barco da UBS e solicita teleconsulta para renovação de receitas e ajuste de medicamentos. A médica nunca o atendeu presencialmente. Segundo a legislação brasileira vigente (Lei 14.510/2022), a conduta correta é

(A) ✓ realizar a teleconsulta, obtendo consentimento informado do paciente, registrando o atendimento em prontuário e garantindo o direito a atendimento presencial se ele preferir.

(B) recusar a teleconsulta, pois a lei exige que o primeiro contato médico-paciente seja obrigatoriamente presencial.

(C) realizar a teleconsulta apenas para orientações gerais, sem poder emitir receitas, pois atos prescritivos são vedados na primeira consulta por telessaúde.

(D) solicitar que o paciente se desloque até a UBS para consulta presencial inicial e, somente após, autorizar teleconsultas.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. A Lei 14.510/2022 permite a teleconsulta inclusive como primeiro atendimento, dando ao profissional autonomia para decidir pela telessaúde. Os requisitos são: consentimento livre e informado, registro em prontuário e garantia de atendimento presencial se o paciente preferir.

(B) ✗ INCORRETA. A Lei 14.510/2022 NÃO exige consulta presencial prévia. O profissional tem autonomia para utilizar telessaúde desde a primeira consulta, conforme Art. 26-C.

(C) ✗ INCORRETA. A Lei 14.510/2022 permite todos os atos médicos via telessaúde, incluindo prescrição de medicamentos e emissão de atestados. Não há restrição a atos prescritivos na primeira teleconsulta.

(D) ✗ INCORRETA. Exigir deslocamento presencial prévio não é obrigatório pela legislação e seria desproporcional neste contexto (6 horas de barco). A lei garante flexibilidade justamente para populações de difícil acesso.

RESUMO (TLDR)

Telessaúde no Brasil: O Que Realmente Importa?

A Lei 14.510/2022 tornou a telessaúde **permanente** no Brasil (não é mais exceção pandêmica).

1. Princípios Fundamentais

- **Autonomia profissional:** o profissional decide se usa telessaúde, inclusive na 1ª consulta
- **Consentimento:** livre e informado, obrigatório
- **Direito de recusa:** paciente pode exigir presencial a qualquer momento
- **Confidencialidade:** LGPD e Marco Civil da Internet

2. O que Pode Fazer por Telessaúde

- Teleconsulta (inclusive primeira)
- Prescrição e atestados (com assinatura eletrônica)
- Teleinterconsulta, telemonitoramento, teletriagem, telediagnóstico

3. Pérola

- Primeira consulta presencial **NÃO** é obrigatória — quem decide é o profissional, não a lei

QUESTÃO 99 ■ Conhecimentos Gerais ■ Cuidados Paliativos e Fim de Vida ■ Gabarito: A

Um homem de 68 anos, com câncer de pâncreas metastático em cuidados paliativos exclusivos, encontra-se lúcido e orientado. Em consulta, manifesta ao médico de família que não deseja ser submetido a reanimação cardiopulmonar ou intubação, pedindo que essa vontade seja registrada. A agente comunitária de saúde questiona se o médico pode simplesmente registrar isso no prontuário ou se seria necessário um documento em cartório. Sobre essa situação, é correto afirmar:

(A) ✓ O registro em prontuário médico é válido conforme a Resolução CFM 1.995/2012, e a limitação de procedimentos em fase terminal é respaldada pela Resolução CFM 1.805/2006 como ortotanásia.

(B) A limitação de procedimentos em fase terminal exige autorização judicial prévia, pois resoluções do CFM não possuem força de lei.

(C) As diretivas antecipadas de vontade somente são válidas quando registradas em cartório por escritura pública.

(D) A suspensão de tratamentos que prolonguem a vida em fase terminal configura eutanásia passiva, conduta vedada no Brasil.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. A Resolução CFM 1.995/2012 valida o registro de DAV em prontuário médico (cartório não é obrigatório). A limitação de procedimentos em doença terminal é ortotanásia, regulamentada pela Resolução CFM 1.805/2006, declarada constitucional em 2010.

(B) ✗ INCORRETA. Não é necessária autorização judicial. As resoluções do CFM regulamentam a prática médica e a Resolução 1.805/2006 foi considerada constitucional pela Justiça Federal em 2010. O médico tem respaldo ético e legal para atuar conforme as DAV.

(C) ✗ INCORRETA. O registro em cartório NÃO é obrigatório. A Resolução CFM 1.995/2012 aceita o registro em prontuário feito pelo médico assistente como válido para as DAV.

(D) ✗ INCORRETA. Ortotanásia (limitar tratamentos fúteis em fase terminal) é diferente de eutanásia (provocar a morte ativamente). A ortotanásia é permitida no Brasil (Res. CFM 1.805/2006). A eutanásia é que é vedada.

RESUMO (TLDR)

Legislação de Cuidados Paliativos: O Que Realmente Importa?

No Brasil, a ortotanásia e as DAV são reguladas por resoluções do CFM, não por lei ordinária específica.

1. Resolução CFM 1.805/2006 (Ortotanásia)

- Permite limitar/suspender tratamentos em fase terminal
- Condições: doença grave e incurável + consentimento + manutenção de cuidados paliativos
- Declarada constitucional em 2010 (não é crime)

2. Resolução CFM 1.995/2012 (DAV)

- Registro em **prontuário médico** é suficiente (cartório é facultativo)
- Paciente lúcido, maior de 18 anos
- Pode ser revogada a qualquer momento
- Prevalece sobre vontade da família

3. Complementos Normativos

- Lei nº 14.238/2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer): reforça autonomia e acesso a cuidados paliativos
- Resolução CFM nº 2.381/2024: atualizações em cuidados paliativos oncológicos

4. Pérola

- Ortotanásia ≠ eutanásia: *"Orto = correto. Morte no tempo certo, sem sofrimento desproporcional."*
- DAV no prontuário = válida. Não precisa de cartório!

QUESTÃO 100 ■ Conhecimentos Gerais ■ Globalização, Pandemias e Governança Sanitária ■ Gabarito: A

Durante a pandemia de COVID-19, países de baixa e média renda tiveram acesso tardio a vacinas, mesmo após a declaração de emergência pela OMS. Para enfrentar essa desigualdade, a OMS coordenou a elaboração de um Acordo Pandêmico, aprovado em 2025. A principal inovação desse tratado, em comparação ao Regulamento Sanitário Internacional (RSI) já existente, é

(A) ✓ a criação de mecanismos legais vinculantes para equidade no acesso a vacinas e insumos, incluindo a obrigação de fabricantes disponibilizarem até 20% da produção à OMS em tempo real durante pandemias.

(B) a substituição integral do RSI por um novo instrumento que centraliza na OMS a autoridade exclusiva sobre todas as emergências sanitárias nacionais.

(C) a criação de um fundo obrigatório do Banco Mundial destinado exclusivamente à compra de vacinas, sem participação da OMS.

(D) a exigência de que cada país produza localmente 100% das vacinas necessárias, eliminando a cooperação internacional.

COMENTÁRIOS

(A) ✓ CORRETA. O Acordo Pandêmico de 2025 inova ao criar o sistema PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing), com obrigações contratuais vinculantes: fabricantes que acessam patógenos compartilhados devem disponibilizar até 20% da produção de contramedidas à OMS. Essa é a grande diferença em relação ao RSI, que não tem mecanismos obrigatórios de compartilhamento.

(B) ✗ INCORRETA. O Acordo Pandêmico **complementa** o RSI, não o substitui. O RSI continua em vigor para vigilância e notificação. Além disso, a OMS não centraliza autoridade exclusiva sobre emergências nacionais — a soberania dos Estados é preservada.

(C) ✗ INCORRETA. O fundo previsto no Acordo Pandêmico é coordenado pela OMS (não pelo Banco Mundial) e não se destina exclusivamente à compra de vacinas — abrange diagnósticos, terapêuticos e fortalecimento de capacidades.

(D) ✗ INCORRETA. O acordo promove transferência de tecnologia e produção regional, mas não exige autossuficiência de 100%. A cooperação internacional é justamente o pilar do tratado.

RESUMO (TLDR)

Acordo Pandêmico da OMS: O Que Realmente Importa?

A COVID-19 mostrou que mecanismos voluntários (como o COVAX) são insuficientes para garantir acesso equitativo a vacinas.

1. RSI (2005) — O Que Já Existia

- Foco: vigilância, notificação, resposta coordenada
- Mecanismo: declaração de ESPII pelo Diretor-Geral da OMS
- Lacuna: **nenhuma** obrigação de compartilhamento de vacinas/insumos

2. Acordo Pandêmico (2025) — O Que Mudou

- Foco: **equidade no acesso** a contramedidas médicas
- Mecanismos vinculantes:
- **20% da produção** à OMS para distribuição equitativa
- **Sistema PABS**: compartilhar patógeno = compartilhar benefício
- **Transferência de tecnologia** (Artigos 10-13)
- Complementa o RSI (não substitui)

3. Pérola de Prova

- RSI = Vigilância e Notificação
- Acordo Pandêmico = Equidade e Acesso
- Os dois coexistem e são complementares